

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica del Grupo Familiar

AÑO XIII Nº 20 — 1990

20

TERAPIAS DE PAREJA

Editor

Psic. Alberto González

PRESENTACIÓN	7
NUEVAS APORTACIONES AL PSICOANÁLISIS DE PAREJA Y DE FAMILIA	9
Isidoro Berenstein - Janine Puget	
TRATAMIENTO DE LAS DISFUNCIONES PSICOSEXUALES EN EL CONTEXTO DE LA TERAPIA MARITAL	21
Dra. Ilda V. Ficher	
CONTRATOS MARITALES Y CREENCIAS EN TERAPIA DE PAREJA	37
Psic. Alberto González	
LA PAREJA Y SUS ESCENAS	53
Carlos María y María C. Martínez Bouquet	
LOS CELOS. UN EJERCICIO EN CONSTRUCTIVISMO SISTÉMICO	81
Dr. Carlos E. Sluzki	
COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS	89
Varios autores	

TERAPIAS DE PAREJA

Editor

Psic. Alberto González

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica del Grupo Familiar

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Asistente de Dirección

Lic. Inés Dates

AÑO XIII Nº 20 — 1990

Coordinadora General

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk

Consejo de Redacción

Maurizio Andolfi (Roma)
Isidoro Berenstein (Buenos Aires)
Rodolfo de Bernart (Florencia)
Donald Bloch (New York)
Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)
Ives Colas (Lyon)
Alberto Eiguer (Bs. As. - París)
Craig A. Everett (Florida)
Jorge García Badaracco (Bs. As.)
Florence Kaslow (West Palm Beach
Florida)
Raymundo Macías (México)
Juan C. Nocetti (Buenos Aires)
Reynaldo Perrone (Rosario -
Argentina, St. Etienne - Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)
Jacques Rudrauf + (París)
Alberto Serrano (Buenos Aires -
Filadelfia)
Mara Selvini Palazzoli (Milán)
Robin Skynner (Londres)
Carlos Sluzki (Bs. As., Berkshire
Massachusetts)
Helm Stierlin (Heidelberg)
Guillermo Vidal (Buenos Aires)
Gerald Zuk (Nueva Orleans)
Israel Zwerling (Filadelfia)
Lyman Wynne (Rochester - USA)
Mony Elkaïm (Bruselas - Bélgica)
Luigi Cancrini (Roma - Italia)

Comité de Redacción

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk
Lic. Inés Dates
Dr. Carlos Díaz Usandivaras
Dr. Fernández Moya (Mendoza)

Dr. Lino Guevara (Neuquén)
Lic. Sara B. Jutoran
Dres. Fidel y Elena Lebensohn
(Rosario)
Dr. Rafael Skiadaressis

Director Honorario
Alberto Cattán

TERAPIA FAMILIAR es una publicación semestral de Ediciones A.C.E., Casilla de Correo 94, Suc. 28, Buenos Aires, Argentina.

Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor.

Nombre de la Revista registrado como marca.

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nro. 332.195.

Registro Internacional de Publicaciones Científicas. ISSN 03215-5905

Indice

PRESENTACIÓN	7
NUEVAS APORTACIONES AL PSICOANÁLISIS DE PAREJA Y DE FAMILIA	9
Isidoro Berenstein - Janine Puget	
TRATAMIENTO DE LAS DISFUNCIONES PSICOSEXUALES EN EL CONTEXTO DE LA TERAPIA MARITAL	21
Dra. Ilda V. Ficher	
CONTRATOS MARITALES Y CREENCIAS EN TERAPIA DE PAREJA	37
Psic. Alberto González	
LA PAREJA Y SUS ESCENAS	53
Carlos María y María C. Martínez Bouquet	
LOS CELOS. UN EJERCICIO EN CONSTRUCTIVISMO SISTÉMICO	81
Dr. Carlos E. Sluzki	
COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS	89
Varios autores	

Presentación

El presente número ha sido diseñado a fin de brindar una vista panorámica de diferentes modelos en el campo de la terapia de pareja.

La mayoría de los artículos son inéditos o prácticamente inéditos. Estas contribuciones tienen —entre otros— el mérito de un esfuerzo personal significativo y el reconocimiento a esta publicación que ha cumplido once años.

Sin pretender agotar todos los modelos posibles en el campo de la terapia de pareja (que puede dar lugar a publicaciones futuras) nuestra intención ha sido contribuir a explicitar teorías, modelos e hipótesis que permiten un abordaje de los fenómenos clínicos presentados por las parejas.

Es posible que investigaciones comparativas entre diferentes modelos, puedan arrojar una mayor precisión sobre la eficacia terapéutica de los abordajes que de aquellos se desprenden. Considero que en nuestro medio no es fácil acceder a investigaciones de este tipo y quizá aun sea el momento de incentivar y estimular el desarrollo de diferentes líneas en la búsqueda de su propia coherencia, sistematización y aplicación. Algo así, como un saludable refrescante pluralismo científico.

Cabe hacer una breve referencia al contexto social donde nos movemos terapeutas y parejas. Entiendo que estudios interdisciplinarios permitirán saber más sobre las transformaciones que experimentan las familias y parejas dentro de los procesos sociales. Muy especialmente en los medios urbanos en donde la familia nuclear se ha constituido en una micro estructura de alta complejidad, inserta en un contexto caracterizado por un alto nivel de expectativas con respecto a los comportamientos de esta entidad (Cambios: las redes familiares, transformaciones de la familia extensa, socioeconómicos, tecnológicos, etc.); al mismo tiempo que las personas construyen un elevado nivel de expectativas tanto en su realización individual, como en el ámbito de su relación de pareja.

La entidad pareja es así un punto de intersección y en cierta medida de caja de resonancia de las vibraciones y desequilibrios del medio social. Este choque o colisión entre necesidades básicas y fundamentales de las personas y las transformaciones, es parte, a mi entender, de una trama social dentro de la cual las disfunciones pueden amplificarse.

Los aportes aquí presentados en el presente número no aspiran a desentrañar todos los interrogantes, sino contribuir al conocimiento e intervención sobre la trama íntima de las relaciones de pareja.

Nuevas aportaciones al psicoanálisis de pareja y de familia

ISIDORO BERENSTEIN

Miembro titular de A.A.P.P. de G. y de A.P. de B.A.
República de la India 2921, 9º A. 1425. Buenos Aires. Argentina.

JANINE PUGET

Miembro Fundador de A.A.P.P. de G. y Miembro Titular de A.P. de B.A.
Paraguay 2475, 1121. Buenos Aires. Argentina.

Este trabajo es una ampliación de "Psicoanálisis de Pareja y Familia" presentado en el Congreso Psicoanalítico de Roma (1989)

1. INTRODUCCION

La cuestión del psicoanálisis de pareja y familia nos lleva de inmediato a interrogarnos acerca de quién es el paciente y definir quién es el objeto del tratamiento.

Por lo general se equipara el paciente a una sola persona y no hay dificultad en tanto se trate de la sesión bipersonal. Nuestro trabajo con pareja, familia y grupo, nos llevó a extender el concepto de paciente a una estructura bi o multipersonal.

En un comienzo los analistas intentaron hacer una aplicación directa de la teoría a este nuevo campo y aunque ello significó un adelanto, resultó de un alcance limitado. Nos fuimos dando cuenta que la teoría psicoanalítica formulada para los fenómenos del mundo psíquico no abarcaba la nueva estructura. El psicoanálisis mismo considerado como una teoría bipersonal pasó

por varias ampliaciones y a su vez recurrió a modificaciones de su encuadre.

Una primera fue la que acompañó la regla de la asociación libre, la segunda fue la introducción de la técnica del juego para el análisis de niños. Nuestro trabajo pertenece a una tercera modificación técnica: atender a dos o más miembros constitutivos de una estructura vincular sean éstos una pareja, una familia o un grupo. En este trabajo solo nos referiremos a familia y pareja.

Si se recuerda, cada historial clínico de Freud está estructurado de manera tal de relatar cómo fue la estructura representacional del mundo psíquico, tomando en cuenta tanto el mundo infantil como la vida familiar de los pacientes. Incluye también menciones del tipo de sociedad en la cual vivían los pacientes o el tipo de educación recibida o a la relación con el medio socio-cultural, sin que necesariamente haya sido esto último tan sistemáticamente trabajado por Freud. Sin entrar en más detalles se pueden recordar los aportes de Freud, como de otros autores que le siguieron, acerca del mundo infantil, del medio familiar y del marco socio-cultural que rodeó a Dora, al Hombre de las Ratas, al Hombre de los Lobos al magistrado Schreber y a cada uno de los pacientes de los historiales.

Llamamos aplicación al uso del psicoanálisis para entender producciones artísticas, literarias, históricas o de otro tipo a los que se intenta comprender pero no modificar: no asocia libremente ni responde a las interpretaciones. Es un campo del cual no se espera transformación por el tipo de comprensión que aporta la teoría psicoanalítica. Para este campo queda reservada una de las definiciones que dio Freud del psicoanálisis en tanto teoría y no como método.

Llamaremos en cambio ampliaciones a todo tipo de desarrollo que proviene de la

relación con un paciente, tomando este concepto tal como acabamos de definirlo. El paciente es susceptible de pensar y hablar en la sesión, de recibir interpretaciones y de responder a las mismas generando entonces material, claro está, diferente en cada caso.

El enfoque que damos a este tema lleva a puntualizar nuevas formulaciones para algunos conceptos básicos definitorios del psicoanálisis.

2. DEFINICION DE CONCEPTOS

a) Estructura vincular

Hablaremos de estructura vincular dándole un matiz si se quiere histórico ligado a la historia de estas ideas en psicoanálisis. En un primer momento lo psíquico fue estructura del aparato psíquico concebido inicialmente sobre un modelo derivado de la mecánica y las leyes de la termodinámica. (Freud, 1895 y 1899 [1900]). Este aparato fue constituido para dar cabida a una primera definición de inconsciente. En ella el elemento fundante son las representaciones y éstas son registros de experiencias primitivas a los que se supone ligada la pulsión (Triebrepresentanz). No nos extendemos en esto porque es tema conocido y muy debatido por los psicoanalistas. Esta conceptualización abarcó desde 1900 hasta 1920 con un momento particularmente importante en 1915 con el trabajo "Lo inconsciente".

Después de 1920, sobrevino la reformulación del aparato psíquico en términos de instancias: Ello, Yo y Superyo. Este cambio se profundizó aún más con los aportes de Melanie Klein de los cuales jerarquizaremos, a los efectos de este traba-

jo, el concepto de relación de objeto. De estructura del aparato psíquico, pasó a considerarse y hablarse en términos de mundo interno caracterizado por las relaciones de objeto, cuya descripción fue oscilando desde un carácter si se quiere antropomórfico hasta otras conceptualizaciones que le dan una configuración surrealista. Los sujetos están representados en ese mundo interno por objetos que tienen una vida propia, entre los cuales se cuentan partes del Yo, partes del cuerpo del bebé, de la madre, del padre, como trozos —objetos parciales— o como objeto total cuando se representa con una tonalidad afectiva compleja y variados sentimientos vinculados a amor y a odio. Deseáramos señalar que el objeto externo no recibió igual dedicación y estudio. Desde ya es mencionado en los escritos psicoanalíticos, pero en general como una investidura de la relación de objeto interno.

Llamamos vincular a una estructura semejante y diferente a las anteriores, si bien las contiene pero con una diferencia metapsicológica que se deriva del hecho de la existencia de dos objetos reales externos. Los llamaremos el Yo y el Otro o los dos Yoes. El elemento definitorio es la relación de exterioridad, porque cada uno de estos Yoes tiene para el otro tanto un sector asimilable como y principalmente un sector no asimilable al propio Yo y sobre lo cual se constituye la noción de ajenidad. Llamamos vínculo a la relación de un Yo con otro que mantiene una relación de ajenidad. Si bien el término vínculo como otros usados proviene del lenguaje coloquial, adquiere un status metapsicológico definitorio del mundo intersubjetivo de pareja y familia. Se diferencia decididamente del término relación de objeto al cual hacemos definitorio del mundo interno.

Desde el concepto de relación de obje-

to, el otro se va perfilando como tal en la medida en que pueda ser aceptado, y que el Yo además de ser capaz de transformar las propias proyecciones fantasmáticas pueda admitir en el otro las suyas. En el vínculo, el otro se impone de entrada y define la existencia del mundo interfantasmático. Esta es la razón de ser de los acuerdos y de los pactos que llamamos inconscientes como se verá en el párrafo siguiente. Este concepto no tendría lugar en la relación de objeto. En ella sólo impera el deseo del Yo invistiendo al objeto o haciendo operaciones con el objeto, o, si las proyecta, en los distintos grados de identificación cuando las asimila al objeto, o el objeto hace operaciones con el Yo.

Se desprende de lo anteriormente dicho que este enfoque lleva —aunque no es objeto de este trabajo— a una reformulación de la noción de mundo externo en psicoanálisis.

Discriminamos dentro del aparato psíquico localizaciones a las cuales hemos llamado espacios, donde se inscribirían representaciones propias. Llamamos a estos espacios intra, inter y transubjetivos (Puget, 1988).

Para el primero, el espacio intrasubjetivo, tanto representación como relación de objeto son definitorias. Su motor emocional deriva de la pulsión —como ha sido empleado clásicamente en psicoanálisis— y es característico del mundo interno. Relación de objeto supone una direccionalidad donde el significado es principalmente interno y desde allí reviste el mundo de los otros.

Para el espacio intersubjetivo que define el marco de la relación entre los Yoes, lo paradigmático es la noción de vínculo que contiene y subsume la noción de pulsión. Lo definitorio es la noción de constancia y

presencia permanente de los Yoes de la estructura familiar y de pareja. Decir presencia constante tiene que entenderse desde el punto de vista de los lugares y de los nombres que tienen estos lugares. El significado es intersubjetivo y desde allí supone una direccionalidad hacia el mundo externo.

El tercer espacio, el transubjetivo, contiene las representaciones del Yo con el mundo socio-cultural. Define la relación con el mundo exterior y el significado se impone tanto al mundo vincular como al interno.

Es coincidente con aquello mencionado por Freud en "Psicología de las Masas" cuando hablaba de las tres fuentes de sufrimiento del sujeto humano; el referido al cuerpo, por lo tanto a lo somático, el producido por las interrelaciones, y el tercero producido por el mundo circundante.

b) Inconsciente: acuerdos y pactos

Por lo general inconsciente incluye la idea de una localización sistemática en el aparato psíquico cuyo contenido son las huellas mnémicas pensadas como representantes de pulsiones investidas de una energía dada y organizadas en relaciones de complejidad creciente: simultaneidad, sucesividad, relación causal, representación por palabra. Estas representaciones tienen una tendencia teleológica de retornar a la conciencia, movimiento impedido por la represión. En una estructura vincular el inconsciente es la representación de lugares y funciones y seis reglas de correlación; porque a las anteriores agregamos las de oposición y correlación.

En psicoanálisis fue importante el pasaje de una conceptualización en base a modelos de orden neurológico y biológico a la

conceptualización de objeto utilizado por Freud con quien adquirió un mayor status científico. El concepto de organización vincular, en este caso de familia y pareja, incluye la idea de una estructura que vive en un constante proceso de complejización. En él interviene la permanencia de una zona o un funcionar inconsciente basado en el por qué se elige un vínculo dado y en el cómo va adquiriendo diferente semantización en función de la organización vincular. Consta de un sector para siempre inconsciente, por lo tanto, factible de ser semantizado al infinito. Es la condición de aquello no transformable en la función parental referido a la cualidad hijo de cada uno de los padres que no desaparecerá nunca, si bien irá sufriendo distintas transformaciones: seguir siendo hijo a través de su propio hijo. Desde el hijo, en el vínculo con los padres, lo que quedará para siempre inconsciente es aquel otro hijo que hubiera podido ser en otra organización vincular o con otros padres. Es lo que los hijos plantean en lo manifiesto cuando desde su lugar se preguntan qué hubiera pasado si hubieran sido hijos de otros padres.

El vínculo anteriormente mencionado de los padres en tanto hijos de sus propios padres introduce el concepto de transmisión inconsciente transgeneracional en la estructura vincular.

En el vínculo de pareja consideramos imposible hacer totalmente consciente el por qué se eligieron y qué vínculo hubiera podido desplegarse en caso de haber realizado otra elección.

En distintos momentos de la evolución de un tratamiento se irán encontrando nuevos significados a la elección sin alcanzar nunca la motivación originaria. El momento constitutivo por definición se pierde para siempre y queda en su lugar una serie de

relatos hechos a posteriori con carácter de mito constitutivo al cual la pareja recurre cuando necesita decirse por qué se eligieron. Esta formulación nos lleva a suponer entre ambos miembros de una pareja la existencia de un acuerdo inconsciente que conserva esta determinada organización y elección, lugar investido de repetición. Si postulamos que nunca podrá hacerse consciente el por qué de la elección, es dable suponer que pueda disolverse el pacto inicial fundante mientras se mantenga tal cual ese vínculo.

La mayor complejidad de una estructura familiar se debe a la existencia simultánea de diferentes tipos de acuerdos. Uno sellan la relación entre dos conjuntos ajenos: el de cada uno de los miembros de la pareja, y otro proveniente del vínculo consanguíneo que describimos como la relación padres-hijos. La simultaneidad de posiciones y funciones para cada uno de los miembros de la familia da origen a la complejidad de las relaciones que en ella se encuentran.

c) Narcisismo

Este concepto ha tenido múltiples significaciones en la literatura psicoanalítica. Para nosotros el narcisismo es concebido como dando origen a una estructura en la cual la organización libidinal circulará en forma tal que pueda crear la ilusión de una vivencia permanente ligada al placer excluyendo la frustración. En lo que respecta a nuestro tema estudiamos la especificidad del narcisismo a la luz de la teoría de los espacios psíquicos a los cuales hemos llamado intrasubjetivo, inter y transubjetivos.

El momento constituyente de cada uno puede ser discernido de la siguiente mane-

ra. En el espacio intrasubjetivo el narcisismo fundante se relaciona con la erotización del cuerpo erógeno y sus representaciones de objeto, definido como relación intrapsíquica. En el espacio intersubjetivo retomaremos un concepto ya creado por nosotros y que hemos llamado Estructura Relacional originaria del Objeto Unico (1988), donde es fundante un vínculo asimétrico en el que ambos polos se sujetan a la ilusión de la posibilidad de una complementariedad perfecta¹ (Puget, Berenstein, 1986, 1988). En el tercer espacio, el espacio transubjetivo, el momento fundante es también de complementariedad perfecta en el que el Yo moldeado por la estructura social habrá de contar permanentemente con ésta.

Veamos ahora someramente qué sucede en estos tres espacios en la estructura de pareja o de alianza y en la estructura familiar. Una dificultad surge de que para su constitución no se produce necesariamente una conjugación y reformulación de los tres espacios. En lo que al vínculo de pareja se refiere, el espacio originariamente puesto en juego en el enamoramiento fundante de la pareja, es la ilusión de recuperar en forma compartida el funcionamiento de Objeto Unico. Secundariamente y en función del enamoramiento es probable que el espacio intrasubjetivo de cada uno, ligado a las relaciones de objeto como construcción altamente singular, pueda sufrir modificaciones favorables o desfavorables. En el primer caso referidas a la alimentación y el reaseguramiento objetal, y en el segundo constituyéndose en falla o lesión de ese mundo objetal. La inserción social, que dio lugar al narcisismo que hemos llamado fundante del espacio transubjetivo, puede ser incorporada a la organización vincular de pareja y quedar negadas o desmentidas las diferencias no comparti-

bles basadas en experiencias in-compartibles.

El esfuerzo por vincularizar estas pertenencias originales lleva a conflictos a menudo irresolubles. Podemos retomar un concepto muy conocido tanto en los dichos populares como en la antropología, así como en algunas formulaciones psicoanalíticas en cuanto que la relación de pareja contiene una fragilidad implícita reemplazada por algo que ya no se disuelve con la constitución del hijo. El hijo sella la pareja al transformarla en pareja parental. La pareja matrimonial puede separarse, no así la pareja de padres. Probablemente la fragilidad de la pareja se deba a que para su creación tan solo es necesaria la reorganización del narcisismo originario de cada uno, el cual se intenta de recuperar a través del enamoramiento. Pueden crear un vínculo sin tener que reorganizar ni el espacio intrasubjetivo ni el espacio transubjetivo. El enamoramiento implica una renuncia al vínculo originario para dar lugar a una complementariedad que ya no será perfecta y nunca podrá serlo con un otro real externo. Esto es vivido como un límite a la capacidad alucinatoria y a ello probablemente se deba la precariedad del vínculo. Esta se acentúa con el advenimiento del hijo, lo cual actualiza la siguiente cuestión acerca de la preminencia. Si el narcisismo es la carga libidinal del cuerpo que inviste a los objetos del mundo exterior (Narcisismo primario) como lo formulara Freud en Introducción al Narcisismo, sugerimos la posibilidad de repensar la direccionalidad del narcisismo, ya que consideramos que el sujeto se constituye a partir de las representaciones que los otros se hagan de él.

Como ejemplo veamos la cuestión del nombre propio. Este espera al Yo que ha de sostenerlo a veces un tiempo corto o muy

largo. La espera anterior a la constitución de otras condiciones referidas al lugar del tercero. El niño, el bebé, se acomodará al nombre propio y a todos los significados en él incluidos. Merced a sus disposiciones tiene alguna posibilidad de modificación de la investidura narcisista, de los ideales y de la representación del Yo.

En la estructura familiar la constitución de un hijo real o simbólico puede transformarse en síntoma al hacer aparecer la falla en la vincularización debida a las dificultades de la pareja derivadas de sus diferentes inserciones sociales infantiles.

El momento fundante de la familia lo encontraremos en este estado de elación en el cual una pareja conjuga su deseo de hijos y decide realizar ese proyecto. Esto quiebra la organización vincular sostén de la pareja hasta ese momento, en la que se ilusionaban con la complementariedad perfecta. Al crearse una familia e incorporarse nuevas funciones o nuevos lugares se asiste a una pérdida momentáneamente de los lugares anteriores.

En cuanto al espacio intrasubjetivo, a nivel objetal suceden cuestiones diferentes para la mujer y para el varón. Para la mujer en función del descubrimiento de su capacidad genitora y la transformación corporal vivida adentro de su propio cuerpo y para el hombre porque ha de volcarse proyectivamente en el cuerpo de la mujer para compartir una vivencia corporal de modificación en función de su capacidad genitora. El hombre necesitará mayor capacidad simbólica para que el embarazo le produzca una pertenencia corporal semejante a la producida en la mujer.

La formulación de un narcisismo fundante de cada uno de los espacios lo acerca al concepto de inconsciente ya que podríamos considerar que estos funciona-

mientos originarios nunca podrán hacerse concientes en toda su complejidad. Ubicaremos estas representaciones como aquellas que por excelencia constituyen el inconsciente.

d) Complejo de Edipo

Sólo consideraremos el Complejo de Edipo desde el punto de vista de la amenaza de castración, de la institución de la prohibición en la creación de la estructura de pareja y de familia así como también del por qué y el sentido de la elección mutua.

La pareja y la familia son conjuntos de lugares a los cuales se adviene como una evolución de la masculinidad y femineidad. En ese sentido el hombre adviene marido por la conjunción de serle dado un lugar y posesionarse e invertir ese lugar. Lo mismo para la mujer en el lugar de esposa. Estos a su vez advienen padre y madre, nombres de lugares de parentesco dados por la cultura. Pero conviene distinguir el serle dado un lugar al Yo y que éste sea capaz de posesionarse del mismo.

Para que una mujer pueda transformarse en esposa es necesario haber inscripto al propio padre como habiendo ejercido la autoprohibición al instaurar el tabú del incesto. Luego aceptar ser entregada, ser dada al hombre que se ha de transformar en marido mediante el ejercicio complementario de la ruptura (castración) del vínculo entre ese padre y esa hija.

El hombre para advenir al lugar de esposo debe ser capaz de recibir la hija del padre y apropiársela. Esta doble situación en la que ejerce la castración y al mismo tiempo recibe un don es la manera según la cual se transformará en esposo y la mujer en esposa. El papel de prohibidor (legislador o

cuidador de la ley) es cedido de padre a hijo. Algo característico de la masculinidad, es que al asumirse como hijo tiene que llevar a cabo la muerte simbólica del padre y éste a su vez aceptarlo y tolerarlo. Estas últimas vicisitudes no intervienen en la separación de la madre con su propia hija por que supuestamente el corte debe haberse producido previamente para dar lugar a la instalación y resolución del Complejo de Edipo, cuando el padre interrumpe tanto para el varón como para la niña el vínculo narcisista con la madre.

Esta formulación nos permite explicar lo que vemos en la práctica diaria como una mayor adhesión de la mujer, esposa o madre, con su propia madre o personajes de la familia siguiendo la línea de la identificación femenina y del narcisismo peculiar a la relación madre-hija. Para la niña la ruptura con su madre ejercida por el padre no está sostenida por el tabú del incesto, es temprana y tiene menos fuerza que aquella sostenida por el tabú del incesto para interrumpir el vínculo edípico del varón con su madre. Si estas operaciones resultan obstaculizadas, es posible que el varón y la mujer ocupen los lugares de esposo y esposa desde modelos de complementariedad parento-infantil.

En lo que se refiere a la estructura de familia, el esposo, para advenir a la posición de padre tendrá que ejercer la prohibición que él recibió de su propio padre para separar el hijo de su madre y reanudar el ciclo.

En síntesis esta conceptualización nos permite explicar el observable de que la masculinidad tiene una evolución diferente que la femineidad. La femineidad transcurre alrededor de las vicisitudes de la relación madre-hija, de la identificación con el interior del cuerpo, considerado como el lugar de los bebés. En cambio la masculini-

dad se desenvuelve alrededor del papel de la ley y su transmisión. En la transmisión de padres a hijos reales o simbólicos.

Hacemos la hipótesis de que el hombre puede no asumir su lugar de padre en tanto no haya podido realizar hacer el corte simbólico con su propio padre, o evite las demandas hacia él o cuando el padre renuncia a que el hijo le requiera como modelo de identificación masculino. Desde la hija pudiera cuando se siente amenazado con fantasías incestuosas o porque no pueda poner en juego la prohibición sobre sí mismo.

e) Transferencia

Al considerar este punto explicitaremos dos supuestos. El primero se refiere a los espacios mencionados previamente para decir que lo generado en cada uno es susceptible de transferencia siguiendo una particular modalidad. Lo generado en cada uno de los espacios es heterólogo y no superponible, condición registrada como una brecha que el yo intentará simbolizar a lo largo de su vida. De ahí surge una hipótesis explicativa que nos permita considerar que cada encuadre psicoanalítico tiene un límite, en cuanto a la posibilidad de la puesta en escena y el despliegue de aquello perteneciente a cada uno de los espacios. El segundo supuesto es que, en la sesión psicoanalítica, la presencia de los otros y por supuesto la del analista de pareja y de familia produce un tipo de transferencia que llamamos vincular, cuyo análisis muestra un aspecto de creación y uno de repetición.

Algunas particularidades de esta transferencia, que no profundizaremos acá, pasan por la configuración del vínculo como algo con una cualidad diferente a la suma de los mundos internos de cada uno de sus

integrantes. Es susceptible de transferencia aquel elemento fusional no pasible de ser puesto en palabras al que llamamos clima, los significados de la temporalidad propia de la pareja que adscribimos a la cotidianidad, la modalidad vincular de sus relaciones sexuales, la construcción del proyecto y la transferencia de los acuerdos y pactos. También serán objeto de transferencia los lugares y las funciones de la estructura familiar.

Una cuestión que pudiera surgir es: ¿entonces qué pasa con las representaciones del mundo interno? Respondemos que quizás todas las representaciones están presentes puesto que son susceptibles de desplazarse mediante la transferencia pero desde el punto de vista instrumental sólo son interpretables aquellas que tienen una relación de pertinencia con el encuadre dado. Es así observable que tanto después de la resolución de un conflicto en el mundo interno se resuelven algunas situaciones vinculares como que después de la elaboración de éstos se producen modificaciones en la estructura del mundo interno.

3. ENCUADRE

El postular la idea que para ciertos conflictos un encuadre pueda ser más adecuado que otro lleva implícita la hipótesis que la puesta en escena de un conflicto proveniente de uno de los espacios psíquicos requiere ciertas condiciones externas a las que llamaremos reales para que su despliegue sea factible. Esto hablaría de una limitación en la capacidad de simbolización, del como sí y nos lleva a cuestionar si la duración extremadamente prolongada de ciertos análisis no podría deberse a un intento ilusorio tanto de parte del analista co-

mo del paciente de acceder desde un encuadre a lo correspondiente a otros.

Esto se le plantea a todo analista que tiene tanto pacientes individuales como pacientes pareja o familia.

En lo referido a los aspectos prácticos del encuadre consideramos necesaria para el análisis de pareja la presencia de ambos miembros. No los atendemos separadamente por aquello que la pareja es el paciente y uno solo no alcanza para constituirlo. Para el análisis de familia pedimos que estén representados por lo menos dos generaciones con un número mínimo de tres y máximo abierto.

4. MATERIAL CLINICO

Presentaremos un viñeta de una pareja con una dificultad para transformarse en familia.

Consultaron estando la mujer embarazada, y el vínculo invadido por un intenso malestar y angustia ante la inminencia del parto para el cual sienten no estar preparados. La relación está ocupada por mutuos reproches y agresiones. El motivo central de discusión es el lugar que habrá de ocupar el bebé en el departamento, relativamente chico, donde vive la pareja. En él vive además la abuela materna que ocupa el segundo dormitorio. Ella dice que es imposible trasladarla y a la vez también es imposible obligarla a convivir con el bebé por lo cual propone un cambio de casa. El dice que esto no es importante, el bebé puede dormir en cualquier parte y dice no entiende por qué no puede dormir con la abuela. El departamento pertenecía a la esposa desde antes de su matrimonio. Siente que su esposo nunca lo ocupó, dice que no se interesa por nada de la casa, que se comporta

como si fuera un inquilino y él parece no entender el significado de estas palabras puesto que se siente cómodo. Tampoco se pueden poner de acuerdo acerca del nombre del futuro bebé, cuestión que postergan hasta el nacimiento. La dificultad para encontrar un nombre propio está basada en una crisis en los acuerdos y pactos inconsistentes puesto que la presencia del hijo hace incuestionable la pareja conyugal al transformarla en parental lo cual se asocia con la pérdida del vínculo con la familia de origen representada por la abuela materna.

En el último mes previo al parto parecen haber realizado algún pacto de no agresión, disminuyen netamente los reproches si bien cada uno incrementa sus actividades en áreas que no conciernen a la vida de la pareja. Se apoyan en la idea de la necesidad de discriminar áreas compartidas y no compartidas.

Cuando el bebé nace niegan inicialmente las dificultades planteadas sin haber podido encontrar una resolución adecuada para la creación de un espacio tercero. Establecen separadamente un vínculo dual con el hijo sin asumir por ello la función parental. Ella no pudo disolver su vínculo con su familia de origen y él no pudo ayudarla a hacer el corte. Al tiempo el hijo comenzó con una serie de síntomas de orden regresivo tal como excesivo chupeteo, dificultad ante situaciones nuevas y simultáneamente desarrolló en otras áreas hipermadurez sobre todo en el lenguaje. Fue analizado este vínculo como si hubieran tenido dos bebés, uno hipermaduro vinculado con la pareja que no pudo ser y otro regresivo vinculado con la relación de la mamá con su propia mamá. Ese bebé se convirtió en el síntoma de la imposibilidad para esta pareja de crear ese hijo simbólico que completara el acceso a la triangularidad.

RESUMEN

En el trabajo proponemos nuevas aportaciones tanto al tratamiento de la pareja y la familia como a algunos conceptos del psicoanálisis.

Redefinimos como paciente a una estructura bi o multipersonal. Hablamos así del paciente-pareja o paciente-familia. Para ello definimos algunos conceptos apropiados a este tipo de paciente; a) estructura vincular: la relación entre un yo y un otro en relación de exterioridad (ajenidad) y definitorio del área intersubjetiva. Lo diferenciamos de relación de objeto como lo propio del mundo intrasubjetivo; b) acuerdos y pactos inconscientes y las estipulaciones que sostienen los vínculos de pareja y familia.

De este tipo de paciente en la sesión psicoanalítica surgieron ampliaciones en la teoría y técnica del psicoanálisis; c) Complejo de Edipo y una reformulación del concepto de prohibición; e) Transferencia: que llamamos vincular con un aspecto de creación y uno de repetición. Fue menester reformular el encuadre terapéutico.

El trabajo presenta a manera de ilustración una breve viñeta clínica.

SUMMARY

We propose in this paper new contributions both to couple and family treatment as well as to some psychoanalytical concepts.

Our research leads us to redefine a patient as a bipersonal or multipersonal structure. Thus, we speak about the patient-couple or the patient-family. We also define some concepts appropriate to these types of patients; a) link structure: the relation between an Ego and another one on an outsi-

de relationship (alienness) which is definitory of the intersubjective. We distinguish this structure from the object relation as that which is proper to the intrasubjective world; b) unconscious pacts and agreements and the specifications that maintain couple and family links.

We broadened some theoretical and technical concepts of psychoanalysis as a result of actual practice; Narcissism, describing the relation with the one-and-only Object; d) Oedipus Complex and a reformulation of the prohibition concept; e) Transference: that we name it as a linkage with both a creative and a repetitive aspects. It was required that we reformulate the therapeutical setting.

As an illustration, we present a brief clinical vignette.

NOTA

¹ El Objeto Unico es aquel que inicialmente provee la acción específica, discrimina mundo interno y mundo externo, yo/no-yo, da los primeros índices de realidad, tiene la aptitud de anticiparse al deseo -pre-

ver - así como suministrar al yo inerte y desamparado un yo auxiliar capaz de significar. Es la contraparte del desamparo originario. En base a ello hemos atribuido al Objeto Unico las siguientes funciones: la de asistente, dador de significados, de indicación, de temporalidad, semiótica y anticipatoria.

BIBLIOGRAFIA

BERENSTEIN, I.: (a) *Vínculos Familiares Inconscientes*. Ed. Paidós, Bs. As., 1989 (en prensa). (b) New ideas about the unconscious family structure, *British Journal of Psychotherapy*, Vol. 5, Nº 3.

PUGET, J.; BERENSTEIN, I. *Psicoanálisis de Pareja*, Ed. Paidós, Bs. As., 1988 (Le socle inconscient du couple, *Gruppo*, Nº 2, 3, 1986). "Psicoanálisis de la pareja y de la familia", 36º Congreso Internacional de Psicoanálisis de Roma, 1989.

PUGET, J. "Un Espace Psychique ou trois Espaces? sont-ils superposés?". *Symposium International: Groupe Analytique et Formation*. Lausanne. Octubre 1988. ("Formación psicoanalítica de grupo - Un espacio psíquico o tres espacios ¿Son superpuestos? *Revista de Psicología y Psicoterapia de Grupo*. XII, Nº 12, marzo 1989.

CERF

Centro para el Estudio
de Relaciones Familiares

Directores:
Psic. Olga Benzadon-González
Psic. Alberto G. González

JORNADAS DE ACTUALIZACION
CIENTIFICA

Dra. ILDA FICHER

Universidad de Widener - Filadelfia

I LA MEDIACION EN EL PROCESO DE DIVORCIO

1. Tenencia de los hijos
2. Actualización de las investigaciones sobre el efecto del divorcio en los hijos
3. Estrategias de abordaje para los acuerdos de separación

Mayo 30 y 31 de 10 a 13 hs. y de 14 a 17 hs.

II TRATAMIENTO DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES EN EL CONTEXTO DE LA TERAPIA MARITAL

1. Tratamiento apropiado para los diferentes tipos de pareja y problemas presentados
2. Diagnóstico diferencial: Organicidad Vs. Psicogenicidad.
3. Supervisión de casos.

Junio 1 y 2 de 10 a 13 hs. y de 14 a 17 hs.

SEDE: EMBAJADA DEL URUGUAY - Las Heras 1987 Auditorio 1er. Piso.
INSCRIP. E INFORMES: CERF. Soler, 3765 4to. "J" Nº 18
Tel. 824-1188 de 14 a 20 hs.
Librería Paidós: Las Heras 3741 - Local 31 - Tel. 801-1286 de 10 a 19 hs.

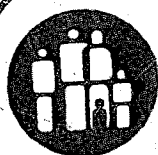
DEPARTAMENTO DE DOCENCIA 1990

Introducción a la terapia sistémica
Especialización clínica en terapia familiar
La persona del terapeuta

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA

Honorarios institucionales

Soler 3765 4º 18 C.P. 1425 - Tel. 824-1188 - Buenos Aires - Argentina



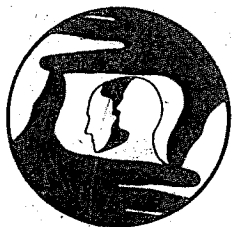
CENTRO DE INVESTIGACION FAMILIAR

Directora: Wanda Santi

FORMACION TERAPEUTAS FAMILIARES TALLERES - CHARLAS - VIDEO DEPARTAMENTO EXT. COMUNITARIA

- Grupos de autoayuda a discapacitados visuales.
- Terapias a honorarios institucionales.
- Gratuidad a familias de bajos recursos.

AZCUENAGA 964 2º "C" ☎ 961-4295
(1115) Buenos Aires - Argentina



C.E.F.Y.P. Centro de Familias y Parejas
Director General: Dr. ADOLFO LOKETEK
Directora: Lic. MARIA ROSA GLASSERMAN

Actividades Mayo/Junio de 1990

- 22/5 - Comienza Seminario "APORTES EPISTEMOLOGICOS A LA TERAPIA FAMILIAR" 19.30 a 22.30 hs.
Lic. SILVIA CRESCINI/Lic. JAIME SZWARSTEIN
- 31/5 y 28/6 - II y III Conferencia Clínica. 12 a 13,30
Dr. ADOLFO LOKETEK
- 4/6 - Comienza Taller de Teatro. 12,45 a 14,15 hs.
FRANKLIN CAICEDO.
- 6/6 - Comienza Taller "EL GENOGRAMA DEL TERAPEUTA FAMILIAR".
Lic. MARIA ROSA GLASSERMAN

Billinghurst 1867 - ☎ 825-1562 / 83-3475

Tratamiento de las disfunciones psicosexuales en el contexto de la terapia marital

ILDA V. FICHER

Universidad de Wideney
Filadelfia USA.

Especialista en sexualidad y mediación para el divorcio

Desde mi punto de vista, la terapia sexual, es una subdivisión de la terapia marital. Mientras que los problemas sexuales son frecuentemente el motivo de consulta de los clientes que buscan terapia, las disfunciones sexuales son sólo frecuentemente la manifestación del conflicto marital. Para el hecho de que el matrimonio es una relación íntima entre dos personas, la intimidad sexual es singularmente sensible a los sentimientos de amor, confianza, enojo, pena y rechazo. En sí misma la relación marital es el paciente en la terapia sexual y es la tarea de los clínicos determinar el foco inicial del tratamiento. Desde la perspectiva de la teoría sistémica, no puede hacerse distinción clara entre los síntomas sexuales y maritales.

En general las parejas que buscan terapia se dividen en tres categorías, (Sager, 1974). La terapia sexual inmediata está indicada en aquellos casos donde la disfunción sexual está produciendo discordia marital. Está contraindicada para parejas que están experimentando severo conflicto marital y hostilidad básica entre ellos. La terapia sexual se puede iniciar en los casos donde hay algún problema marital que incide sobre el funcionamiento sexual si los cónyuges tienen sentimientos positivos reci-

procos y desean mejorar su relación.

En la clínica, de acuerdo a nuestra perspectiva sistémica, tomamos un abordaje multicausal ecléctico para la comprensión y el tratamiento de las dificultades sexuales, (Ficher, 1982). En las entrevistas que comprenden la fase de evaluación el terapeuta busca tanto las causas inmediatas como las remotas de la disfunción sexual. En la entrevista conjunta se interroga a la pareja sobre su historia y el estado actual de la relación marital. A los cónyuges se les pregunta en forma individual cómo ven el problema actual, cómo comenzó y por qué están buscando tratamiento ahora. También se les pregunta sobre el ciclo vital de su matrimonio, cómo se conocieron, qué es lo que los atrajo de su pareja, el proceso de noviazgo, dificultades de los comienzos y qué es lo que desde entonces les ha resultado muy difícil. La meta del terapeuta en la primera sesión conjunta es adquirir una impresión de calidad de la relación marital a través del contenido y del proceso de las interacciones de la pareja.

Las entrevistas pueden ser conducidas alternativamente con cada miembro de la pareja en forma individual para obtener una más extensa historia individual. Las entrevistas se focalizan sobre temas premaritales, familia de origen, experiencias infantiles y relaciones actuales. La meta de las sesiones individuales es obtener más información sobre el funcionamiento individual y descubrir diferencias en las conductas de cada uno y en su "historia" individual.

Durante la fase de evaluación el terapeuta toma decisiones respecto a qué técnicas terapéuticas utilizará en el tratamiento. Nuestro programa enfatiza la importancia de adaptar las técnicas terapéuticas al estilo de vida y al sistema de valores de sus

clientes. Nuestra experiencia al trabajar con personas de diferentes backgrounds socioeconómicos y culturales nos ha provisto de una extensa información con respecto al rango de disfunciones sexuales y a la clase de estrategias más efectivas de tratamiento, (Ficher, 1980). Hemos desarrollado una serie de consideraciones como marco de referencia que los terapeutas debieran preocuparse por conocer cuando determinan un plan de tratamiento. Antes de desarrollar una estrategia de tratamiento para tratar problemas presentes, el terapeuta debe comprender globalmente el contexto sociocultural con el cual la metodología del tratamiento debe ser compatible. Lo siguiente representa algunas de las cuestiones mayores que requieren atención: normas socioculturales, las expectativas del rol ligadas al género, rasgos ligados al sexo, restricciones impuestas culturalmente y expectativas de lenguaje. El terapeuta debe estar alerta a los mitos, creencias y costumbres que influyen en la conducta del paciente, porque sin tal comprensión puede emplear estrategias terapéuticas que entran en conflicto con las actitudes y valores personales de la pareja respecto al sexo y al matrimonio.

Una vez que el plan del tratamiento se ha desarrollado, el tratamiento consiste en sesiones conjuntas que combinan psicoterapia y prescriben ejercicios sexuales. Las intervenciones clínicas están diseñadas para cambiar el sistema disfuncional marital y sexual. Una de las más significativas contribuciones de la teoría de los sistemas a la ciencia de la conducta ha sido el reconocimiento de que las dificultades sexuales están frecuentemente relacionadas a los aspectos más difíciles de la relación marital y no son necesariamente expresión de los conflictos intrapsíquicos individuales de

una persona. El terapeuta buscará explorar conflictos intrapsíquicos individuales, si el/la terapeuta ha determinado que poseen un impacto en la disfunción sexual y, por lo tanto, los clientes pueden ser asistidos con un enfoque psicodinámico, (Ficher, 1985).

En síntesis, la terapia sexual es una subdivisión de la terapia marital porque la disfunción sexual es un producto del conflicto marital. Al margen de que el cliente posea el síntoma, el paciente es la relación y el tratamiento es realizado con parejas en terapia conjunta. Los tipos de intervención y las técnicas a utilizar deben ser moldeadas a los valores y necesidades de los clientes. Los siguientes casos ilustrarán los diversos factores implicados en el desarrollo e implementación del tratamiento para las disfunciones sexuales.

CASO 1: JUANA Y PEDRO

Fase de evaluación

Juana, una orientadora escolar de 29 años y Pedro un terapeuta físico de 39 años, me fueron derivados para terapia sexual por un ginecólogo, porque no podían llegar al coito a pesar de sus 7 años de matrimonio. En el momento de la derivación no era claro, si el problema primario era vaginismo, disfunción de erección o ambos. La pareja informó que buscaban ayuda en ese momento por el deseo de tener un hijo. Tanto Juana como Pedro eran católicos practicantes y Pedro había sido cura hasta el momento en que se casaron.

En la entrevista inicial conjunta se interrogó a la pareja sobre su estado actual e historia de la relación marital. A ambos se les preguntó cómo veían su problema sexual, cómo comenzó y porqué buscaban tratamiento en este momento. También cómo

se conocieron, qué los atrajo el uno por el otro, cómo había sido el noviazgo, qué dificultades experimentaron al comienzo del matrimonio y qué había pasado desde entonces.

Las sesiones segunda y tercera consistieron en entrevistas individuales con cada uno de ellos. La pareja fue reunida nuevamente en una cuarta sesión en la que exploramos las percepciones y expectativas de cada uno de ellos con respecto al matrimonio.

Las siguientes son algunas de las preguntas que hicimos: ¿Cómo se ve uno al otro como amante? ¿Cuáles fueron sus expectativas con respecto al matrimonio? ¿Cuántas de esas expectativas se han realizado y cuáles han cambiado? ¿Cómo es su fantasía de un buen matrimonio? Mi meta en esta sesión era descubrir la función del síntoma en el sistema marital y comprender cómo esto satisfacía las necesidades de cada uno. La cuarta sesión produjo la siguiente información.

Pedro y Juana convinieron que tenían una vida sexual satisfactoria a pesar de su inhabilidad para llegar al coito. Pedro dijo que era capaz de tener erecciones durante el juego sexual con Juana pero que la perdía cuando comenzaba la penetración. Añadió que era capaz de mantener una erección adecuada durante la masturbación. Juana informó que ella tenía respuesta sexual y orgasmo durante la estimulación manual y oral pero que presentaba dificultades con la penetración. Ambos convinieron que tenían una relación amorosa y que deseaban que el matrimonio fuera exitoso. Sus palabras eran confirmadas por el hecho de que se trataban uno al otro con cariño y mucho afecto durante las sesiones.

Historia de la pareja: Juana y Pedro se conocieron en el colegio cuando ella tenía

20 años y él 30 años. Pedro permaneció siendo cura durante los dos años de noviazgo. Durante el noviazgo ellos se "interrelacionaban" en todo menos en el coito. Juana no recordaba que hubiera habido problemas en Pedro con las erecciones en ese momento. Recordó que ambos habían decidido no tener coito antes del matrimonio. Ella dijo que al principio Pedro tenía más atracción por ella que ella por él y que después de cierto tiempo de matrimonio ella se sintió más ligada a él.

Historia de Juana: Juana era la mayor de las dos hijas de una familia irlandesa católica tradicional. Se sentía mucho más cerca de su madre, una ama de casa full-time devota que se dedicó a cuidar su hogar y sus hijos. El padre permanecía mucho tiempo fuera de la casa debido a los requerimientos de su trabajo. Juana consideraba al matrimonio de sus padres libre de mayores problemas, y afirmó que su infancia había sido feliz. También recordó ser la "niña buena" que trataba de ser útil a su madre mientras que su hermana (3 años menor) era más rebelde. Juana se describe a sí misma como una adolescente tímida, bien vista tanto por los chicos como por las chicas. Tuvo citas tanto en la escuela como en el colegio, pero no fue sexualmente activa hasta que conoció a Pedro. Juana se educó en escuelas parroquiales y fue al colegio católico para estudios preuniversitarios. Ella ve a sus padres sólo dos o tres veces al año por la distancia geográfica, pero se comunica regularmente con ellos por teléfono.

Historia de Pedro: Pedro fue el segundo hijo de una familia irlandesa católica de tres hijos y dos hijas. Nació y se crió en el Sur y se educó en escuelas católicas. Su madre extremadamente religiosa esperaba que uno de sus hijos fuera cura. Frecuentemente había curas invitados a cenar a su ho-

gar y la madre asistía a misa diariamente. Pedro la percibía como muy metida, infantil, dependiente y asexuada. Dijo que él era su hijo favorito. Pedro describió a su padre como autocrático y preocupado con su trabajo de abogado la mayor parte del tiempo. Sospechaba que su padre tenía *affaires* con otras mujeres. Pedro se sentía constantemente descalificado por su padre y que "nunca nada era bastante para él". El favorito de su padre era el hermano mayor de Pedro a quien describía como un abogado inescrupuloso, que era egoísta, desconsiderado con los demás tal como era su padre. Pedro se veía a sí mismo como interesado por los demás y como un benefactor de sus hermanos menores. Pedro decía que siempre se sintió popular con las chicas, tenía numerosas citas y planeaba casarse y fundar una familia. Comenzó sus estudios pre-médicos de acuerdo con los planes de su padre que deseaba que fuera médico. Su decisión de entrar al sacerdocio a los 21 años fue motivada fundamentalmente por el deseo de satisfacer a su madre y oponerse al padre que se negaba ferozmente a esta decisión. Su madre murió cuando Pedro tenía más de 20 años y su padre 5 años después. Pedro tenía citas aún siendo cura, siempre tenía a "alguien". Dijo que fue sexualmente activo pero que nunca llegó al coito. Se masturbaba desde los 13 o 14 años y dijo tener fantasías heterosexuales durante las mismas.

Diagnóstico y plan de tratamiento

Después de las cuatro sesiones del proceso de evaluación se formuló el diagnóstico y el plan de tratamiento. Yo determiné que la pareja no tenía problemas serios en su relación marital ya que ambos sentían que tenían una unión muy próxima y amorosa. Y

observé que durante las sesiones se relacionaban cálidamente. El ginecólogo de Juana informó que no había causas fisiológicas para su vaginismo y que ella podía completar el examen físico cuando se relajaba. Por lo tanto, inicialmente parecía un caso relativamente claro para la terapia sexual. El diagnóstico primario fue de vaginismo, una condición bastante común en las mujeres católicas de profundas convicciones religiosas. A Pedro se lo vio como teniendo disfunción en la erección relacionada con la ansiedad de ejecución como consecuencia de su inhabilidad para la penetración. También sentí que él tenía alguna culpa que respondía al abandono de su carrera como seminarista. El plan de tratamiento consistió en una combinación de prescripciones conductuales específicamente diseñadas para estas disfunciones y psicoterapia focalizada en este fuerte background religioso y su culpa consecuente.

En la medida que progresó la terapia y la condición de Juana mejoró sustancialmente se tornó más claro que los problemas sexuales de Pedro tenían raíces más profundas conectadas con sus conflictos de dependencia. La pareja terminó su terapia cuando Pedro rechazó la terapia individual de orientación psicoanalítica para resolver esos conflictos y aquellos vinculados al sacerdocio. Mi conclusión fue que hubo un error en la evaluación inicial de la pareja al determinar que sus disfunciones sexuales no estaban comprometidas con sus problemas psicológicos o maritales.

Proceso del tratamiento

La terapia comenzó con ejercicios de focalización sensorial para la pareja, a fin de reducir tensiones y aliviarlos de la ansiedad de ejecución (Kaplan, 1974, para una dis-

cusión más detallada de esto y otras técnicas de terapia sexual). Esto fue seguido de ejercicios específicos para Juana y para la pareja. A Juana se le prescribió el tratamiento standard para el vaginismo, condición en donde la entrada vaginal se contrae tan fuertemente que hace imposible la penetración. El vaginismo es una respuesta condicionada como resultado de la asociación del miedo y el dolor a la penetración. La meta del tratamiento es la alteración de las respuestas aprendidas a través de un descondicionamiento progresivo del espasmo involuntario de los músculos que rodean la entrada vaginal. A Juana se la instruyó inicialmente para que se tocara y fantaseara. Cuando se sintió cómoda con estos ejercicios debía introducirse un dedo en su vagina y después otro. Cuando ella logró relajarse con estos ejercicios individuales, tenía que pedirle a Pedro que le introdujera un dedo y después dos en su vagina, controlando la progresión del procedimiento, en la medida en que se sintiera cómoda. Las prescripciones diseñadas para desviar la atención de Pedro de sus erecciones, incluían leer literatura erótica, fantasear y ver films eróticos en el dormitorio. todo anduvo bien durante la fase inicial de la terapia, tanto Juana como Pedro aceptaron las instrucciones, se comunicaban libremente y cooperaban en forma total. En cada tramo, Juana se sentía relativamente relajada, con mayor confianza y comodidad con su sexualidad. No obstante en la medida que ella fue aumentando las demandas hacia Pedro, él experimentaba mayor dificultad y a veces no lograba una erección. Cuando la pareja progresó a la etapa donde Pedro debía insertar su pene en la vagina de Juana, él perdía su erección. Al poco tiempo comenzó a tratar de evitar completamente el coito. Me asombré en relación con lo que es-

taba pasando, porque aparentemente ellos parecían cooperar con el tratamiento.

Apareció un elemento que derivaba de un cambio en el ciclo vital de su matrimonio. Un cambio significativo se había llevado a cabo en el balance del poder, a través de los años, en la relación de esta pareja. En sus comienzos su relación podía caracterizarse como una relación de padre e hija con Pedro siendo mayor y más mundano, que guiaba y protegía a la tímida e ingenua Juana. Pedro era un hombre muy atractivo, con una actitud de seguridad de sí mismo y ligeramente seductor. Al descubrir su atracción inicial hacia Juana, había dicho que ella era "diferente a las otras chicas", ya que no era egoísta, era vistosa, seria, religiosa y virgen. Yo noté una llamativa similitud entre la descripción que hizo Pedro de Juana y la de su madre, a quien él visualizaba como dulce, asexuada y casi santa. Cuando la pareja comenzó terapia, Juana era completamente diferente de la descripción que había hecho Pedro, era una joven bien parecida, abierta y moderna. En la medida que el tratamiento progresó, ella devino más atractiva y libre sexualmente. La percepción de Pedro hacia Juana no correspondía con la realidad. Quizá él necesitaba negar su sexualidad porque no podía tener una esposa tan sexy.

El temprano control parental de Pedro sobre Juana puede ilustrarse con un incidente que ocurrió tres años antes que la pareja solicitara terapia. A Juana le habían ofrecido dos distintos puestos de consejera escolar, una con buen salario en una escuela suburbana prestigiada y el otro puesto en una escuela privada menos prestigiada con un salario de \$7.000 menos. Pedro la convenció que aceptara la de menor posición porque la escuela quedaba más cerca de la casa, no obstante su fuerte preferencia por

la otra. En los tres años posteriores, Juana se hizo más segura y menos deseosa de ser controlada por Pedro.

Durante el tratamiento exploramos las familias de origen y las culpas que surgían en ambos miembros debido a las fuertes convicciones religiosas. Cuando se pasó esta etapa, se trasladó el foco de la terapia a los conflictos de lealtad de Pedro. Varias cuestiones habían emergido con respecto a las relaciones de Pedro con su familia de origen. Actualmente tenía contactos con una hermana, —trabajadora social psiquiátrica— que aún vivía en el sur con el resto de la familia. Pedro la utilizaba a ella como un medio de contactar con la familia sin mantener él un contacto directo, él continuaba sintiéndose culpable y amargado con su padre por el hecho de que nunca había podido elaborar esa relación tormentosa. Cuando su padre murió de un ataque al corazón imprevisiblemente, Pedro estaba al final de sus 20 años y entre los dos no había diálogo. El padre dejó una buena cantidad de dinero que fue dividido equitativamente entre los cinco hijos. Como en tal época Pedro estaba en su carrera de cura, él sintió que no necesitaba ese dinero, él le prestó su parte al hermano menor para que iniciara el pre-grado y la carrera médica. Esta benevolencia de Pedro con su hermano menor era congruente con la imagen de sí mismo como una persona protectora que estaba más comprometido con el bienestar de sus hermanos menores que con sus propias necesidades. El hermano de Pedro había satisfecho las expectativas del padre que originalmente habían sido para Pedro, de ser un médico exitoso y de hacer fortuna. Pedro sintió que su hermano era desagradecido al no devolverle el dinero que él le había prestado y estaba convencido de que a su hermano le habían lavado el cere-

bro al no querer a su hermano mayor. Pedro había transferido muchos de sus sentimientos negativos relacionados con su padre, a su hermano mayor. El no había contactado con su hermano mayor durante tres años y lo describía "igual a su padre", un "abogado inescrupuloso", egoísta y no confiable. Fue claro para mí que Pedro tenía muchas cuestiones sin resolver con su familia que estaban interfiriendo con su vida actual.

Sugerí a Pedro que fuera a su hogar, en el sur para resolver algunos conflictos. Cuando inicialmente indiqué una reunión familiar Pedro pensó que era una idea loca. No obstante, cuando él reconoció las relaciones entre sus problemas familiares y sus problemas actuales se sintió intrigado y aceptó ir. Cuando fueron a la casa de la familia de Pedro, Pedro y Juana estuvieron en la casa de la hermana más cerca a él y vieron a todos sus hermanos. Por primera vez hablaron acerca de sus padres, y cómo cada uno de ellos veía a sus padres. Pedro descubrió que su hermano mayor siempre había estado celoso de su estrecha relación con su madre y que reveló que nunca se había visto como el favorito del padre; más bien él se había inclinado hacia él porque nunca podía sentirse cerca de su madre. Tanto los hermanos y hermanas veían a Pedro como un hermano más sensible, una persona protectora y generosa. El hermano menor se sorprendió cuando Pedro comentó el tema del dinero que le había prestado para su carrera. Lo había visto a Pedro como "la madre" que se ocupaba de él después de la muerte de sus padres. En ese contexto para nada se le había ocurrido que Pedro pretendiera la devolución de ese dinero. Cuando Pedro le había dado el dinero a su hermano, él tenía poco interés en el dinero, y seguía siendo cura. todos los hermanos aún pensaban en Pedro como cura.

También le señaló el hermano, que Pedro nunca le había pedido plata de vuelta. Pedro sintió que su experiencia con su familia había sido sumamente exitosa porque le había aclarado muchas de sus distorsiones y recuperaba la familia que había perdido.

Después que la pareja volvió del sur, Pedro se sentía muy contento y comenzó a hablar de la abadía en la que había vivido en su época de cura. Mientras él hablaba de su vida allí, se me hizo claro que había recreado su familia de origen allí. En su familia de origen él había estado atrapado entre su madre casi santa que quería que él fuera cura y un padre mundano que quería que fuera médico. El resolvió ese conflicto haciéndose cura, pero utilizando su herencia para hacer que su hermano fuera médico. En la abadía él también queda atrapado en medio, esta vez entre la Madre Iglesia que él amaba, y un Padre Superior fuerte y dominante. Siendo un hombre joven del 60, Pedro había participado en actividades pacifistas y liberales como cura, pero el Padre Superior desaprobaba las actividades sociales y políticas. También Pedro se había rebelado siendo activo sexualmente mientras era cura, pero nunca dio el paso final de llegar al coito. (Dentro de la iglesia no se considera que un cura haya roto su voto de celibato a menos que haya llegado a una relación completa). Por lo tanto Pedro peleaba contra el Padre Superior mediante la desobediencia, pero nunca podía llegar a correr todo el camino o renunciar a la relación. Aun cuando Pedro dejó la abadía, cuando se casó hace 7 años, la comunidad no había reconocido que él se había ido. Todas las navidades recibía una tarjeta del Padre Superior dirigida al "Padre P".

Exploraciones posteriores revelaban que Pedro nunca había dejado emocionalmente su sacerdocio. Todos sus amigos

eran parte de una red informal de ex-curas que se mantenían unidos para su apoyo mutuo e identidad. Yo comencé a ver el significado que tenía para Pedro el matrimonio no consumado: él no había roto el voto de celibato y por lo tanto era aún un "buen cura". Así como él había mantenido su resentimiento respecto al padre, transfiriéndolo a su hermano mayor, él retenía su ser cura y sus conexiones con el Padre Superior manteniendo su voto de celibato. Yo urgí a Pedro a que visitara la abadía para resolver estos conflictos pero él se negó a hacer la visita cuando exploramos esta situación.

Durante este período de la terapia, Juana se afirmó, era más libre y estaba menos deseosa de tolerar la limitada relación sexual que ellos tenían. Ella comenzó a considerar la separación. Ni la acentuada presión de Juana, ni ningunas de mis estrategias terapéuticas tuvieron efecto sobre Pedro que aún se negaba a trabajar sus relaciones con la abadía. Pedro aumentaba su resistencia a la terapia desde la visita a su familia, ahora dejó de trabajar junto con ella en la terapia, diciendo que él venía a la terapia porque Juana se lo pedía. Cuando se le ofreció la opción de terapia psicoanalítica individual conmigo o cualquier otro terapeuta, Pedro rechazó la idea de seguir adelante con el tratamiento. Como Juana y Pedro estaban por salir de vacaciones, acordamos que me llamarían con su decisión cuando volvieran dentro de un mes. Pedro aceptó considerar la terapia individual y hablar con sus amigos ex-curas para ver si habían tenido problemas similares. La pareja no contactó conmigo nuevamente.

Cuando yo llamé después de unos tres meses Pedro dijo que la terapia había sido útil en muchas áreas pero que no había habido cambios en sus problemas sexuales.

El había iniciado un grupo de apoyo con excuras que se encontraban para discutir sus dificultades comunes en el ajuste a la vida secular y que esto le era muy útil a todos ellos. Dijo que Juana y Pedro acordaron que no sería productivo volver a la terapia sexual en este momento. Dos semanas más tarde Juana llamó pidiendo ser derivada a un tratamiento individual.

Análisis del tratamiento

Yo consideré este caso como un fracaso atribuible a un error en la evaluación inicial de la pareja. Si el foco se hubiera dirigido hacia la dinámica de las relaciones maritales y cómo habían cambiado, hubiera emergido más claramente la función del síntoma en el sistema marital. Probablemente dicha exploración hubiera expuesto las lealtades divididas y la ambivalencia de Pedro. Pedro logró "insight" de sus conflictos como se evidencia por su acceso a visitar a su familia de origen. No obstante, no pudo iniciar ninguna acción basada en el "insight" de sus relaciones con su familia espiritual, ni una exploración de sus conflictos de dependencia. Quizá hubiera estado deseoso de abordar estas cuestiones si no hubiera estado presionado por Juana en aumento de sus demandas sexuales.

El diagnóstico original fue de disfunción sexual sin complicaciones porque Juana y Pedro impresionaban como estando muy cerca, queriéndose y relativamente sanos psicológicamente. La terapia sexual comenzó inmediatamente para el vaginismo de Juana y la disfunción de erección atribuida a la inhabilidad de Pedro para la penetración. Retrospectivamente queda poco claro si el vaginismo estuvo realmente presente o si Juana deseaba simplemente aceptar el rol de "paciente sintomá-

tico" por la dinámica de la relación marital.

Es importante considerar el contexto sociocultural de una relación de pareja. Cuando Juana y Pedro se conocieron, él era cura y le llevaba 10 años. Juana había internalizado los valores de su hogar irlandés religioso y la educación católica. Dentro de este marco los curas eran considerados más sabios, más fuertes y superiores. Si había una inadecuación sexual debía pertenecer a Juana y no a Pedro. La complementariedad de la relación de esta pareja también queda ilustrada por la relación padre-hija que habían tenido en los primeros años de su matrimonio.

Yo diagnosticué la impotencia de Pedro como secundaria, considerando su virginidad cuando entró de cura, bastante común ya que muchos jóvenes en sus 20 años no han experimentado aún la relación sexual. Retrospectivamente Pedro debiera haber sido diagnosticado como habiendo tenido una impotencia primaria ya que el no haber experimentado la relación sexual, estaba más relacionado con sus conflictos socioculturales y familiares. La madre de Pedro era una mujer muy religiosa que esperaba que uno de sus hijos fuera cura. Siendo Pedro su favorito sintió desde la infancia que él debía cumplir con los deseos de la madre. Es muy común en familias católicas irlandesas que uno de los hijos en edad temprana sea seleccionado para hacer la contribución de la familia a la iglesia. Las condiciones eran ideales para que Pedro internalizara los conflictos parentales, porque su padre esperaba que él fuera médico. Pedro era medio cura y medio no. Se rebelaba contra su padre y su padre espiritual, quedando así "a mitad de camino". El conflicto debe haber sido un factor importante en la relación de Juana como su mujer: en el momento en que la veía como pu-

ra, seria y santa como su madre, una perfecta compañera para ayudarlo a rebelarse un poco. Durante el curso de la terapia sexual Juana devino más cómoda con su sexualidad y más demandante hacia Pedro, quien se sintió más presionado de lo que él podía manejar. Pedro no podía consumir el matrimonio antes de resolver su conflicto intrapsíquico entre su madre y padre y entre sacerdocio y matrimonio.

Debiera haberse dedicado mayor atención a la cuestión que es la que hacía ahora intolerable la disfunción sexual. La razón por la cual la pareja había solicitado terapia fue el mutuo deseo de tener un hijo. No obstante, el ímpetu para entrar en terapia provenía desde Juana. Ella se estaba acercando a los 30 años, sintiendo la presión del tiempo. Cuando Juana y Pedro se conocieron ella era una joven de 20 años "buena católica" protegida y con inexperiencia sexual y la ausencia de las relaciones no había sido perturbadora. En la medida que se fue acercando a los 30 años, empezó a sentirse lista para "crecer" sexualmente y por lo tanto empezó a hacerle demandas a Pedro. Inicialmente estaba deseosa de aceptar los problemas como si fueran propios, no obstante, en la medida en que aumentó su competencia y soltura sexual, comenzó a esperar que Pedro cambiara. Por su parte Pedro estaba contento con el status quo y probablemente hubiera seguido así para siempre. La situación le permitía a él tener dos mundos: él podía estar casado y activo sexualmente y mantener sus votos sacerdotales.

En síntesis, este caso ilustra al menos dos de las dificultades al practicar la terapia sexual desde una perspectiva familiar sistémica. La visión de las dificultades sexuales como relacionadas a la dinámica de la relación marital y no como una expresión

de los conflictos intrapsíquicos ha sido un avance importante. No obstante, este caso demuestra la necesidad de investigar las causas individuales e históricas conjuntamente con las interacciones del "aquí y ahora" de la pareja. Pedro tenía conflictos serios no resueltos que estaban bastante separados de su relación con Juana. El fue capaz de actuar con "insight" en la conexión de sus problemas con su familia de origen y sus problemas presentes, pero no en la cuestión de la relación marital.

CASO 2: JUDY Y ALAN Entrevista inicial

Alan, un abogado de 28 años y Judy de 26, artista, me fueron enviados para terapia sexual por antiguos pacientes míos, pues Alan era incapaz de alcanzar el orgasmo y un examen realizado por un urólogo mostró que no había disfunciones orgánicas. La pareja estaba casada desde hacía 2 años y dijeron tener problemas desde el comienzo de su relación. Dijeron además que buscaron ayuda desde entonces, ya que sintieron que su matrimonio se derrumbaba y sus contactos sexuales eran esporádicos. Ambos eran católicos y educados en escuelas católicas, incluyendo la universidad. Yo usé para este caso el mismo modelo que en el caso Nº 1. la pareja fue evaluada en 4 sesiones antes de tomar una decisión sobre la técnica terapéutica a ser usada en el tratamiento.

Historia de la pareja

Judy y Alan se conocieron en la universidad cuando ella tenía 22 años y él 24. Durante el cortejo, tuvieron ciertos acercamientos sexuales pero decidieron no ir más lejos hasta casarse, pues esto iba en-

contra de su religión. Alan era brillante y bastante flexible aunque a veces parecía un poco tímido. También había señales de ciertas conductas pasivo-agresivas. Comentaron que en sus relaciones íntimas, Alan podía intentar durante 45 a 50 minutos sin ningún éxito. Judy no se percató del problema hasta que Alan se lo confió. Tenía temor de comunicarle esto a su esposa para no lastimarla y así falló en tener orgasmo alrededor de 3 meses. Esto lo dejó frustrado y ansioso y trató de evitar esta situación lo más posible. Judy era una joven atractiva, pasiva y emocionalmente necesitada. Una vez que Alan le confesó su problema, ella lo interpretó como su propia culpa, reprochándose a sí misma y al mismo tiempo como otro agregado a su difícil vida. Esto recreó la sensación de desconfianza y abandono que ella experimentó en el pasado con su propia familia de origen, especialmente con su padre alcohólico. El padre era religioso, malhumorado y con tendencia a denigrarla, especialmente cuando estaba borracho. Judy y Alan no informaron de ningún otro antecedente psiquiátrico en ninguna de las dos familias.

Proceso terapéutico y resultados

En la primera etapa del tratamiento se asignó a la pareja, ejercicios placenteros, enfatizando la prohibición de contacto genital, de manera tal que Alan no se sintiera obligado a mejorar. Simultáneamente la pareja fue impulsada por el terapeuta a explorar en las sesiones sus necesidades individuales y maritales, como así también sus expectativas con respecto a cada uno y con respecto al matrimonio. Al mismo tiempo percibieron, cómo su funcionamiento sexual era paradigmático de su relación ma-

rital y cómo ambos estaban involucrados y complotados en mantener la distancia entre ambos. Judy era capaz en ese momento de discutir sus sentimientos ambivalentes hacia Alan con quien ella deseaba realmente estar más cerca y más cariñosa, aunque al mismo tiempo tenía miedo de que él, como su padre, la lastimara. (Esto se complicó con un abuso físico y ulterior abandono de un antiguo novio, de quien estuvo profundamente enamorada). Durante varios años antes del matrimonio, se sintió ansiosa y depresiva cuestionándose, qué había hecho para merecer ese abuso y tener sueños viéndose a su padre como el agresor sexual. El matrimonio, de hecho, fue la respuesta para liberarse de esos sentimientos y como resultado eligió un esposo que aparentaba ser dócil. Sin embargo, luego de su matrimonio, comenzó a incorporar en sus sueños, a su esposo junto a los otros agresores. Repentinamente se encontró en una situación perdedora, deseando afecto y amor de su esposo, mientras al mismo tiempo, desconfiaba de él por ser un hombre.

Alan venía de una familia irlandesa católica, con una madre dominante, siendo el mayor de 5 hijos. Con su padre hubo muy poca interacción afectiva, y desarrolló un secreto deseo de ser querido por él y usándolo como modelo desarrolló una actitud pasiva y defensiva frente a las mujeres.

Alan como otros chicos católicos, no era extraño que nunca se hubiera masturbado y por lo tanto, no tenía conciencia de sus dificultades eyaculatorias. Nunca tuvo relaciones sexuales antes de su matrimonio. Para poder continuar con su conducta pasiva, eligió una mujer insegura, para quien esta abstinencia era valiosa. Al mismo tiempo siendo un joven tierno y cortés, frustró sus necesidades de acercamiento y ternura. El resultado fue que los ejercicios

focalizados en sus relaciones (inicialmente prescriptos), fueron saboteados por ambos, usando diferentes excusas como: fatigas, falta de tiempo, desagrado, incomodidad, etc. Yo interpreté este rechazo de la intimidad sensual como resultado de los sentimientos ambivalentes entre ambos. A través de sesiones individuales y conjuntas tratando sus interrelaciones y dinámica intrapsíquica, empezaron a sentirse más cómodos entre ellos durante los ejercicios placenteros.

El próximo paso del tratamiento fue el abordaje de la eyaculación retardada. Generalmente el tratamiento standard, sería que el esposo se masturbara en ambiente emocionalmente confortable y luego gradualmente ser capaz de masturbarse cerca de su pareja hasta que pudiera, luego de varios pasos, tener una eyaculación durante el coito (Kaplan, 1974). Sin embargo debido a los antecedentes estrictamente católicos de Alan y sus sentimientos negativos acerca de la masturbación yo estaba segura de que sabotearía pasivamente el tratamiento. Utilizando una variedad de técnicas de relajación, se le enseñó cómo relajarse sistemáticamente. También fue instruido para tener fantasías eróticas, enfocándolas especialmente en la vagina de Judy. Estas fantasías debía tenerlas, primero, antes de estar juntos y luego nuevamente cuando estaba en la cama. Durante una de sus sesiones individuales Alan relató que era incapaz de fantasear frente a Judy.

La pareja fue motivada posteriormente a compartir fantasías eróticas para desarrollar sentimientos de intimidad sensual y emocional.

Luego Alan fue aconsejado de penetrar la vagina de Judy en una situación relajada mientras compartían las fantasías eróticas. Gradualmente Alan se permitió experi-

mentar placer y sentir excitación sexual mientras Judy se estimulaba manualmente los genitales. Luego del tercer intento, él alcanzó el orgasmo y eyaculó durante el coito.

Este tratamiento duró 18 semanas. En el seguimiento después de un mes, la pareja no presentó problemas sexuales.

Como en otros casos, las intervenciones terapéuticas fueron diseñadas para cambiar los problemas maritales y la disfunción sexual.

CASO EJEMPLO Nº 3: MARIO Y SUSANA

Diagnóstico y Plan de Tratamiento

Mario y Susana fueron derivados a nuestra clínica por un urólogo, para terapia sexual. La pareja llevaba 4 años de casada cuando los ví. Guillermo era un dibujante de 31 años y Susana una atractiva mujer de 25 años que había trabajado como maestra desde su graduación.

Mario y Susana dijeron que tenían una excelente relación marital exceptuando el problema de la eyaculación de Mario, el cual eyaculaba apenas entraba a la vagina de Susana, generalmente después de dos o tres impulsos y muchas veces antes de penetrar. La eyaculación precoz había existido desde los comienzos del matrimonio y Mario dijo que había tenido este problema desde su primera relación a la edad de 19 años. Susana informó que ella era orgásmica con la estimulación clitoridea u oral, pero ella no consideraba "normal" tener como forma primaria, esta forma de actividad sexual. Ella había sido capaz de tener orgasmos vaginales con otros hombres antes de casarse con Mario. Susana había tomado la iniciativa en la búsqueda de trata-

miento para los problemas sexuales. No se observó mayor patología durante la evaluación psiquiátrica y la pareja parecía tener una relación cálida y afectuosa.

Había algunos elementos en la historia psiquiátrica de cada miembro y la historia de la relación que podía ser interpretada como indicador de conflictos intrapsíquicos. No obstante, estas cuestiones no fueron tenidas en cuenta durante las sesiones terapéuticas porque sentí que no eran de relevancia inmediata y podían ser pasadas por alto sin perturbar la terapia.

El contrato terapéutico incluyó la comprensión de que el foco del tratamiento era la eyaculación precoz del marido. Enfatizando la necesidad de seguir todas las instrucciones para el éxito e informar a la pareja sobre una estadística de éxito en el tratamiento de este problema. También enfatiqué que los procedimientos discutidos son los únicos exitosos y que son ampliamente utilizados por los terapeutas familiares, urólogos y terapeutas sexuales en todo el país. Mi meta era hacer comprender a la pareja que la prescripción de las experiencias sensoriales y eróticas eran similares a las prescripciones dadas por un médico para la enfermedad física.

PROCESO TERAPEUTICO SEXUAL

La primer entrevista conjunta consistió en la evaluación de la calidad de la relación y los patrones comunicacionales. Las sesiones individuales, durante las próximas 2 semanas se centraron en la historia individual pasada de cada uno, percepción del problema sexual, evaluación del efecto del problema en el matrimonio y en la calidad de la relación conmigo. Le dí a cada uno una información sexual adecuada en el esfuerzo de disipar algunas de sus creencias equi-

vocadas. Todas las sesiones subsiguientes fueron conjuntas.

El tratamiento se focalizó en las percepciones de Mario en el punto de inevitabilidad, las sensaciones que preceden al orgasmo. El método específico utilizado fue la técnica "Stop-Start" (Kaplan, 1974). La pareja generalmente cumplía los ejercicios prescritos. No obstante, hubo algunas sesiones en las que ambos miembros, o uno (usualmente Susana), admitía fracasar en el seguimiento de las instrucciones.

Esta clase de resistencia es indicadora de conflictos intrapsíquicos o maritales que deben atenderse antes de continuar el tratamiento. En este caso la simple confrontación fue suficiente, no hice ningún intento de interpretar material inconsciente, en cambio enfatiqué las consecuencias del rechazo para completar los ejercicios y señalé que ellos eran los responsables de conducir la terapia. Si ellos deseaban aliviar su problema, ellos debían seguir todas las instrucciones.

El tratamiento consistió en 12 sesiones semanales consecutivas y 3 visitas finales separadas por un mes. La pareja informó tener un éxito completo. Mario obtuvo un control eyaculatorio bueno y Susana informó de orgasmos frecuentes durante el coito. En el follow-up, 6 meses más tarde, la pareja informó no tener problemas sexuales.

DISCUSION

Varias técnicas diferentes se utilizaron para tratar efectivamente a esta pareja. Primero se definió el problema específico. Limitando la terapia de esta forma, y al asegurar a la pareja el éxito esperado, se logró la colaboración. Este abordaje aseguró congruencia entre los pacientes y el terapeuta

respecto de la meta del tratamiento.

La terapia en sí misma, fue simple, directa y orientada hacia la tarea. Las tareas específicas fueron diseñadas para llegar fácilmente al éxito, de modo que la pareja experimentara su progreso. Como resultado de ello, las técnicas de la modificación de la conducta proveyeron la terapia necesaria a la pareja. Se dio información sexual adecuada en un contexto abierto, permisivo y de apoyo. Esto apareció como proveyendo a la pareja del insight que ellos mismos podían tolerar. No fue necesario o aconsejable en este caso intentar interpretaciones psicológicas de la disfunción sexual. Prescripciones simples y directas ayudaron a estos pacientes a lograr su meta dentro de las 15 semanas.

RESUMEN

Estos tres casos demuestran los varios factores que los clínicos deben considerar al desarrollar e implementar un plan de terapia sexual. Es esperable que ellos ilustren el rango y clase de factores que deben ser considerados al diseñar estrategias de intervención. Dentro del modelo teórico, el terapeuta debe ser lo suficientemente flexible como para recomendar terapia psicoanalítica individual cuando se hace claro que los conflictos intrapsíquicos deben ser tratados para posibilitar los progresos posteriores. También el terapeuta debe ser sensible a las necesidades de los clientes para los cuales la terapia de insight esté contraindicada.

He llegado a la creencia de que a pesar de la eficacia de las técnicas conductuales sexuales, uno puede errar en la dirección de prescribirlas precozmente o a un ritmo demasiado acelerado. Los problemas sexuales no pueden ser separados de los proble-

mas maritales y frecuentemente no pueden ser separados de los problemas psicológicos individuales. Para que la terapia sexual sea de un valor perdurable dentro de un matrimonio, la relación marital debe ser acrecentada o mejorada. Las cuestiones del ciclo vital marital, tales como los cambios en la dinámica del poder, frecuentemente pueden proveer la clave de la función del problema sexual dentro del sistema.

SUMMARY

With three clinical cases we try to show which are the factors the clinicians should consider when developing or implementing a sexual therapy treatment plan.

We expect to make evident the range and type of factors that must be considered when designing intervention strategies. In this theoretical model, the therapist should be flexible enough to be able to recommend psychoanalytical individual therapy when it's clear that intrapsychic conflicts must be treated to render possible further progress. The therapist must also be sensitive to the client's needs which make insight therapy a contraindication.

We believe that in spite of the efficacy of behaviorist sexual techniques, you can err by prescribing them precociously or on a too accelerated rhythm. Sexual problems cannot be separated from marital problems, and they frequently cannot be seen apart from individual psychological problems. For sexual therapy to have an endurable meaning in a marriage, the marital relationship must be increased or improved with it. Some issues of the marital vital cycle, such as changes in the dynamics of power, frequently can give us a clue as to the function of the sexual problem in the system.

Sistemas Familiares

Directora: Lic. Adela G. García



Algunos de los artículos que publicaremos en los próximos números:

- El trabajo en equipo: instrumento insustituible para la investigación clínica mediante la terapia familiar. Modalidad para favorecer y proteger el potencial creativo.
Mateo Selvini y Mara Selvini Palazzoli
- Constructivismo, autopoiesis y sistemas determinados por problemas.
Harold Goolishian y Lee Winderman
- Efectos adversos de las creencias psicoterapéuticas. Una aplicación de la teoría de atribución al estudio crítico de la psicoterapia.
Ben Furman, M.D. y Tapani Ahola, M.A.
- El problema de los sexos en la teoría de terapia familiar
Rachel T. Hare-Mustin
- Terapia individual sistémica.
Gunthard Weber y Fritz B. Simon
- Un abordaje holístico hacia la experiencia del dolor.
Lic. Doris Suchecki Lewin

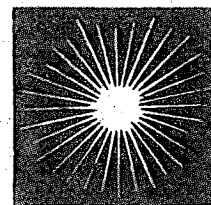
- ☐ Vol I., 1985 (2 ejemplares) U\$S 10.-
- ☐ Vol II., 1986 (3 ejemplares) U\$S 20.-
- ☐ Vol III., 1987 (3 ejemplares) U\$S 20.-
- ☐ Vol IV., 1988 (3 ejemplares) U\$S 20.-
- ☐ Vol V., 1989 (3 ejemplares) U\$S 20.-

¡Suscríbase!

Nombre _____
Dirección _____
Ciudad _____ Estado - País _____ C.P. _____

Suscripciones: consultar telefónicamente.

Juncal 3611 - PB "B" - (1425) Buenos Aires, Argentina. Tel. 804-4231



ISIS

INSTITUTO SISTEMICO
ASISTENCIA • DOCENCIA
INVESTIGACION

Directora: MARIA ESTER PANIZO

Directora Asociada: SARA BOTTA BARCINA

Entrenamiento en terapias sistémicas

- Cursos anuales de formación de terapeutas de 1º, 2º, 3º nivel.
- Seminarios intensivos
- Genograma del terapeuta
- Terapia de pareja
- Cursos especiales para abogados, médicos y psicopedagogos.
- Grupos de investigación

Córdoba 2773 1º D

Cap. Fed.

Tel. 961-3290

El Instituto de Terapia Familiar de Santiago le invita a celebrar el retorno a la convivencia democrática en conjunto con:

- Dr. Donald Bloch
- Dr. Mony Elkaim
- Dr. Humberto Maturana
- Dr. Salvador Minuchin
- Dr. Carlos Sluzki



Congreso Internacional en el tema "LA FAMILIA EN PROCESO DE CAMBIO" del 10 al 13 de Mayo de 1990

Organizadores: Ps. Fernando Coddou, Ps. Carmen Luz Méndez, Dr. Carlos Sluzki

Comité Científico: Dr. Hernán Montenegro, Dr. Fernando Riquelme, Ps. Gloria Kunstmann, Ps. María Gandolfo y Dr. Humberto Maturana

Inscripciones e información:

I.T.F. de Santiago: Asturias 257 Las Condes
Santiago, fono (562) 228 7830
Eliodoro Yañez 2063 of. 407, Santiago
fono (562) 2513176 anexo 361

Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Carlos E. Sluzki, *Palo Alto, CA*

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, *CHRM., Rochester, N.Y.*, Edgar H. Auerswald, *Maui, Hawaii*, Michael Goldstein, *Los Angeles, Calif.*, Reuben Hill, *Minneapolis, Minn.*, Arthur G. Rosenthal, *Cambridge, Mass.*, Robert Ryder, *Storrs, CT*, Margaret T. Singer, *Berkeley, Calif.*, M. Duncan Stanton, *Philadelphia, Pa.*, Carl Whitaker, *Madison, Wis.*

FAMILY PROCESS, in continuous publication since 1962, is the definitive journal in the field of family psychotherapy. Original articles report on theory and practice of family treatment, research and training. In addition, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to reviews of books and audiovisual materials.

Among the many contributors in recent years have been *James Framo, Mara Selvini-Palazzoli, Paul Dell, Carl Whitaker, Bradford Keeney, Cloe Madanes, and M. Duncan Stanton.*

FAMILY PROCESS

149 East 78th Street
New York, N.Y. 10021

Gentlemen:

DATE _____

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS (U.S. funds drawn on a U.S. bank)

INDIVIDUAL SUBSCRIBERS
(paid by personal check)

INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

☐ \$24.00 per year United States

☐ \$35.00 U.S.

☐ \$27.00 per year Canada &
Latin America

☐ \$38.00 Canada &
Latin America

☐ \$30.00 per year All other countries

☐ \$42.00 All other countries

NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____ STATE/COUNTRY _____ ZIP _____

ALL SUBSCRIPTIONS ARE ENTERED ON A CALENDAR YEAR BASIS

Contratos maritales y creencias en terapia de pareja

Psic. ALBERTO GONZALEZ

Co-director del CERF - Centro para el Estudio de las Relaciones Familiares.
Soler 3765 - 4ª "18" (C.P. 1425)

I. INTRODUCCION

En el presente artículo intentaré transmitir mis ideas acerca del concepto de contrato. En mi práctica clínica, este ha sido sumamente útil como articulador entre el nivel intra-personal e inter-personal. Se trata — básicamente— de un concepto instrumental que puede dar cuenta de ciertos procesos y dificultades en la relación de pareja.

También postulo que la explicitación del contrato permite redescubrir el significado —dimensión semántica¹— de los patrones interaccionales. El significado es el tema central de aquellas interacciones que creemos pertinentes para el proceso terapéutico. Cabe aclarar que el concepto de contrato tal como será desarrollado aquí no tiene características reduccionistas. No aspiro o pretendo explicar con él, todo lo que acontece en una relación de pareja.

Por otra parte, intento transmitir una premisa que me ha resultado muy valiosa a lo largo de mi práctica profesional. Además de intentar la resolución del/los problemas presentados o de la disfunción marital, he tratado de facilitar el conocimiento y reconocimiento de las personas que componen la díada. Entiendo que parte de

un problema bastante general es que cierto tipo de modalidades relacionales producen un estrechamiento del campo perceptual de los participantes en esa interacción. Los papeles asignados y mantenidos a lo largo del tiempo por las interacciones recurrentes dejan en la periferia de este campo relacional áreas, recursos potenciales y conductas alternativas de los participantes. Esta restricción de no ser modificada constituye una fuente de empobrecimiento relacional y personal.

Por ello considero que toda experiencia terapéutica es una oportunidad para que esas personas se conozcan más y mejor entre sí. En otros términos; traspasar los límites de los papeles asignados y poder tomar contacto pleno con el otro.

Esta premisa puede ser extendida a nosotros en tanto terapeutas. Cuanto más conozcamos de los procesos interpersonales mejor será la ayuda que podamos brindar. Esto requiere en mi opinión lograr un delicado equilibrio entre los desarrollos de modelos de intervención y lo que muy acertadamente Keeney llama comprensión formal².

Es precisamente en este último sentido que el conocimiento por parte de los miembros de la pareja de puntos nodales y aspectos claves de su propia historia, se integra con nuestra necesidad como operadores terapéuticos de tener acceso a esa información básica.

La reconstrucción del contrato permite así, organizar parte de la historia de esa relación y de sus creencias básicas, así como —circularmente— las creencias actuales sobre la historia. Esta exploración, este recorrido en la dimensión temporal de la vida en común tiene un importante grado de resonancia con las experiencias de los autores y actores de la misma³.

II. CONCEPTO DE CONTRATO

En publicaciones anteriores me he referido a un aspecto central en las relaciones de pareja: en cierta etapa o momento de la relación sus participantes acuerdan o convienen pautas acerca de su propio funcionamiento. Delimitan un territorio propio en gran medida exclusivo e íntimo. Asimismo, una esfera o área personal dentro del ámbito de la intimidad interpersonal. Dentro de este microsistema se asignan funciones, tareas y medios de intercambio.

Parte de estos acuerdos están dados por el marco sociocultural y otros son creados y sancionados dentro de la propia pareja.

Es precisamente esta región o zona de la relación la que voy a desarrollar en este trabajo con el fin de transmitir una guía o mapa para su exploración e intervención.

La importancia de cierto tipo de acuerdo básico había sido expuesta por diversos autores entre los cuales cabe mencionar a Jackson con su concepto de *quid pro-quo*, Watzlawick, Beavin y Jackson con su concepto de definición de la relación; Sager con su concepto de contrato, Willi con el desarrollo del concepto de colusión y Puget y Berenstein con el concepto de pactos inconscientes.²⁵

Diferentes autores de extracciones teóricas diversas podemos converger en este punto sobre este fenómeno básico de las relaciones interpersonales, que posee un alto valor y significado para sus integrantes. Sea que llamemos a este fenómeno acuerdo, contrato, estabilización de la relación o definición de la relación.

En otros términos: puedo suponer que cuando diferentes clínicos e investigadores trabajando con distintos marcos de referencia acuerdan en delimitar un fenómeno de las relaciones interpersonales, es porque

ese fenómeno es constitutivo de aquello que queremos conocer, y no podemos dejarlo fácilmente de lado. Es posible, entonces partir de que en las relaciones significativas ciertas pautas, funciones, intercambios no pueden ser aleatorias, por la misma necesidad de un mínimo grado de predictibilidad de aquellas conductas que hacen a la supervivencia del sistema mismo.

La elección del término "contrato" me resulta adecuada porque describe y connota ciertos aspectos de comportamientos esperables y en parte ineludibles para los participantes de la interacción. Si bien, una o ambas partes pueden violar o burlar algunas de sus cláusulas, esta acción no quedará en estado de impunidad. Cada miembro puede optar, no están mecánicamente determinados a cumplirlo, pero no pueden desviarse de las premisas básicas del contrato, salvo que pretendan o aspiren a salir del marco del mismo (a eso nos referiremos luego).

Como hipótesis central y aclarando que el contrato no es una cosa que está ahí, sino la construcción de un acuerdo y que en terapia de pareja pasa a ser una co-construcción, afirmamos que el contrato "posee", por así decirlo, las siguientes características:

- Es fundante*: como acta que constituye, marca el status de la relación (similar a la función de las constituciones políticas).
- Es axiomático*: son premisas que se establecen y de las cuales no podemos dudar, a las que no podemos cuestionar⁴.
- Es cognitivo*: del nudo argumental del contrato se desprenden marcos o mapas generales y abarcativos.
- Establece una jerarquía valorativa*: instala una escala de bueno-ma-

lo, superior-inferior. Es un microsistema social en el cual se recompensan positivamente las conductas que reafirman expectativas y se castigan (cláusulas punitivas) las conductas que frustran y/o se oponen a las expectativas. Existen grados de desviación tolerables y no tolerables.

- Es tácito*: la fortaleza de las cláusulas contractuales reside en que algunas de ellas están en la oscuridad y en el silencio (a diferencia de los sistemas racionales que deben ponerse a prueba).

A fines de la exploración y uso de los contratos en terapia, el objetivo que me propongo es especialmente trabajar este último aspecto. Intento presentar una guía para construir y explicitar el contrato implícito y básicamente aquellas cláusulas que afectan ahora el funcionamiento de la relación. Diferentes aportes y enfoques han señalado la importancia y el poder enfermante tanto de contenidos "secretos" como de la prohibición de comentar o cuestionar ciertos aspectos de la comunicación (Pichon-Rivière y Bateson).^{5,6}

Como había mencionado en párrafos anteriores los supuestos implícitos poseen el carácter de verdad subjetiva, que se transforma durante algunos momentos de crisis o en algunas relaciones para siempre, en la *verdad*⁷.

Por otro lado, parte de la comunicación íntima se apoya en sobreentendidos. El "dar por supuesto que el otro lo sabe". El deslizamiento del sobreentendido al malentendido es moneda corriente en las relaciones de pareja⁸. Como veremos luego en el uso clínico del contrato algunas cláusulas permanecen inaudibles e invisibles pese al paso del tiempo, y producen ruido en

la comunicación, e insatisfacción para uno o ambos miembros de la pareja, y sin que los mismos sepan exactamente de dónde proviene la perturbación.

En otros términos, algo anda mal pero no se sabe qué es. Al mismo tiempo, si por la regla de prohibición del comentario más la presencia de mitos románticos se desatienden los indicadores de malestar, crece en forma geométrica la probabilidad de que el malentendido se establezca.

III. CONTRATOS INDIVIDUALES E INTERACCIONALES

- Contrato individual*: coincidimos con Sager cuando afirma "Cada integrante de la pareja actúa como si su propio programa matrimonial fuera un pacto concluido y firmado por ambos; cada cual piensa en su propio contrato. Aunque llegue a desconocer partes de él"⁹. Agrega luego: "Así, pues no son verdaderos contratos sino dos conjuntos diferentes de deseos, expectativas y obligaciones."

Cada miembro de la pareja cree que recibirá lo que quiere, a cambio de lo que él le dará al otro¹⁰.

Desde la perspectiva de cada persona el contrato individual incluye:

"Los conceptos expresados y tácitos (conscientes e inconscientes) que posee una persona con respecto a sus obligaciones conyugales y a los beneficios que aspira a obtener del matrimonio en general y de su esposo/a en particular¹¹.

"En verdad, hasta se puede suponer que existe un acuerdo mutuo sobre su contrato, cuando en realidad no existe".

"El individuo actúa como si hubiera un contrato real a cuyo cumplimiento estuviese obligado. Cuando no se cumple ocurre como si hubiere quebrantado el contrato real. Esto ocurre sobre todo cuando creen que han respetado sus obligaciones". Y en cierta medida puede esperar recibir creyendo en que le dio algo al otro (ver luego concepto de estancamiento relacional).

Cuando existe un conflicto matrimonial (agudo o crónico) pero especialmente en la discordia marital crónica (DMC) es clínicamente observable que cada parte actúa o se comporta ignorando las cláusulas de su compañero y en la espera de ver satisfechas sus demandas.

Por otro lado, parte de sus propias demandas no son claramente percibidas por lo cual existe en uno o en ambos cónyuges una insatisfacción importante y no explicitada. De este punto parten, cuando la insatisfacción se prolonga en el tiempo,^{12,13} las formas más insidiosas y peligrosas de la disfunción marital. Cuando los términos del conflicto están a la vista hay mayor posibilidad de colaboración y de intervención.

Expectativas y necesidades (realistas e irrealistas) crónicamente insatisfechas forman un terreno apto para el desarrollo no solamente de una patología vincular severa sino de alto riesgo para la salud mental de los cónyuges y miembros involucrados (especialmente los hijos y en algunos casos miembros de la familia extensa).¹⁴ En mi práctica, una modalidad altamente frecuente es la siguiente:

A espera que B le dé "x".

A "cree" que le dio a B suficiente "y", para que B le dé "x", por lo tanto A no aporta más, se considera con el mérito suficiente.

B considera que le corresponde recibir

"y". B también "cree" que ya dio suficiente "x" a A.

Por lo tanto B considera que ya hizo el gasto o mérito a recibir "y".

Esta situación es de suma importancia en los casos que podemos calificar como parejas detenidas en el tiempo, estancadas, y la considero de alto riesgo.¹⁵

En esta línea de análisis estamos considerando los aspectos estáticos e inmóviles del contrato pero es básico considerar la dimensión temporal del mismo. En el CVF (Ciclo Vital Familiar) y en el CVI (Ciclo Vital Individual) se van incorporando nuevas expectativas y cláusulas que en algunos casos contradicen tanto en el plano interpersonal como en el intra-personal, las cláusulas primitivas. Cuando se superponen cuestiones pendientes en ambos planos las entrevistas diagnósticas son de enorme utilidad como herramientas de discriminación, de distinción, entre los distintos aspectos comprometidos. Frecuentemente y de modo particular en la edad media de la vida, cuando la pareja entra en crisis y se atribuye a la relación de pareja la responsabilidad exclusiva del fracaso personal¹⁶.

Cada miembro de la pareja "coherentemente" se acredita a sí mismo el mérito suficiente para recibir lo que necesita y con mucha frecuencia, por los fenómenos del malentendido y el sobreentendido^{17,18,19} cree haber dado al otro todas las señales necesarias por las que "ya es tiempo que sepa lo que yo quiero", "no pediré más lo que necesito", "me cansé de demandar en vano", y "ya es inútil hablar".

b) *Contrato interaccional*: En cuanto al contrato de interacción coincidimos con Sager que es común, único y en buena medida tácito¹⁹. "Convenio operativo mediante el cual ambos esposos procuran satisfacer sus necesidades"²⁰.

Otra definición, complementaria de la anterior, "el conjunto de convenciones y reglas de conductas, en el sentido de "quid pro-quo"²¹ (Jackson). Reglas en este sentido, abarcan e incluyen las redundancias observables y el modo de definición de la relación.

Como hipótesis de trabajo y en la faz clínica me ha resultado útil la distinción entre definición de la relación y reglas^{22,23}. Reservando para la definición de la relación un papel similar al de contrato. Ambas apuntan a aspectos no directamente observables.

El concepto de contrato implica necesariamente la definición de la relación. Desde esta organización o estructura invisible (trama oculta) y básicamente a partir de su aspecto argumental se arman o tienden las grandes líneas y esquemas de acción²⁴. Desde la perspectiva de los actores de la interacción cada uno asigna al otro un papel indisolublemente amalgamado con su propio papel.

El observador, aún no conociendo la historia de la relación y de las personas, puede hacer inferencias a nivel precisamente de las redundancias observables. Pero, para los actores la asignación está provista necesariamente de valor y significado. Proviene de su propia historia personal y de la historia de la interacción en esa pareja.

Esto último es especialmente importante en aquellas parejas que han convivido durante largo tiempo y en donde la referencia a la historia personal está articulada (—En algunos casos fusionada— con la otra persona en la evolución de la relación). En el curso de las interacciones se ha producido un perfecto encaje al que llamamos acuerdo de base a contrato básico. Esta es la clave para entender

lo aparentemente incomprensible.^{25,26,27}

Este encaje puede ser potencialmente contradictorio y aun ser displacentero pero difícil de cambiar (El "peor es nada"). El mismo presenta una fuerte analogía con las asociaciones o ligaduras estables que se dan en el mundo del cine y del teatro —relación entre texto-director-actor—. La diferencia con la Relación de Pareja es que en estas son los propios participantes los que tienen coreducción-codirección-coactuación.

Como mencionamos anteriormente (punto I) el encuentro de dos personas puede ser por azar (el amigo que lo presenta a la amiga de su novia), la elección de pareja puede responder al fenómeno de la fascinación e ilusión (Espejismo/narcisismo). Pero la continuidad en el tiempo exige para su comprensión explicaciones de un mayor nivel de complejidad. La interdependencia en el tiempo, además de las convenciones culturales y mandatos familiares, sólo pueden explicarse si exploramos el sentido de anclaje y proyecto recíproco que tiene en ambos participantes.

En síntesis postulo:

1) Acuerdo de Base: implícito, anudado generalmente en los comienzos de la relación.

2) Acuerdos y desacuerdos en un nivel más observable o de mayor posibilidad de registro. Tanto para el observador como para los participantes de la interacción.

3) Cuanto más historia en común exista y mayor compromiso emocional, mayor será el esfuerzo para el cambio.

4) De lo expuesto en 3) los fenómenos de resistencia al cambio pueden entenderse como una protección frente a la amenaza de ruptura disgregante.

IV. CONTRATOS Y MODOS DE RELACION

En el marco de mi experiencia he logrado abstraer tres modos de relación que presentan cierto grado de especificidad.

Cabe aclarar que como toda formalización, ésta no es pura sino más bien apunta a destacar ciertas notas dominantes.

Son las siguientes:

1) *Modalidad imperativa*: El contenido argumental básico es dominio-sumisión. Esta descripción recorta la lucha permanente por definir la naturaleza de la relación^{28,29}. Esta tarea, o trabajo si cabe llamarlo así, ha consumido buena parte de la energía de los participantes y ¿por qué no? buena parte de la vida en común²⁹.

En un cierto nivel de descripción la relación es inestable. Desde otro nivel de descripción, como patrón que se mantiene en el tiempo es rígidamente estable. Es una oscilación permanente (Flip-Flop) donde en forma alternada cada miembro logra una victoria o una ganancia ilusoria³⁰. Al mismo tiempo y en forma monotemática cada cónyuge expresa el deseo de romper la relación y retirarse del campo (especialmente lo dicen a terceros).

Cuando acuden, si lo hacen, a la consulta terapéutica, inducen en el/la terapeuta y/o el equipo terapéutico el papel de ser quienes determinen el fin de la relación pero, para sorpresa y desconcierto de los operadores, el juego continúa.

En mi experiencia me han resultado útiles las siguientes hipótesis:

a) Este patrón (rígido) brinda una enorme seguridad. Es intuitivamente predecible: "mi peor es nada" equivale a peor es la nada. (Equivale a estar en pareja).

b) En algunos casos hemos detectado mandatos familiares antidivorcistas (tradi-

ciones y patrones intergeneracionales) estructurados en torno a valores que privilegian mantener la familia intacta: el sacrificio por los hijos, la tolerancia extrema. Como factores de refuerzo: están los beneficios económicos y de status social.

c) La existencia en el comienzo de la relación de grandes expectativas por ambas partes y de sus familias de origen.

d) El fracaso temprano de las expectativas, con la continuación de la relación, en parte por las hipótesis mencionadas, pero además con la esperanza de que el contrato se realice. Esa creencia subyace en mi opinión a la lucha por la definición de la relación. Esta creencia, utópica³¹ en sistemática contradicción con la experiencia real se traduce en la impotencia para disfrutar y construir "años felices" o una suma de momentos felices. El efecto es poseer pocos lugares de anclaje o referentes de bienestar compartidos y, por el contrario pueden exponer con fuerte base empírica infinidad de anécdotas y de pequeñas e ilustrativas historias sobre cómo han frustrado en forma reiterada los mejores deseos de cada uno.

Este contrato es bifronte dado que por una parte se sigue esperando algo que no ocurre^{32,33} en el plano implícito y por otra parte se lucha casi sin cuartel por imponer al otro su deseo y voluntad.

En el plano de las interacciones verbales y no verbales es posible encontrar:

a) *Desvalorización*: "Vos hacés todo mal", "Nada de lo que vos hacés sirve".

b) *Coacción: Amenaza o Punición*: Si no me complacés te puede ocurrir tal o cual cosa, "te privaré" o "te abandonaré".

c) *Negación al otro de su autodeterminación (modelo de violador)*: "No me importa que te guste o no",

"Quiero que lo hagas", "Tomo decisiones que te comprometan pero no debo consultarte" (no tengo por qué darte explicaciones).

En numerosas parejas he podido abstraer esta secuencia típica (él "domina" lo económico, ella lo sexual).

- 1) El insiste en tener relaciones sexuales.
- 2) Se concreta la relación sexual.
- 3) El obtiene su "placer".
- 4) Ella no obtiene su "placer".
- 5) El le reprocha a ella que no participa "realmente": ("Pedazo de carne en la cama", "bofe", "bolsa de papas").
- 6) Ella argumenta que no puede desear a un hombre que la maltrate.
- 7) El no puede vivir con una mujer que "no me haga sentir hombre".

2) *Modalidad-Acercamiento-Alejamiento*

Argumento Central: Desencuentro

Ambos cónyuges, —al menos dentro del marco de mis observaciones— han deuteramente aprendido que la intimidad, trae algún tipo de perturbación. Como ser invasión; pérdida de los límites del self, confusión de identidad; exceso de dependencia. Por otra parte también han aprendido que: cuando la distancia implica frustración, enojo, rabia o cualquier tipo de sentimiento "negativo" la verbalización de los mismos puede desequilibrar la relación y eventualmente poner a la misma en peligro.

En otros términos la forma de "cuidar" la relación es evitar el conflicto. Evitar el conflicto logra mantener la distancia, pero si emergen las necesidades de uno o ambos participantes ese equilibrio puede alterarse. Al no "poder" comentar la frustración, la rabia, etc., el límite o parámetro no es so-

brepasado, con lo cual el grado de desviación es mínimo con respecto a aquellos. La evitación "cobra" el impuesto de la soledad y el vacío.

Desde la psicopatología individual podemos describirlas como dos personalidades fóbicas con un contrato implícito de mantenimiento de la distancia. Una secuencia típica es la siguiente:

- I) A (sin intentar ni culpar) pretende acercarse a B. (A necesita de B).
- II) B toma distancia: su argumento puede ser que no está predispuesto/a en este momento a intimar en las diferentes áreas de la interacción, no sólo en el área sexual y/o no necesariamente en este terreno.
- III) A puede experimentar cierto desconcierto o desánimo, rabia encubierta, dado que si fuera explícita chocaría con B, lo que traería como efecto mantener el contacto, el acercamiento con B. Por lo tanto se aleja (retracción).
- IV) B puede sentir deseos de acercamiento a A. Pueden ser deseos positivos o genuinos o bien de haber sentido culpa y/o pena por la frustración de A. Por lo tanto inicia un movimiento hacia él/ella.
- V) A puede que esté experimentando el efecto de la distancia de B (entendida como rechazo, no deseo, etc.) y no haya todavía "perdonado" a B con lo cual B experimenta a su vez algo similar a lo que anteriormente experimentó A y efectúa su movimiento de alejamiento.

En esta modalidad interactiva las reglas de cortesía impiden el planteo abierto y explícito de la frustración recíproca y la totalidad de la vida en común adquiere un tono grisáceo.

Es fácil advertir que el mantenimiento de este patrón estabilizado en el tiempo tiende a producir un profundo y compartido (aún cuando sea en forma implícita) sentimiento de frustración.

3) Modalidad con Temática de Protección:

Argumento Central: Protección: búsqueda del protector. A diferencia de las modalidades 1 y 2 los participantes presentan en la interacción terapéutica mayor cantidad de señales de insatisfacción. La frustración es más palpable, cabe llamarla o definirlo como síndrome de *impotencia relacional* (a la modalidad 2 cabe llamarla carencia relacional silenciosa).

Existe en ambos participantes una búsqueda más desesperada de protección y afecto al mismo tiempo que el temor (o terror) a experimentar un franco rechazo, o una brusca e irreversible negativa a sus demandas. Los miembros de la pareja arrastran y trasladan a esa relación historias de carencia y soledad.

El deuterio aprendizaje básico ha consistido en ser relativamente ignorados en sus demandas o cuando éstas han sido satisfechas haber recibido un mensaje de pedido de gratitud, pago inmediato o compromiso compulsivo y culpante de devolución (esa expectativa de devolución es cualitativamente y cuantitativamente distinta a la gratitud).

El punto de intersección de estos modelos (siempre que no haya habido transformación) da lugar o tiene como efecto que el contrato implícito puede girar en torno a ser protegido sin que el otro perciba que eso se le pide, a través de una señal subliminal (generalmente no verbal). El contrato implícito de la otra parte puede ser que espere reconocimiento del otro como para po-

der brindar protección. Predominan maniobras de culpa o conmisericordia.

Secuencia protección (protegido)

- 1) El/ella experimenta deseos de ser querido, mimado, cuidado. Produce un indicio.
- 2) El/ella no toma en cuenta el indicio, "no percibe" y sigue en lo suyo.
- 3) El/ella se siente solo, se autoabastece, intenta arreglarse, por su cuenta.
- 4) El/ella lo percibe a él distante, en lo suyo.
- 5) El/ella comienza a experimentar deseos de ser cuidada, etc. Produce indicios. Como ser acortando la distancia física.
- 6) El/ella continúa encerrado/a y envuelto/a o sumido/a en su estado de frustración, lucha interior por ser más abierto/a y por lo tanto pedir o quedarse.
- 7) Finalmente, se dispone a hacerlo pero pide mal, como si al mismo tiempo que pide no quisiera pedir y/o temiera recibir".
- 8) Puede que él/ella sea gratificado/a o satisfecho/a en su pedido pero quizás también "repredido/a" por ser más abierto/a y muy demandante.

V. USO TERAPÉUTICO DEL CONTRATO

En el marco de mi práctica la aplicación del concepto de contrato ha reportado beneficios directos e indirectos. Por una parte la exploración del mismo nos aproxima a las claves o nudos básicos de la relación de pareja permitiendo por lo tanto el diseño de objetivos para la intervención terapéutica. Por otra parte brinda la oportunidad y crea-

ción de un contexto apto para un conocimiento recíproco.

Es muy posible que aquellas parejas que funcionan adecuadamente a lo largo de su ciclo vital, han logrado en forma intuitiva un conocimiento operativo de lo pertinente para su desarrollo. Las parejas que requieren ayuda terapéutica tienen casi la obligación de aprender más sobre su propia historia y el repertorio de sus creencias básicas. Este punto de vista se apoya en mi propia creencia en cuanto a que somos producto de nuestra historia y productores de la misma.

La tarea de reconstrucción y co-construcción del contrato brinda un camino para este conocimiento recuperando la memoria de los sueños fundacionales que le otorgan sentido a esa relación. Crea condiciones para la reconexión y el recontacto con la totalidad de cada persona. Este puede ir de lo mejor de cada uno a lo más bizarro. Pero aun así al proponerlo como una reasunción, un reasumirse, intentamos crear el contexto para la resignificación del papel que cada miembro jugó e hizo jugar y juega y hace jugar en esa relación.

En síntesis:

1) En la construcción de la historia de la relación, entender la historia es entenderse. Ampliar la capacidad de cognición. Pasar de objeto de conocimiento a sujeto cognitivo.

2) Permite una posición "meta" con respecto a la historia.

3) Posibilita la explicitación de los supuestos implícitos y el juego oculto en la relación.

4) Permite el acceso verbal a desilusiones muy profundas (desilusión primaria/primordial).

5) Testeo y prueba de realidad de las cláusulas que han explicitado.

- 6) Diseño del contrato actual.
- 7) Redefinición, propuestas y objetivos.

GUÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO

- A) 1) ¿Cómo se conocieron?
- 2) ¿Qué circunstancias personales y contextuales atravesaban cada uno?
- 3) ¿Cómo acordaron el establecimiento de la relación y su consolidación?
- B) 1) ¿Hubo personas-circunstancias que influyeron en su decisión?
- 2) ¿Como por ejemplo, un embarazo no planeado y/o no deseado?
- 3) ¿Convenciones ético-religiosas y/o presiones sociales y/o familiares?
- 4) ¿Esta unión fue definida "desde afuera"? Si lo fue...
- 5) ¿Cómo marcó la vida en común y la relación?
- 6) ¿Fue incorporada o quedó funcionando en forma excéntrica a la pareja?
- 7) ¿Fue conversada, discutida, comentada? O sea ¿La pareja pudo intentar una reabsorción y por lo tanto una redefinición de lo impuesto (mandato) o se produjo un acatamiento pasivo?
- C) 1) ¿Qué esperaban de la R?
- 2) ¿Qué acordaron básicamente (Explícito/Implícito)?
Él de Ella.
Ella de Él.
- 3) ¿Qué funcionó?
¿Qué no funcionó?
- 4) ¿Qué aspectos o puntos del contrato evaluados posteriormente eran o no realizables?

- 5) ¿En qué medida cada uno puso en juego sus mejores recursos para sí y para el otro?
- 6) ¿En qué etapa, circunstancia, momentos, de la vida en común percibieron que algo no funcionaba bien y en qué áreas?:
 - a) Cambios en un sentido amplio.
 - b) Transformaciones de la familia extensa.
 - c) Nacimiento de hijos.
- 7) ¿Qué intentaron hacer al respecto?
- 8) En un balance:
 - a) ¿Qué consideran que dieron o no dieron al otro?
 - b) Yo esperaba / yo no esperaba. El/ella de Ella/él.
- D) Otra serie de motivos:
 - 1) Cambio de residencia (ciudad, país). Cuando una de las partes no puede menos que aprovecharla porque por ejemplo de ellos depende su carrera, etc.
 - 2) En caso que el cambio haya tenido lugar ¿Cómo fue tomada la decisión?
 - 3) ¿Hubo una discusión clara y abierta acerca de las consecuencias positivas y negativas?
 - 4) ¿Cómo afectaban a uno y a otro, por ejemplo con respecto a las familias de origen (distancia, duelos, rupturas, alteración de las lealtades)?^{34,35}
 - 5) Temas que quedaron sin hablar, etc.
 - 6) De acuerdo al papel que c/u jugaba en su familia de origen hijo/a parental. ¿Cómo la tensión en un polo del sistema cargó al otro?
- E) Cuando la unión de la pareja ocasionó enemistad con la rama sanguínea y/o política ¿Cómo quedó signada la relación?
 - 1) Peleas entre la esposa y la madre.
 - 2) Suicidio del padre.
 - 3) Muerte de uno de los padres en la fecha de la boda o cerca de ella.³⁶

La otra dimensión a tener en cuenta es el modo en que están construyendo la historia y la relación existente entre el relato actual y el cómo del mismo y el contenido aludido o referido al comienzo de la relación (Mito original y orígenes del mito).

Cabe distinguir al menos dos niveles:

- a) Lo que dicen respecto al contrato.
- b) Cómo tratan lo narrado.

Y la diferencia o no diferencia entre a y b (esto permite destacar) a) la vigencia del pasado, b) la rigidez de la creencia acerca del pasado. Cuando existe una pauta prácticamente pura a lo largo de un tiempo prolongado las consecuencias suelen ser peligrosas.

Puede darse combinación de modalidades, en momentos de la historia y del CV (Ciclo Vital) de la pareja. Es un indicador clínico de primer orden para reforzar la hipótesis de un contrato con propiedades rígidas. O equivalente a una creencia rígidamente sostenida de que esa historia fue así y no de otro modo.

Esta parte de la exploración permite, una perspectiva de sí mismos que va logrando en el mismo proceso de conocimiento (intelectual/vivencial. Es un proceso circular en el cual la tarea de conocer a las personas y construir hipótesis sobre la relación va generando y co-generando, modos diferentes de entender, conocer y formular nuevas preguntas.

Esta tarea la había definido en publicaciones anteriores como esclarecimiento y comentario³⁷. Conservo aquí el sentido básico de aquellas definiciones pero integrando una perspectiva más operativa en el nivel interpersonal.

La pregunta no sólo permite recoger información sino que abre una posibilidad para el receptor de pensar y percibir esa relación de un modo novedoso y diferente (efecto de redescubrimiento y de conocimiento recíproco).

Veamos un ejemplo:

T: (a Ella) según Ud. cuando lo conoce a él estaba muy enojada con su familia, y especialmente con su padre. El (padre) había preferido a su hijo varón. Este tema no había sido hablado con su padre.

Ella: Sí, fue siempre difícil la comunicación con él.

T: ¿Cómo y cuánto la afectó a Ud.?

Ella: Estaba muy sola y muy resentida con mi padre.

T: ¿Puede ser que buscara en él un apoyo sólido y de confianza?

Ella: Sí, me daba mucha confianza. Comprendía muy bien todo lo que me pasaba.

T: (a El) Ud. jugó un papel muy significativo en las relaciones entre su padre y su madre. Ud. se oponía y criticaba el modo en que su padre trataba a su madre.

Según su relato él discutía muy frecuentemente con su padre luego de escenas de violencia familiar. O bien intervenía para frenar una escalada de violencia.

Ambos intersectan en un punto. La intersección es de resentimiento y/o rebelión hacia algo injusto.

Ella resentida con su padre (padre prefiere al hijo varón).

El resentido con su padre y protegiendo a la madre (M del joven héroe).

¿Qué argumento pueden tejer? Pueden construir diversas historias pero en este caso el argumento construido fue rescate,³⁸ justicia y en parte despecho.

Esta hipótesis fue confirmada por

ellos. Estuvieron de acuerdo en que la situación de rabia y enojo con la familia de origen de Ella fue una fuerza muy poderosa para concretar la unión.

En el momento de estabilizar su noviazgo ella hablaba muy poco con su padre, prácticamente nada. El por su parte estaba profundamente enojado con su padre y en conflicto entre quedarse (para proteger a la madre) o irse, lo que significaba vivir más tranquilo, casarse y armar su propia vida.

Al cabo de 2 años aproximadamente deciden su casamiento. Ambas familias aceptan la unión pero sin apoyo ni alegría. Ella y él se sienten bien uno con el otro y recuerdan el alivio que les significó salir de sus respectivos hogares. Pese a ello y especialmente El; siguió preocupado por la salud y bienestar de su madre. Ella aumentó aun más la distancia con su padre y hermano y sólo mantenía el contacto con su madre.

Las tensiones no resueltas con respecto a las familias de origen implicaron o favorecieron aun más la cohesión en la joven pareja. El contrato original se estableció en torno a la protección recíproca y a cierta distancia con sus familias de origen.

Aun así, no logran disfrutar de la intimidad y el placer de la vida en común.

Ambos funcionan como protegidos/protectores, preocupados por la salud y bienestar de terceros (especialmente él, y ella siente la soledad de su madre).

En una primera hipótesis sobre el contrato, concluimos que:

a) Ella y él tienen buenos recursos y motivos para el mantenimiento de la relación. (El proyecto era seguir juntos).

b) El contrato inicial sin embargo estaba muy referido a problemas pen-

dientes con los respectivos familiares de origen.

c) Esto implicaba como peligro lo siguiente:

Para él 1) si la situación en la familia de origen tenía una evolución favorable podría llegar a sentir alivio y vacío (perdía su papel de héroe). 2) Si la situación se mantenía estática (vale decir negativa) su preocupación no podría disminuir, por lo tanto mantenía su papel, pero restaba interés o energía a su matrimonio. Tanto en 1 como en 2 el nuevo espacio no podía ser disfrutado.

Para ella:

A diferencia de El, no estaba tan atrapada por la preocupación hacia su madre, pero sentía una fuerte necesidad de demostrarle a su padre y a su hermano sus méritos y realizaciones.

Esta intensa motivación se traducía en una gran productividad aun cuando cada realización estaba acompañada de intensa ansiedad y temor al fracaso, que implicaba como efecto restar energía y tiempo para disfrutar su matrimonio.

Este argumento "elegido" a dúo en el de ambos casos de la GFO y el papel que él y ella desempeñaron en esa estructura, va a desarrollarse en el libreto, éste texto delinearía ciertos movimientos básicos en el interjuego de papeles de ese sistema interaccional. (Parón interaccional).

En otros términos: el nudo básico está en el argumento y se despliega en el libreto. El sentido o parte del sentido de la relación queda marcado, signado por esta clave.

Las estrategias terapéuticas apuntan por un lado a la modificación de los patrones y el interjuego de papeles y por otro a la explicitación y comprensión de las cláusulas básicas.

CONCLUSION

Finalmente, el contrato es un concepto instrumental que permite diseñar hipótesis o serie de hipótesis que amplían el campo de conocimiento tanto para el terapeuta como para los miembros de la pareja.

Este objetivo, el conocimiento, no tiene en lo inmediato una eficacia pragmática. no brinda resultados rápidos ni espectaculares pero permite establecer ciertos referentes, puntos de orientación en un territorio totalmente nuevo. Porque si bien en cualquier aproximación terapéutica aplicamos la experiencia previa, principios teóricos, modelos intermedios, e hipótesis de trabajo, cada pareja ha escrito en cierto sentido una historia única e irrepetible. La aproximación respetuosa a esta construcción es de por sí terapéutica.

Por último, la información que brinda el contrato, integrada a los demás datos clínicos permite la aplicación de diferentes alternativas y técnicas terapéuticas.

RESUMEN

El presente artículo presenta y desarrolla el concepto de contrato marital y su aplicación en la terapia de pareja.

La estructura del contrato se apoya en las creencias y expectativas que cada miembro aporta a esa construcción interpersonal.

Este contrato debe ser realizado, cumplido, llevado a cabo en el devenir de la pareja. Su no cumplimiento y de modo muy especial en lo referente a sus cláusulas implícitas trae dificultades insalvables. Algunas de las cuales han sido expuestas en este artículo.

Asimismo se presenta una guía —su-

maria— para la recolección de información a los fines de la construcción del contrato. La explicitación del mismo permite —en el contexto de la terapia de pareja— su reelaboración y reactualización.

SUMMARY

The present article is intended to expose and develop the concepts of the marital contract and its application in couples therapy.

The structure of the contract is based on the beliefs and expectations which each member brings to that interpersonal construction.

This contract must be made, fulfilled and carried on during the couple's evolution. Insoluble difficulties may occur if it is not fulfilled, particularly regarding its implicit clauses, some of which have been exposed in this article.

A summary guide for the collecting of information in order to rebuild the contract is also shown. Making the contract explicit will allow —in the context of marital therapy— its reelaboration and reactualization.

BIBLIOGRAFIA

1. KEENEY, SILVERSTEIN: *Mapas teóricos en:* KEENEY, B.; SILVERSTEIN, O.: *La voz terapéutica de Olga Silverstein*. Paidós, Buenos Aires, 1988.
2. KEENEY, B.; ROSS, J.: Capítulo I-II. Amorrtu, Buenos Aires, 1987.
3. KENNEY, B.: *Estética del cambio: Las historias vía regia hacia la epistemología:* en capítulo 6. Paidós, Buenos Aires, 1987.
4. BATESON, G.; RUESCH, J.: Capítulo 8: *Las convenciones de la comunicación, cuando la*

validez depende de las creencias, en *Comunicación: La matriz social de la psiquiatría*. Paidós, Buenos Aires, 1965.

5. PICHON RIVIERE, E.: *Clases de la Escuela Privada de Psiquiatría Social*.
6. BATESON, G.: *Hacia una teoría de la esquizofrenia en: Pasos hacia una ecología de la mente*. Ediciones Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1985.
7. BEAVERS, R. W.: *Successful marriage: Capítulo 3. Attributes of the healthy couple*. Norton, New York, 1987.
8. PUGET, J.; BERENSTEIN: *Psicoanálisis de la pareja matrimonial*. Capítulo 5. *El malentendido en la pareja matrimonial*. Paidós, Buenos Aires, 1988.
9. SAGER, C.: *Contrato matrimonial y terapia de pareja*. Capítulos 1, 2, y 3. Amorrtu editores, Buenos Aires, 1980.
10. SAGER, C.: Op. cit.
11. SAGER, C.: Op. cit.
12. JACKSON, D.: en BRICKSON, G.; ROGAN, T. *Family therapy: Family Rules. Marital quid pro quo*. BROOKS/COLE Publishing Company, Monterey, California, 1972.
13. GONZALEZ, A.: *Análisis de la relación de pareja*. Capítulo IV y apéndice. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1979.
14. MINUCHIN, S.: *Familias y terapia familiar. El concepto de triangulación y desviación del conflicto*. Ediciones Gedisa, Buenos Aires.
15. SIMON, F. B.; STIERLIN, H.; WYNNE, L. C.: *Vocabulario de terapia familiar. Concepto de estancamiento relacional*. Gedisa, Buenos Aires, 1988.
16. BEAVERS, R.: Op. cit. Capítulos 6 y 7.
17. SLUZKI, Carlos E.: *Marriage and marital therapy. Paolino I.; Mc CRADY, B. Capítulo 78. Marital therapy from a systems theory perspective* (mind-reading 370-71).
18. BANDLER, R.; GRINDER, J.: *La estructura de la magia*. Capítulo 4. *Encantamientos para el crecimiento y el potencial (especialmente presuposiciones y adivinación o transmisión del pensamiento)*.
19. SAGER, C.: Op. cit.
20. SAGER, C.: Op. cit.
21. JACKSON: Op. cit. *quid pro quo* literalmente "esto por aquello" es una metáfora descriptiva de una relación basada en las diferencias y una expresión de las redundancias observables en las relaciones matrimoniales.

22. WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J.; JACKSON: *Teoría de la comunicación humana*. Capítulos 1, 2 y 3. Editor Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1971.
23. KLIMOVSKY, G.; GONZALEZ, A.: *Seminarios C.E.R.F.: Reglas y organización familiar*. Buenos Aires, 1982-83.
24. ANDOLFI, M.; ANGELO, C.: *Tiempo y mito en la psicoterapia familiar*. Capítulos 2 y 5. Paidós, Buenos Aires, 1989.
25. PUGET, J.; BERENSTEIN, J.: *Concepto de zócalo inconsciente*. Capítulo 8. Op. cit.
26. GEAR, M. C.; LIENDO, E. C.: *Psicoterapia estructural de la pareja y del grupo familiar*. Capítulo 6. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974.
27. WILLI, J.: *La pareja humana: relación y conflicto. Concepto de colusión*. Morata, Madrid, 1985.
28. WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J.; JACKSON: *La lucha por definir la naturaleza de la relación*. Capítulo 3. Op. cit.
29. JACKSON, D. y otros: *Interacción familiar*. Capítulo 6 (Categoría de familias). Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1971.
30. WATZLAWICK, P.; WEAKLAND, J.; FISCH, R.: *Cambio*. Herder, Barcelona.
32. GONZALEZ, A.: *Apéndice*. Op. cit.
33. JACKSON, D.: *Quid pro quo*. Op. cit.
34. KRAMER, J.: *Family interfaces (transgenerational patterns)* Capítulos 1 y 2. Brunner Mazel, Nueva York, 1985.
35. Mc. GOLDRIC, M.; GERSON, R.: *Genogramas en la evaluación familiar*. Capítulos 1 y 2. Gedisa, Buenos Aires, 1987.
36. Corresponden a historias clínicas de nuestro centro.
37. GONZALEZ, A.: Op. cit.
38. Un caso clínico con argumento de rescate está descrito en PAPP, PEGGY: *El proceso de cambio*. (Capítulo 2. *El dilema del cambio*). Paidós, Buenos Aires, 1988.

Carlos Srebrow y Asociados

Asesores en análisis y desarrollo organizacional

CONSULTAS Y ASESORAMIENTO

Pequeña y Mediana Empresa
Empresa Familiar
Asociaciones e Instituciones
Persona y Rol Profesional

GRUPOS DE ESTUDIO

Introducción al Análisis Organizacional - Teoría y Práctica del Análisis Organizacional - Escuelas y Marcos Conceptuales del Fenómeno Organizacional - Empresa y Familia.

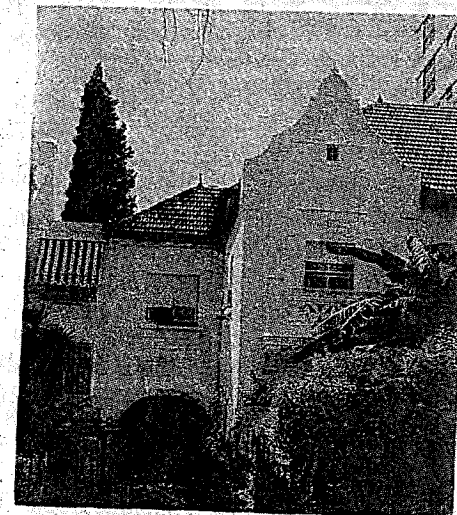
CAPACITACION — ORIENTACION OCUPACIONAL INTERCONSULTAS — SUPERVISION

Avda. Raúl Scalabrini Ortiz 2255 - (1425) Bs. As. - Tel. 72-3866

ditem

clínica
psiquiátrica

DOCENCIA - INVESTIGACION Y TRATAMIENTO
DE LAS ENFERMEDADES MENTALES



ABORDAJE DE LAS DISTINTAS PATOLOGIAS EN UN CONTEXTO
DE COMUNIDAD TERAPEUTICA MULTIFAMILIAR EN
INTERNACION Y HOSPITAL DE DIA CON LA PRESENCIA
DE SUS TERAPEUTAS.

Norberto J. Proverbio - Jorge E. García Badaracco

O'Higgins 2328 - 1428 Buenos Aires -
Tel. 781-0557/1306/7825/1861 - 785-9283

terapia familiar

rivista interdisciplinare di ricerca ed intervento relazionale

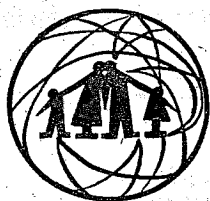
The Journal is published quarterly (March, July, November) by the Rome Family Therapy Institute.

Editor in Chief: M. Andolfi

Editorial board: P. Menghi, A. Nicolò, C. Saccu

Its aim is to promote research and present studies in the following areas:

- ☐ Theory and practice of family therapy
- ☐ Training in family and marriage therapy
- ☐ The individual, the family, social systems and their correlates (schools, neighborhoods, social and health services, etc.) from a systems point of view.



The journal is published in conjunction with:

Family Process, Journal of Marital and Family Therapy, The American Journal of Family Therapy.

The journal, established in 1977, has been the only Italian publication in the field of family psychotherapy. It has always been active in the cultural and scientific debate in this field both in Europe and in America.

It includes contributions by:

H. Aponte, L. Boscolo, D. Bloch, I. Boszormenyi-Nagy, M. Bowen, P. Caillé, G. Cecchin, M. Elkaim, J. Framo, J. Haley, K. La Perrière, S. Minuchin, P. Papp, G. Prata, M. Selvini Palazzoli, H. Stierlin, C. Sluzki, P. Watzlawick, C. Whitaker, I. Zwerling.

One year subscription

Europe:	u.s. \$ 25
Extra-European countries:	u.s. \$ 30

Checks payable to:
I.T.F., s.r.l. - Via Reno, 30 - 00198 Roma

La pareja y sus escenas¹

**CARLOS MARIA Y
MARIA CRISTINA MARTINEZ
BOUQUET**

CARLOS Ma. MARTINEZ BOUQUET
Director del Instituto Argentino de Análisis Bioenergético. Director del Instituto Argentino de Investigaciones Dramáticas.

MARIA C. MARTINEZ BOUQUET
Vicedirectora Instituto Argentino de Análisis Bioenergético. Directora Instituto Argentino de Investigaciones Dramáticas.
Santa Fe 1385 5º (1059) CC. 131 (1448)
Suc. 48 Bs. As. Arg. 42-2090

ESCENAS. APROVECHAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DRAMÁTICAS EN PSICOTERAPIA. DRAMÁTICA.

Somos una pareja y trabajamos con las parejas en coterapia. La mayor parte de nuestra experiencia en tratamientos de pareja y familia la hemos hecho de este modo.

Cuando estamos trabajando nos encontramos en un momento de nuestra vida cotidiana compartida. Ese momento puede comprenderse en función de una escena. En ella, cuatro individuos estamos reunidos en un consultorio: nosotros dos tenemos una función terapéutica, los otros dos han venido a presentar sus conflictos y problemas matrimoniales y traen generalmente un cierto anhelo de solucionarlos. Lo que aquí queda configurado es, pues, una escena, a cuya estructura estamos muy acostumbrados.

Tomemos ahora un caso particular: la primera entrevista con una determinada pareja. Comienza el interrogatorio de los pacientes. Nos cuentan que vienen por fuertes desentendimientos en relación con la educación de un hijo. Ella dice: "Mi marido no soporta que nuestro hijo pueda tener una falla en sus calificaciones. Todos los meses es un drama: el chico llega ya aterrorizado sabiendo cuál va a ser la actitud del padre al fijarse en las notas más bajas; sabe que no va ni a mirar las más altas". Esta mujer nos está relatando una escena que ocurre a veces mientras están sentados a la mesa al mediodía en el momento en que el hijo llega del colegio (escena originaria). Es muy probable que a ella se le presenten en ese momento ante su vista (mental) algunas imágenes de esa escena que recuerda y relata; es casi seguro que sus sentimientos correspondan a dicha escena. Aquí tenemos —pues— una segunda escena, ésta relatada y transmitida por "M"² la mujer de la pareja. Y una tercera, grabada en el recuerdo de "M" (escena propia del individuo), de la que la anterior es una especie de traducción.

A continuación habla "H", el marido: dice que su mujer falsea la realidad, que eso no es de ninguna manera tal como ella pretende. Y comienza una fuerte discusión. Llegamos así a estar ante una nueva escena, actuada ésta por marido y mujer. Podemos ubicarnos nosotros en relación a esta escena en dos posiciones diferentes: "desde el escenario", cuando la fuerza de la transferencia es muy grande y en virtud de ella la pareja nos lleva, nos absorbe hacia el "escenario", a ocupar un personaje; o podemos sentirnos a la manera de espectadores que observan lo que está siendo dramatizado ante ellos. En este último caso miramos como "desde la platea", observamos a la

manera de un espectáculo.

En esta cuarta escena los cónyuges "actúan" (en el sentido psicoanalítico de "acting out"). Es muy útil esta actuación: nos permite comprender, ver y sentir un modo de interacción de la pareja.

Las citadas son escenas de muy diferentes substancias. La primera de todas es la substancia de la vida cotidiana. La segunda es un relato, nos llega en forma de palabras y se refiere a otra escena que escapa a nuestra observación directa, la "escena originaria". La tercera es un registro en la mente de un individuo y aparece como recuerdo.

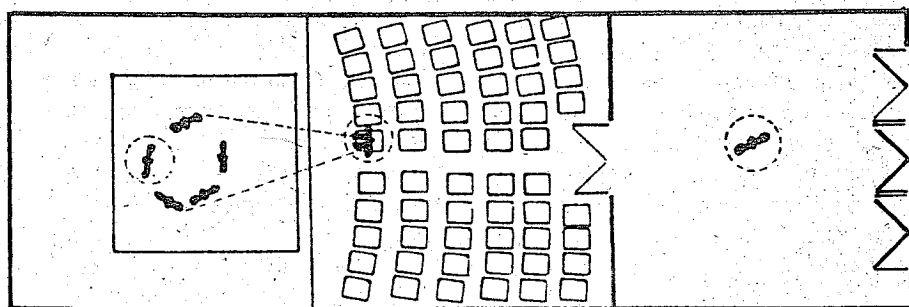
La cuarta es una escena actuada frente a nosotros que nos conviene aprovechar porque nos permite estar presentes en un momento clave de la vida de la pareja. La estructura y el contenido de esta escena probablemente no sea muy diferente de la de otras que ocurren con frecuencia en la casa.

Acabamos de mencionar que nosotros podríamos sentirnos absorbidos hacia el escenario por la fuerza de la transferencia. ¿Qué quiere esto decir?:

Desde el punto de vista de la dramática hay tres posiciones o distancias desde las

cuales uno vive las cosas: en primer término, uno puede estar introducido en la situación, participando muy comprometidamente en ella "desde el escenario"; en segundo término, uno puede estar observando "desde la platea", en este caso nuestra mirada está dirigida hacia el "escenario", pero no se participa tan plenamente; y en tercer término uno puede estar "fuera del teatro", "desde el hall", reflexionando sobre la escena que vió. Son tres ubicaciones muy diferentes. En la primera, cuando uno está "desde el escenario", se experimentan sensaciones, emociones, sentimientos, impulsos, deseos. En la segunda, "desde la platea", uno tiene percepciones mediante los órganos de los sentidos, imágenes, recuerdos, escenas vistas en panorama. En la tercera, "desde el hall del teatro", nuestra mente está ocupada por ideas, reflexiones. Son grados progresivos de distanciamiento sujeto-objeto.

La primera posición, a la que simbólicamente llamamos "desde el escenario", corresponde al modo de funcionamiento del nivel latente. A la tercera posición, la de estar reflexionando "desde el hall", corresponde el modo de funcionamiento del discurso, el nivel manifiesto.



ESCENARIO

PLATEA

HALL

Es cuando la pareja discute acerca de la educación del hijo que nosotros podemos ser arrastrados hacia el escenario, lo que quiere decir que empezamos a experimentar deseos, impulsos, emociones que corresponden a personajes de la escena puesta en juego mediante la actuación; así, en virtud del fuerte tropismo persona-personaje, "caemos" dentro de alguno de los personajes y participamos de manera muy directa en la escena que está produciéndose.

Si la llamada de la transferencia a nuestra participación es menor o si nosotros evitamos comprometernos, manteniendo mayor distancia afectiva, nos encontraremos observando y, preferentemente, se nos presentarán imágenes, recuerdos, conectados con lo que estamos viendo "desde la platea". Si la distancia emocional es aún mayor podremos encontrarnos pensando o reflexionando sobre lo que vemos o hemos visto: estamos situados "desde el hall del teatro".

En el modo sistematizado de psicoterapia de pareja que vamos a describir, luego de las primeras entrevistas llega el momento en que comenzamos a trabajar con dramatizaciones. Es entonces frecuente que, si lo creemos conveniente, le pedimos a uno de los cónyuges que dramatice la misma escena que momentos antes, o tal vez en una entrevista anterior, ha relatado.

Así contribuimos al despliegue de escenas de un tipo diferente de las de los ejemplos anteriores. Estas son escenas producidas con un fin terapéutico, o sea, se trata de un uso instrumental de las mismas.

Son escenas que nosotros proponemos; y participamos en la configuración que ellas han de tomar mediante las consignas que impartimos. En el caso particular a que antes nos referimos la dramatización nos

facilitará, entre otras cosas, comprender mejor el modo en que M experimenta la situación relatada ya en la primera entrevista y conocer así que es lo que esta escena significa para ella.

Con el fin entonces de producir este tipo instrumental de escena le pedimos a la mujer de la pareja que —sin la intervención de su marido— dramatice el momento en que el chico llega del colegio. Ella deberá hacer los distintos papeles. Irá tomando cada uno de ellos, desenvolviendo la situación. Lo que en su mente estaba como escena interna (escena propia del individuo), ahora quedará exteriorizado. Al encarnar ella todos los papeles vamos a tener una más precisa visión de cómo esta escena ocurre en su mundo interno. Esta dramatización, ahora realizada, es un nuevo tipo de escena, un quinto tipo.

Llega un momento, generalmente unas sesiones más tarde, en que trabajamos sobre las relaciones sexuales. Frecuentemente les pedimos —ahora a ambos— que bailen juntos libremente una danza sin música; de antemano manifestamos que esa dramatización va a servirnos para comprender sus relaciones sexuales. Ocurre regularmente entonces que, entre los dos y sin proponérselo deliberadamente, reproducen ritmos de acercamiento, de alejamiento, de atracción, de excitación, de actividad y pasividad, la presencia de inhibiciones, de disfunciones, miedos, etc. Así, contenidos y defensas quedan exteriorizados, lo que nos permite comprender de una manera simbólica y con compromiso afectivo, a una distancia óptima, cómo son sus relaciones sexuales. Es éste otro tipo de escena, un sexto tipo, otro modo de estar presente la estructura dramática. Se trata también, como en el caso precedente, de una producción instrumental.

Recordamos que en un primer momento de la primera sesión habían entablado una fuerte discusión: el marido decía que las afirmaciones de su mujer no eran verdaderas; ella replicaba y así durante un largo rato. Los coterapeutas fuimos observadores de esa escena actuada por ellos; esto nos permitió comenzar a comprender el modo similar (casi con seguridad) en que ese tipo de altercados se desarrollaban fuera del ámbito del consultorio, en la casa, o en otros lugares.

Un momento después, en esa misma primera sesión, se trenzaron otra vez en discusión. Les señalamos que ya habíamos comprendido cómo eran las peleas entre ellos, y seguimos el interrogatorio. Pero, las cosas no terminaron allí, en la segunda entrevista nos encontramos nuevamente con la producción de una situación similar. Entonces les aclaramos que eso era lo mismo que nos habían mostrado dos veces en la primera entrevista, y que una nueva repetición en realidad no ayudaba sino que entorpecía la marcha ágil del tratamiento de acuerdo a la manera que habíamos pactado de trabajar.

Estos "clinchs", tan frecuentes en la terapia de pareja, son tratados —como se verá— en parte con interpretaciones, en parte con señalamientos indicativos de la poca utilidad que prestan para la terapia (apelaciones al encuadre). Después de haber sido provechosos como muestra de la forma que toman estas disputas de la pareja ya no tiene más utilidad la repetición de esta misma conducta, e impulsamos a la continuación del trabajo en una dirección diferente. El resultado de este tipo de intervención terapéutica suele ser a veces, por una parte, una toma de conciencia, un aumento del "insight" acerca de la escena de que se trata y, por otra, puede favorecer la modifica-

ción de rigideces de conducta en las sesiones; si el efecto llega más allá, puede contribuir ocasionalmente a modificar hábitos estereotipados en la vida cotidiana de la pareja.

En caso de que la pareja luego de varios señalamientos e interpretaciones no pueda seguir nuestra propuesta, lo consideramos un importante índice de la intensidad de las defensas, o incluso del grado de enfermedad de la pareja, o de las dos cosas al mismo tiempo. Muchas veces se trata de una defensa en que hay un acuerdo inconsciente de evitar el avance de la terapia, o de que se toque algún tema determinado. Por ejemplo, en este mismo caso, en el momento en que anunciamos que íbamos a trabajar sobre relaciones sexuales reapareció la disputa, en forma arbitraria, traída de los cabellos, con la finalidad inconsciente de la pareja —no simplemente de los individuos— de evitar tocar el tema de las relaciones sexuales.

Hasta aquí nuestro propósito central en lo que venimos escribiendo ha sido mostrar diferentes maneras en que las escenas se presentan en la psicoterapia de pareja. Ha sido una pequeña muestra, ya que su variedad es mayor. Es que, por una parte vivimos inmersos en escenas; por otra, constituimos escenas con los demás; y en tercer término, en nuestro interior se constituyen, conservan y desarrollan escenas. Las escenas atraviesan la barrera del individuo. Dicho de otra manera: el mundo externo y el mundo interno constan de estructuras dramáticas y estas estructuras no reconocen al individuo como límite, lo trasponen. El estudio de las estructuras dramáticas induce a la propuesta de una concepción del mundo para la cual lo intraindividual y lo interpersonal no configuran una categoría principalísima de opuestos, como el sentido co-

mún o el modo habitual de ver nos sugiere.

Se nos podrían tal vez formular algunas preguntas; como por ejemplo: ¿Hay algún beneficio en mirar a la gente y a las cosas en recortes que subrayan la organización dramática"? O tal vez alguien podría decirnos: "—Bueno, sí, es natural, todos sabemos que existen escenas; pero ¿qué hacer con ellas?". Nosotros podríamos contestar desde el punto de vista del psicodrama: "—Se puede dramatizar; eso ayuda a comprender mejor. Beneficiaremos así el proceso de entendimiento de lo que pasa en los individuos, y más aún, lo que pasa en la pareja y la familia; y además agregaremos un instrumento técnico conveniente, enriqueciendo el modo de operar". Esta nos parece una respuesta adecuada; pero tenemos además otra, dependiente de nuestra concepción dramática. Esta concepción sostiene que las estructuras dramáticas no están restringidas a su ubicación exclusiva en las relaciones interpersonales, sino que la trascienden: entendemos que existe una estructura del mundo exterior y del interior que es la estructura dramática y que si se estudian los elementos, las dinámicas, las leyes... de la dramática es posible comprender distintos aspectos de la conducta humana. Por ejemplo, hay regularidades en la producción de escenas: secuencias de escenas rigiendo unas la producción de otras; hay escenas latentes que determinan una y otra vez la emergencia de escenas manifiestas de estructura y contenido siempre similar en la vida de un individuo o de una pareja o de una familia.

TEORIA DE LA ESCENA³

La ciencia Dramática corresponde a un

gran campo disciplinario que espera ser investigado. La Teoría de la Escena es apenas un limitado sector ya elaborado, que comenzó con el estudio de las dramatizaciones en Psicodrama.

Nuestro modo de trabajar se sustenta en primer término en la teoría psicoanalítica y en este desarrollo de la misma, la Teoría de la Escena. Este desarrollo proviene de la observación y estudio de la dramática, y surgió como modo de explicar los fenómenos que se observan en el psicodrama psicoanalítico.

Después pudo aplicarse a la observación de la dramática en las sesiones de psicoanálisis en su forma habitual y de psicoterapia de grupo, y, finalmente, a la dramática de las relaciones interpersonales en general.

La afirmación inicial de la teoría de la escena fue: a toda dramatización (escena manifiesta) subyace otra estructura dramática, la escena latente portadora del significado que atribuimos a la primera. Y pudimos agregar más tarde que la misma estructura subyace a toda relación interpersonal.

Los individuos contienen un acervo de escenas propias, subjetivas, que se han originado a raíz de la elaboración de las experiencias de la vida, son recortes de las escenas latentes en las que se ha participado, corresponden aproximadamente a lo que se conoce habitualmente con el nombre de fantasías inconscientes. Las escenas propias están en el interior del individuo, en su psique y, organizadas en ellas, los personajes, afectos y deseos que las constituyen.

Alguna de estas escenas están en actividad o se activan al entrar el individuo en contacto con otros individuos. En virtud del interjuego entre escenas propias activadas se generan escenas latentes en las relaciones interpersonales, las que tienden a

aparecer de distintos modos a nivel manifiesto, produciendo pensamientos, conductas, etc.

Importa detectar en la pareja y en los individuos las escenas de mayor importancia, las más frecuentes, en particular las escenas conflictivas, que son aquellas que generarán síntomas y sobre las que radicará preferentemente nuestra acción terapéutica.

A diferencia de los tratamientos individuales, a los que el paciente lleva sus escenas propias, recortes de escenas latentes del pasado que han de entrar en interrelación con las del analista para constituir entonces escenas latentes actuales, lo que será el material acerca del cual el analista producirá sus interpretaciones transferenciales —las parejas llegan con escenas latentes ya constituidas desde el momento de pisar el consultorio y algunas de ellas de una gran constancia de repetición—. (Esto establece una diferencia con el psicoanálisis de individuos —se realice éste en forma individual o grupal— y ubica a la terapia de pareja junto a la de familia, de instituciones y de otros grupos preformados).

Si observamos un corte de esa especie de "música" (melodía latente) que se desgrana a lo largo de las sesiones, encontraremos una estructura compuesta por personajes latentes unidos entre sí por puentes afectivos y de impulsos que los interrelacionan: esta es la escena latente. La escena latente es un instante de la melodía latente, como un fotograma es un instante de un film cinematográfico. Todos los que participan de tales escenas contribuyen a su creación, y al mismo tiempo las "habitan". Los individuos "asoman" hacia los demás, sienten y se expresan instalados en los personajes de las escenas, percibiendo los afectos y siendo motivados

por los impulsos y deseos del personaje en el que en un momento dado están ubicados.

En ese nivel los individuos no somos islas, sino que estamos abiertos unos a otros en virtud de nuestra participación en ese imaginario o inconsciente común o grupal, de índole emocional, ocupado por escenas latentes, que todos contribuimos a crear.

En nuestro modo de trabajar, hacemos dramatizar a los individuos que constituyen la pareja una serie de "escenas-tipo" manifiestas que, hemos comprobado, son idóneas para movilizar escenas propias, constitutivas de la estructura de la personalidad del paciente⁴, y escenas de la pareja.

Así, mediante este proceso de actualización o movilización que origina escenas latentes, tenemos a nuestro alcance el material de escenas, en particular las conflictivas, y podemos investigarlo y tratarlo.

Volvamos ahora a la pregunta de qué hacer con todo esto, qué utilidad puede prestar este enfoque dramático, para intentar otras respuestas más específicas:

Veamos una de las consecuencias de tener una comprensión dramática en psicoterapia. Dicha comprensión hace resaltar la importancia de una zona del campo de trabajo: la relacionada con lo que hemos llamado "escena terapéutica". Y veremos que se nos hará evidente el hecho de que es imprescindible preservar la existencia de esa escena durante todo el transcurso de nuestro trabajo. Llamamos escena terapéutica a la escena en la cual existe un personaje latente terapeuta y un personaje latente paciente. Parece ser imprescindible la presencia constante de estos dos personajes para que la situación pueda tener efecto terapéutico. Esto quiere decir que aunque el terapeuta, la persona del (o de los) terapeuta (s),

esté (n) en determinado momento ubicado (s) en un personaje que no sea el personaje terapeuta, si se da la condición que acabamos de señalar, el encuadre terapéutico podrá ser adecuado. O sea, puede estar preservado el encuadre siempre que en la estructura dramática de la sesión esté presente un personaje terapeuta, sustentado por la relación interpersonal, aunque los terapeutas (personas) estén sintiendo lo que ocurre en muchos momentos de la sesión desde otro personaje latente, por ejemplo, el personaje latente "la mujer de la pareja".

La otra condición complementaria es que esté presente el personaje latente paciente en las escenas latentes que se suceden en la sesión, aunque no esté encarnado por nadie en muchos momentos.

Esto sería arduo de explicar hasta hacerlo claramente comprensible sin un desarrollo detallado de la teoría de la escena. Nos limitaremos a decir que lo que en términos psicoanalíticos habituales se designa como buen encuadre, en términos dramáticos puede ser entendido como la existencia de estos dos personajes latentes, predispuestos a ser encarnados, los que repetidamente, en diferentes momentos de la sesión serán ocupados, efectivamente encarnados, por las personas de los terapeutas y los pacientes.

Así la dramática nos ofrece una perspectiva propia acerca de la importancia que tiene un buen encuadre, al mostrarnos cómo el mantenimiento de ciertas características de la estructura dramática latente hacen posible que el intercambio terapéutico y el beneficio terapéutico sean logrados. Entonces, como conclusión operativa: debemos preservar la escena terapéutica, sobre todo teniendo en cuenta que, por el hecho de tratarse de parejas y con el uso de

técnicas dramáticas, la complejidad de la situación aumenta

ABORDAJE TERAPEUTICO

Hecha la anterior introducción general, seremos a continuación más específicos en la exposición de nuestro modo dramático de psicoterapia.

Vamos a describir un modelo de abordaje al que nos aproximamos a veces más, a veces menos en nuestro trabajo: muy sistematizado, es un "desideratum" que vamos desplegando ante la pareja y que a menudo se ve modificado en razón de la problemática o las características de nuestros pacientes. Las condiciones requeridas para cumplir acabadamente el modelo no siempre se dan (más o menos 50% de los casos, en nuestra estadística), porque exige una intensa participación de los pacientes y un yo relativamente fuerte. No es un método con reglas que marquen estrictamente lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer, sino una guía para ordenar el trabajo.

Se trata de un método diagnóstico y terapéutico, pautado, de 15 sesiones de duración, generalmente a razón de una hora por semana, que tiene una base teórica psicoanalítica, más el desarrollo aportado por la teoría de la escena. Emplea técnicas verbales y técnicas dramáticas.

El programa general de trabajo consta de tres etapas:

Primera Etapa: encuentro y primeros contactos; primeros diálogos y obtención de datos; imagen diagnóstica y contrato (establecimiento de una forma acordada de funcionamiento).

Segunda Etapa: Se trabaja en forma sucesiva sobre situaciones clave con técnicas

verbales y dramáticas.

Hay un plan general que es indicativo y que debe adecuarse en cada caso.

El tiempo que se destina a trabajar sobre una determinada zona clave —y si se trabaja o no sobre ella— va a depender de:

- a) que la zona esté más intensamente comprometida que otras por la problemática de la pareja;
- b) que no haya urgencias de la pareja o los individuos que lleven el interés hacia ellas, difiriendo los pasos siguientes del plan;
- c) que haya suficiente yo disponible en los cónyuges como para seguir el activo plan de trabajo.

Tercera Etapa: Revisión cronológica de todo lo ocurrido en las sesiones precedentes y lo trabajado sobre ello (señalamientos, interpretaciones, respuestas, "insights", etc.).

Finalmente damos consejos en cuanto a nuevos pasos terapéuticos, si cabe, y otros consejos. Eventualmente proponemos recontratos, con objetivo y tiempo predeterminados, para trabajar sobre situaciones conflictivas detectadas que requieren más elaboración.

PRIMERA ETAPA

La primera etapa suele desarrollarse en tres entrevistas, a veces se hace necesaria una cuarta para completar los datos, dado que una finalidad de esta primera parte del tratamiento —entre otras— es la obtención de datos. Trabajamos con la pareja en conjunto las dos primeras horas; la tercera hora la dividimos en dos y ambos coterapeutas entrevistamos durante media hora a cada uno de los cónyuges por separado.

La primera entrevista está destinada a:

- Conocerlos y que nos conozcan (presentaciones);
- Tener mutuamente, pacientes y terapeutas, una primera visión unos de otros;
- Establecer los primeros diálogos, con lo que se producen contactos personales que facilitan un mayor conocimiento entre pacientes y terapeutas;
- Obtener y ofrecerles una primera visión diagnóstica;
- Proponer el contrato de trabajo si consideramos —como ocurre en la mayoría de los casos— que ya es el momento adecuado para hacerlo.

Comenzamos interrogando acerca de los motivos de la consulta tanto de uno como del otro cónyuge. Hemos sistematizado la anamnesis con el fin de emplear el menor tiempo posible que nos permita llegar a contar con los suficientes datos necesarios. (Más adelante transcribimos un sumario de dicha anamnesis).

En el transcurso del interrogatorio empezamos a conocer a la pareja y así desde la primera entrevista damos opiniones, hacemos comentarios, señalamientos e interpretaciones.

Prestamos atención a los motivos latentes de la consulta de cada uno de los cónyuges, interrogamos acerca de lo que quieren obtener de este tratamiento y hacemos una aproximación diagnóstica, en particular tratamos de determinar el grado de enfermedad y la fuerza del yo de cada uno.

Buscamos establecer si es adecuado algún tipo de tratamiento de pareja. Y en caso afirmativo, si lo es nuestro método de las 15 sesiones. También intentamos evaluar el grado de interés en el tratamiento y la disposición a colaborar en un tratamiento que exige una participación activa importante

por parte de los pacientes.

También tratamos de evaluar si hay o no segundas intenciones. Mucho de lo anteriormente consignado está directamente relacionado con la conveniencia de determinar las posibilidades que la pareja tiene de aprovechar de nuestra ayuda y el grado de compromiso y sinceridad en el pedido.

En esta primera entrevista hacemos una devolución de las primeras impresiones tenidas sobre la pareja y los individuos. No nos importa en este momento ser muy precisos —aunque muchas veces lo seamos— y mucho menos dar opiniones completas: pueden ser sólo modos de sentirlos, escenas que han evocado en nosotros, que un momento después, o más adelante se aclararán. Pero importa que desde un primer momento haya diálogo, transmitirles lo que hemos podido observar sobre las interrelaciones más salientes entre ellos y con nosotros; a veces, hipótesis diagnósticas; e inclusive comentarios para reubicarlos en el sentido común que puedan haber perdido al estar en un circuito cerrado; el abrirse a otros ya es terapéutico sobre todo en la pareja, ya que la situación de pareja se presta para producir "enquistamientos" entre los cónyuges. Si la terapia no sigue (o, no comienza), al menos habrán recibido esta porción de ayuda terapéutica y esta entrevista habrá sido una experiencia —aunque mínima tal vez— de aprendizaje modificador para la pareja y para los individuos.

Habiendo llegado a la conclusión de que es adecuado nuestro tratamiento de las 15 sesiones explicamos a la pareja este modo de trabajar y proponemos llevarlo a cabo. Si están de acuerdo establecemos un contrato psicoterapéutico.

En otros casos, les aconsejamos los tratamientos que consideramos adecuados:

personal, psicoterapia de pareja pero no el procedimiento de las 15 sesiones, en grupo de parejas, etc.

El momento de establecer el contrato terapéutico suele llegar al cabo de media a una hora. A veces, recién en la segunda entrevista. Mientras tanto hemos ido acumulando datos e impresiones y lo seguiremos haciendo durante la segunda y tercera entrevistas.

En estas entrevistas empezamos a conocer a la pareja. Y como se vio, también hacemos desde un principio señalamientos, comentarios, interpretaciones.

Si la primera entrevista ha resultado satisfactoria en el sentido de haber podido nosotros determinar que sí podemos ayudarlos, y se ha llegado a un acuerdo sobre el tratamiento a seguir, la segunda entrevista se dedicará generalmente a obtener datos.

El comienzo de esta segunda entrevista está marcado por nuestra pregunta sobre cómo se sintió uno en el momento de salir del consultorio la vez anterior. Y cómo, durante el tiempo transcurrido hasta esta segunda entrevista. Nos ilustra con respecto a cómo han sentido ese primer contacto, cómo ha repercutido en sus expectativas. Es útil como índice pronóstico de la relación terapéutica y como guía para un adecuado tratamiento de algunos aspectos urgentes de la situación, particularmente lo que se refiere a la transferencia. Es útil además porque hay una escena que fue y seguirá siendo la primera de todas, a cuyas vicisitudes hay que estar continuamente atentos: "... cuatro personajes estamos reunidos en un consultorio: nosotros dos tenemos una función terapéutica, los otros dos han venido a presentar sus conflictos y problemas matrimoniales y ...".

GUIA DE LOS DATOS PRINCIPALES A OBTENER EN LA PRIMERA ENTREVISTA

Nombre y apellido, edad, teléfonos y direcciones, profesiones y actividades, de parte de quién vienen, el motivo de la consulta de uno y de otro, otros motivos de la consulta, qué quieren obtener de esta consulta, qué esperan de estas entrevistas terapéuticas, qué terapias anteriores han realizado (o actuales). Datos familiares u otros datos que sea necesario conocer de entrada.

EN LA SEGUNDA ENTREVISTA, DESTINADA A RECOGER DATOS, LOS PRINCIPALES ITEMS SON:

¿Cómo se sintió cada uno en el momento de salir de la primera entrevista? ¿Y en los días siguientes hasta hoy?

¿Desean ambos el tratamiento-exploración que les hemos propuesto?

La familia actual, en particular hijos de la pareja (edad, sexo, etc.); los que conviven y los que viven fuera de la casa.

Historia de la pareja:

¿Cuándo se conocieron? ¿Y cómo?

¿Cuándo la primera relación sexual?

¿Cuándo se unieron?

Primera desavenencia o dificultad.

Historia sexual de la pareja.

Historia en cuanto a hijos.

¿Ha habido cambios emocionales, de la interrelación, etc., en el pareja con el nacimiento del primer hijo, u otro?

Historia en cuanto a actividades, lugares de residencia, relaciones con familias de origen, muertes, enfermedades, etc.

¿Ha habido separaciones?

¿Otros matrimonios? ¿Hijos de otros

matrimonios u otras uniones?

Enfermedades, operaciones, accidentes y otros eventos personales importantes.

Incidencia de otros eventos en la pareja.

* Familias de origen padre, madre, hermanos, etc.

Edades, caracteres, ocupaciones, etc.

Lo social, económico, cultural, nacionalidad, etc.

Relaciones con el paciente y entre sí, y con el otro miembro de la pareja.

* Primeros años.

Caracterizar con un término (una palabra o una frase corta) los primeros cinco años de la vida, y los siguientes cinco.

Historia de la educación y actividades

Historia afectiva y sexual.

La tercera entrevista es individual, se compone de dos medias horas en que se ve a cada uno separadamente. En ella investigamos:

* La imagen que cada uno tiene de sí mismo como miembro de la pareja.

* ¿Qué los une?

* Si hay algo que le sea difícil o imposible de comentar estando el otro miembro de la pareja, o que no esté dispuesto, en ese caso, a contar.

* ¿Ha tenido relaciones extramatrimoniales? ¿y homosexuales?

(A veces estas preguntas las hacemos, además, con respecto a si supone tales conductas en el otro miembro de la pareja).

* ¿Objetaría que eventualmente fuera empleado este material? ¿En qué condiciones no habría objeción?

En distintos momentos del tratamiento y por supuesto ya desde la primera etapa, preguntamos:

* ¿Hay algo importante que no hayan hablado?

* ¿Alguna novedad o comentario? (esto es casi una regla al comienzo de cada sesión). Tiene por finalidad ofrecer un espacio de receptividad en este procedimiento, uno de cuyos caracteres es que está fuertemente pautado, para dejar así espacio a las manifestaciones autónomas de los pacientes. Se logra también recibir un informe de lo que ha pasado en la semana, tener un cierto conocimiento de la actualidad, evaluar las movilizaciones individuales y de la pareja producidas durante la semana, sobre todo a consecuencia de la sesión anterior. Permite también llevar un cierto control de las actuaciones (acting-out) si las hay.

* ¿Alguna pregunta? (más generalmente formulada en los comienzos en que los pacientes no están familiarizados con el modo de trabajar y necesitan información y/o pueden permanecer inhibidos sin atreverse a formular preguntas).

SEGUNDA ETAPA: DRAMATIZACIONES. TEMAS CLAVE

La segunda etapa, donde se introduce el uso de dramatizaciones, se inicia generalmente en la cuarta sesión.

Se extiende durante 10 sesiones, lo que generalmente —no siempre— corresponde a 10 horas.

Se trabaja sobre determinados temas clave que son enfocados y activados con la ayuda de dramatizaciones ideadas con ese fin y avaladas por la experiencia. Algunos de estos temas son trabajados regularmente en todas las parejas. Repetidamente hemos comprobado su innegable importan-

cia. Otros son enfocados menos a menudo, o no con tanta dedicación, destinándoles menos tiempo, o siendo sólo conversados y no dramatizados.

Como ya dijimos es la experiencia la que ha servido tanto para sancionar una dramatización como para establecer cuáles temas son clave.

En cada caso deben los terapeutas volver a plantearse la prioridad e importancia de los temas. Y no caer en la rutina de ocuparse en un caso dado de temas que en él no tienen prioridad sólo porque la mayoría de las veces, pero en otros casos, ese tema tiene prioridad.

Este método intenta economizar tiempo. Se requiere hacer constante evaluación crítica de lo que es prioritario. Al cabo de las 10 sesiones con dramatizaciones no llegaremos a ver todos los temas clave. No hay que pretenderlo. Un propósito de primer orden es detectar escenas latentes, que son estructuras que se repiten en muy distintas situaciones de la pareja. Cada tema clave es privilegiado por una parte por la importancia intrínseca que posee y, por otra, porque sirve para sacar a luz una zona de ese tejido de escenas latentes que queremos detectar. Pero una vez que tenemos a la luz parte de ese tejido, tratamos de explorar otras zonas más que reafirmar y extendernos hacia la observación de detalles del hallazgo hecho.

Un ejemplo: en la pareja N.-J. encontramos, trabajando sobre las relaciones sexuales, la necesidad apremiante de cariño del marido (H), que lo reasegura de fuertes y casi constantes sentimientos de abandono. Y en la mujer (M), el rechazo desprecioso de lo que siente como una debilidad (la necesidad de reafirmaciones de cariño) que no le tolera a él como en toda su vida no se ha tolerado a sí misma. Pero esto había si-

do visto previamente, ya habíamos tomado contacto y trabajado con la escena latente correspondiente cuando nos ocupamos del tema clave "Dificultades..." y en "Primera desavenencia".

Es útil la corroboración para fortalecer la imagen que los terapeutas tienen de la pareja; puede ser útil también para el paciente (H), porque convierte lo convincente en ineludible, innegable; y para ella (M) porque resulta algo esclarecedor hasta la evidencia. Pero, dado que nuestra intención es cubrir lo más que podamos el espectro diagnóstico, sacar a luz toda la red de escenas conflictivas e incluso no conflictivas, una vez hecho el "insight" en general dirigimos nuestro trabajo terapéutico hacia otra zona.

Como regla, la primera hora de dramatizaciones (cuarta del tratamiento) y a veces la siguiente también, la dedicamos a trabajar sobre las dificultades de acuerdo a lo que han manifestado uno y otro.

Están advertidos que ese día se inician las dramatizaciones.

Se comienza casi siempre con las preguntas:

T: ¿Qué tal?

¿Hay alguna novedad?

... (si la hay, a veces parte del tiempo, se destinará a trabajar, reelaborando, reubicando, interpretando el material emergente comunicado por los pacientes). Y luego:

T: "Hoy vamos a comenzar con las dramatizaciones. Antes vamos a rever las dificultades por las que cada uno considera que ha venido a tratamiento. Vayan ustedes repitiendo lo que ya hablamos en sesiones anteriores y vamos a ir haciendo dos listas que contengan el "ranking" de las dificultades de la pareja tipificándolas, de acuerdo al punto

de vista de cada uno. Comience cualquiera de los dos a enunciar lo que considera el problema principal".

TEMAS CLAVE

Vamos a pasar revista a los temas de los que nos ocupamos.

- * Dificultades de la pareja (Dramatizaciones sobre los motivos de la consulta)
- * Con qué expectativas, actitud, sentimientos, intensidad, etc. va actualmente cada uno hacia el otro, al encuentro del otro, (Dramatización: el momento en que se conocieron).
- * Desacuerdos básicos (Dramatización: la primera desavenencia).
- * Las relaciones sexuales (Diferentes dramatizaciones)
- * Las raíces inmediatas de los cónyuges (Dramatización: la pareja y los 4 padres).
- * Los deseos fervientes y los impedimentos que se oponen a ellos (Dramatización: la pareja ideal).
- * Expectativas con respecto al futuro (Dramatización: proyección al futuro).
- * La familia (hijos en particular)
- * El nacimiento del primer hijo (u otros).
- * La educación de los hijos.
- * Los individuos y la pareja (las tres entidades y sus interrelaciones).
- * Los componentes simbióticos y de amor objeto.
- * Los componentes masculinos y femeninos en cada uno.
- * La pareja sana y la pareja neurótica.
- * La pareja cariñosa y la pareja rencorosa o destructiva.
- * Embarazos, partos, abortos, infertilidad.

- * Cambios, duelos, desprendimientos.
- * Las frustraciones.
- * La primera frustración.
- * La presencia de terceros (personas, actividades, etc.).
- * Las profesiones, ocupaciones y vocaciones.
- * Lo económico. El manejo del dinero.
- * Las ideologías, filosofías de la vida y religiones de cada uno.
- * Las raíces, en general desde los bisabuelos.
- * Lo adulto y lo infantil en cada uno.
- * ¿Qué será de mi vida ahora que acaba de morir mi cónyuge?
- * ¿Qué será de su vida ahora que acabo de morir?
- * Los distintos intereses (gente y cosas) compartidos o no.
- * Los individuos de la pareja y la molécula social.
- * Relación fantaseada entre la (o el) cónyuge y el (o la) supuesto/a amante.
- * Imagen de la pareja, de la familia y del tratamiento.
- * Imagen del cónyuge.
- * Las familias de origen de ambos y su interrelación.
- * Las generaciones: los abuelos, los padres, los cónyuges y sus hijos.
- * Los momentos de mayor felicidad, de pareja lograda.
- * Los placeres.
- * Exitos.
- * Las interferencias.
- * Los personajes imaginarios o latentes que conviven con la pareja.
- * La dramática de las situaciones complicadas de la pareja.
- * Los derechos de la mujer y del hombre.
- * Recontrato matrimonial.
- * Concordancias, discordancias y otros interjuegos energéticos (con técnicas bioenergéticas).
- * Las distancias confortables (con técnicas proxémicas).
- * Las proyecciones crónicas en el otro.
- * La pareja a distintas edades.
- * Relación de cada uno con su padre del mismo sexo.
- * Relación con todos los antepasados del mismo sexo.
- * Momentos muy significativos del pasado.
- * Supuestos comentarios de las madres y de los padres de ambos (los padres como testigos).
- * Las tres situaciones conflictivas más probables en el futuro de la pareja de acuerdo a cada cónyuge. (Para profilaxis).
- * Las tres escenas más conflictivas, las tres neutras más comunes, las tres más benéficas.

En oposición a nuestro propósito de trabajar sobre estos temas se alzan muchas veces resistencias y dificultades, para cuya solución empleamos, por una parte, interpretaciones; por otra parte, las registramos y evaluamos, ya que las consideramos de importancia en el diagnóstico y pronóstico. En el caso de que estas resistencias nos hayan impedido ahondar algunos temas a los que consideramos imprescindible esclarecer más para un diagnóstico suficientemente completo, así lo comunicamos, y proponemos o no unas horas más para trabajar sobre ello.

Hemos sistematizado una serie de dramatizaciones que permiten, facilitan o enriquecen el abordaje de tales temas. Tedioso resultaría describirlas, y poco esclarecedor. Su ilustración sólo es posible mediante la experiencia directa o la observación de las mismas, como hemos hecho en cursos mediante registros filmados o mediante la

observación o participación en dramatizaciones.

En algunas situaciones realizamos una *sesión en el consultorio con toda la familia*. Y en parejas que nos resulta útil o necesario realizamos una *visita a la casa de la pareja* durante una hora aproximadamente, y en un horario que habitualmente la familia esté reunida.

Nuestra intención es tener una impresión directa de la pareja, de la familia, de los hijos, de la casa. Esta visita la hacemos sin la afectación de un supuesto "papel de analistas", siguiendo aproximadamente en cambio las convenciones habituales del trato social. El resto de la familia ha sido advertida acerca de la visita que vamos a hacer los terapeutas en función del tratamiento de la pareja.

Conversamos sobre los temas que surgen espontáneamente y dejamos todo comentario e interpretación para trabajar en la siguiente sesión.

Entonces comentaremos nuestras impresiones e integraremos lo sucedido al resto del material clínico.

En algunas circunstancias trabajamos *en consultorios separados cada uno de nosotros con uno de los pacientes*, debido a que se ha hecho muy difícil trabajar estando los dos juntos, ya sea porque tienden a repetir violentas peleas sin comunicar nada nuevo, o porque se inhiben fuertemente en presencia del cónyuge, porque forman un sólido frente defensivo, porque es más fácil hablar con el terapeuta del mismo sexo de ciertos temas, porque necesitamos corroborar algún dato que sospechamos no surgiría al estar el otro cónyuge presente.

Cada uno de nosotros trabaja con la misma consigna durante parte de la sesión en otro consultorio y nos reunimos luego del tiempo establecido para comentar en

presencia de los pacientes sobre la entrevista individual.

Compartimos con la pareja lo sucedido, integrándolo a la comprensión de las relaciones de la pareja y muchas veces somos así el puente para establecer una difícil comunicación.

TERCERA ETAPA: REVISION O SEGUNDA VUELTA

Lleva 2 ó 3 horas. Primero pedimos a los pacientes que hagan comentarios sobre todo lo vivido y comprendido durante el tratamiento. Inquirimos luego, a cada uno, si no lo han comunicado espontáneamente. ¿Qué efectos considera que él mismo, su cónyuge y la pareja han experimentado? ¿Qué ha podido comprender sobre sí mismo, su cónyuge y la pareja? ¿Qué temas considera que han quedado sin ser tratados o sería necesario completar? Y, finalmente: ¿Qué consejos terapéuticos u otros darían él y ella a la pareja y a cada uno de los cónyuges?

A continuación comenzamos nosotros la revisión. En forma cronológica hacemos un resumen de todo lo significativo ocurrido, agregando ahora comentarios e interpretaciones actuales.

Resultan de este modo dos niveles: uno, el de nuestras intervenciones hechas en cada sesión y que ahora recordamos; y el otro, comentarios e interpretaciones de segundo grado —digamos— que se han hecho posibles ahora gracias a la visión ampliada e integrada de la pareja y de cada individuo que hemos llegado a obtener con el transcurso de las sesiones.

Nuestro modo de trabajar facilita que se haga patente la repetición en distintas sesiones de ciertas escenas y secuencias de escenas (correspondientes a estructuras de

la personalidad y a la neurosis de los cónyuges, y a estructuras de la relación).

Desde enfoques disímiles como: la pareja ideal, las relaciones sexuales, el momento en que se conocieron, el nacimiento del primer hijo, las relaciones con los padres, hemos podido llegar a una misma estructura, se lo recordamos y —si es posible— lo mostramos (mediante el uso de la video grabación),⁴ proveyendo así una visión integrada agregando un elemento más de evidencia al encadenamiento de situaciones que los terapeutas revisan para ayudar a la pareja a verse más realísticamente.

La constatación y el recuerdo de estas reapariciones tiene un efecto tan contundente que —en caso de no haber ocurrido antes— los pacientes casi siempre llegan ahora a comprender y aceptar aquello que se les muestra una y otra vez en relación con una variada gama de situaciones vividas y dramatizaciones realizadas.

Esto constituye un diagnóstico expresado en términos de escenas: señalamos así cuáles son las principales escenas conflictivas presentes en la pareja. Y también las no conflictivas y las benéficas.

Finalmente damos un pronóstico, si cabe, y consejos: sobre terapia a realizar o de otra índole.

Por ejemplo: "Consideramos conveniente que Ud. inicie una terapia personal con una psicoterapeuta mujer o, tal vez en un grupo de mujeres, donde nos parece útil que vea todo lo concerniente a su identidad femenina; en cuanto a H es muy importante que continúe su terapia individual", O: "Aconsejamos que realicen terapia sexual", O: "Aconsejamos un período de terapia de pareja que podría ser de tres meses, centrada sobre el tema de las rivalidades mutuas y de la educación de los hijos. Algunas sesiones se realizarán incluyendo a

los hijos y haremos una visita a la casa". O: "Dado que han alcanzado una mayor comunicación y al parecer, salvados los malentendidos y ciertos rencores, la pareja puede orientarse hacia una mejoría de la relación, y a una mayor expresión de los sentimientos cariñosos, les decimos adiós, les deseamos suerte y estamos a disposición de ustedes si consideran necesaria alguna nueva consulta más adelante". O: "El mayor de los niños necesita un psicodiagnóstico, de allí resultará si requiere tratamiento o no".

No sólo aconsejamos en cuanto a terapia y como terapeutas; sino que hacemos intervenir nuestra personalidad total en los consejos por una parte y, por otra, damos —además— otra clase de consejos. Por ejemplo: "Es absolutamente necesario que la madre de M. no viva con Uds., si quieren mantener realmente una relación armónica". O: "Sus hijos y Uds. se beneficiarían con más límites: recuerden mantener con llave la puerta del dormitorio de Uds., ellos deben tener claramente señalado dónde detenerse". O: "Nos parece muy conveniente que H. retomé sus estudios y se gradúe, esto puede incrementar mucho sus sentimientos de autoestima, lo que probablemente lo lleve a ser menos cruel consigo mismo, con M. y con todos".

LA COTERAPIA HOMBRE-MUJER

En la psicoterapia de grupo y en el psicodrama, la coterapia tiene bastante años de historia⁶. En la coterapia hombre-mujer dos terapeutas, un hombre y una mujer, conducen el tratamiento.

Son múltiples los beneficios que brinda tal coordinación.

Provee dos perspectivas desde diferen-

tes ángulos, lo que disminuye o hace desaparecer las zonas escotomizadas por cada terapeuta. Las opiniones diferentes, debidas a puntos de vista distintos no perturban los tratamientos; pero es necesario, sí, que se establezca una sola estrategia, y que en el funcionamiento del equipo no sea intensa la rivalidad ni el sometimiento, sino la necesidad.

En estos casos la comprensión resulta del acto de creación conjunto del equipo de terapeutas (y de los pacientes, en el mejor de los casos).

Brinda también la coterapia hombre-mujer la posibilidad de tener —además de la visión del terapeuta del mismo sexo— la visión del terapeuta del sexo opuesto sobre las actitudes y conductas de cada uno de los miembros de la pareja.

Cada miembro de la pareja de pacientes, de acuerdo a pautas personales, establece vínculos con los terapeutas, que pueden servir como índice de sus modos de relación heterosexual, lo que permite comprender a él o a ella y saber sobre las distorsiones de la percepción del otro miembro de la pareja.

Existe facilitación de aspectos de la transferencia del Edipo directo e invertido sobre uno y otro miembro de la pareja. Es más confusa y difícil cuando ambos coterapeutas son del mismo sexo. Es menor el despliegue de la pantalla proyectiva cuando no se trabaja en coterapia hombre-mujer.

El equipo constituido por una pareja hombre-mujer es un ámbito más adecuado para la elaboración post-sesiones de las tensiones contra-transferenciales que no fueron completamente reconocidas durante las sesiones y que, por lo tanto, no llegaron a transformarse hasta ser verbalizadas en forma de señalamientos e interpretacio-

nes en las sesiones.

El hecho de estar en juego tres personas —cuando la terapia es conducida por un solo terapeuta— es propensa a la alianza de dos y a la exclusión de uno; más exactamente: es facilitadora a veces de perturbadoras fantasías sobre alianzas y exclusiones.

Así como consideramos que nos ocupamos de tres entidades: dos individuos y una pareja, el equipo terapéutico lo constituyen también tres entidades. Dos (o tres) son más fuertes que uno sólo para mantener la independencia de criterio frente a las presiones de la pareja de pacientes que en muchos momentos intentará forzar al equipo terapéutico a asumir roles, a ver las cosas distorsionadamente, a detener su acción terapéutica, en virtud de mecanismos defensivos dependientes de la conflictiva que la domina.

Los equipos de coterapia hombre-mujer son más universalmente abarcales, y de constitución más equilibrada que dos coterapeutas del mismo sexo.

Qué nos proponemos

El procedimiento que empleamos tiene finalidad diagnóstica y terapéutica. El diagnóstico abarca a la pareja y a los individuos que la componen y a veces a la familia en totalidad.

Proporciona conciencia de enfermedad tanto de la pareja como de cada uno de los cónyuges.

Activa y enriquece las terapias que paralelamente efectúen los individuos, al movilizar conflictivas personales.

Ofrece la posibilidad de colaboración con los terapeutas individuales. Por corresponder a una visión desde un ángulo

diferente, adecuado para echar luz sobre la pareja, como ocurre en general con toda terapia de pareja, suele poner de relieve aspectos poco visibles en la terapia personal.

Los cambios que esta terapia produce muchas veces se traducen en modificaciones, mejorías o desaparición de síntomas conductuales, en particular de aquellos síntomas que los habían movido a consultar. Asimismo promueve: el "insight" de los pacientes en aspectos personales atinentes a su vida de pareja; la reducción de los malentendidos (oficiando los terapeutas de intermediarios o traductores, trabajando sobre los conflictos de uno en presencia del otro, etc.); la comprensión e integración —cuando es posible— de las diferencias de cultura de sus familias de origen; el conocimiento más profundo de sí mismo, del otro, de la pareja y, eventualmente, de la familia; la reconexión con los factores positivos que llevaron al establecimiento de la pareja; la elaboración y modificación de los factores negativos de unión (simbiosis); la elaboración de la reconciliación, en parejas que estaban próximas al divorcio, cuando se inclinan hacia la reconciliación a causa de cambios sobrevenidos en el transcurso de la terapia; la elaboración del propósito de separarse, si así lo deciden, en vista de la falta de amor y deseo y la existencia de odio y rencores inmodificables; el reconocimiento de las cosas tal como son; la defensa de sus sentimientos de amor, altruistas y nobles; la jerarquización de los aspectos vocacionales, la autenticidad y la creatividad; el reconocimiento de la necesidad del "trabajo de pareja" para el mantenimiento de una relación feliz; la adopción de un modo de vida adecuado al presente en que viven, por ejemplo: que se actualicen transformando modos tribales de convivencia, que lleguen a dar la importancia

que merece el buen trato a los hijos, o el ser buena gente...

Es frecuente que como consecuencia del tratamiento se produzca: la iniciación de terapia personal, que había sido resistida hasta entonces, por parte de uno de los dos miembros de la pareja; la disminución o desaparición de interjuegos neuróticos de la pareja; una reorganización u ordenamiento familiar; una mejoría en la salud psíquica de alguno de los hijos; el "descubrimiento" de los valores del otro, o de la intensidad del amor del otro; el "insight" acerca del propio amor hacia el otro, y/o de la admiración y valoración; la movilización de vocaciones con el consiguiente efecto de disminución de las tensiones de la pareja y la familia...

Algunas leyes que ligan lo discursivo a lo latente o cómo producir las escenas latentes que deseamos a los fines del trabajo dramático o cómo activar determinadas zonas del inconsciente (individual o grupal) mediante dramatizaciones.

Se habrá visto que, en los casos que lo explicitamos, las dramatizaciones con las que se trabaja y las situaciones clave no parecen a veces coincidir. Aunque esto sorprenda en un primer momento, así son las cosas. Poco sabemos acerca de las leyes que relacionan lo manifiesto con lo latente, en particular sobre cómo influir lo latente desde lo manifiesto, y nuestra tecnología es muy pobre cuando nos proponemos activar determinadas escenas latentes⁷.

Sin embargo contamos con algunos recursos pragmáticos, como los siguientes:

1. Producir dramatizaciones que contengan una versión discursiva de lo que buscamos activar;

Es el recurso más frecuente de psicodrama; y es la clave de una técnica psicodramática, la "dramatización simple

de un hecho". Se emplea este recurso cada vez que —ingenuamente⁸— se produce una escena que contiene en el argumento, en la estructura temática, una aproximación discursiva a la escena latente que se busca activar. Nosotros en el tratamiento de parejas infértiles cuando queremos inspeccionar (y tratar) en qué zona o momento se concentra la mayor ansiedad frente al proceso concepción embarazo-parto-crianza, producimos dramatizaciones que corresponden a cada momento de tal proceso; por ejemplo, utilizando las siguientes consignas:

- a. llamada telefónica del laboratorio: el test de embarazo ha resultado positivo; o, el obstetra afirma "tengo que darles una buena noticia, esta vez está embarazada", etc.
 - b. primeros meses del embarazo; ella ha aumentado algo de peso y dice a su marido que siente que el cuerpo le está cambiando.
 - c. en la cama: la mujer, que ha experimentado la primera "patada" del bebé, toma la mano de su marido y se la apoya en el vientre.
 - d. etc.
2. Producir dramatizaciones cuya estructura general sea similar a la de la escena latente que queremos activar y, sobre todo, que contenga un conflicto similar, pero más atenuado, donde hay un cierto desplazamiento; son las dramatizaciones llamadas "simbólicas". Por ejemplo: a una mujer que tiene miedo de hablar de la sexualidad con su marido, se le propone una escena en el que va a dar explicaciones y consejos acerca del sexo a una hermana menor.
3. Se puede evocar recurriendo al uso de una consigna doble una zona del in-

consciente.

Por ejemplo, si decimos a una pareja que lo que van a hacer a continuación va a representar ante nosotros sus relaciones sexuales (primera parte de la consigna) y al mismo tiempo proponemos una acción adecuada: bailar una danza libre, comer, jugar en un parque de diversiones, etc. (segunda parte de la consigna), nuestra afirmación de que vamos a trabajar sobre sus relaciones sexuales a partir de lo que sus actos expresen hará de activador de las zonas inconscientes relacionadas con la vida sexual de la pareja, lo que a su vez influirá sobre la conducta, los actos, los movimientos, los diálogos, de modo que podremos leer o comprender cómo son las relaciones sexuales de la pareja, sus ritmos, la actividad y pasividad de cada uno, el placer, los impulsos y las defensas, etc.

Lo manifiesto será la danza, la comida, etc. Lo latente, aquellas escenas latentes estrechamente relacionadas con las relaciones sexuales.

4. Dramatizar la culminación final de un proceso resulta útil porque suele presentar la escena latente fundamental de todo el proceso.

Un ejemplo de esto es lo que ocurre al trabajar sobre la vocación de cada uno de los cónyuges. La escena de la recepción del diploma al terminar un curso o una carrera activa la escena latente que contiene el conflicto fundamental que dicho curso o carrera presenta para el individuo.

5. Tomando el primer momento de un proceso *tal como es recordado* se reproduce la escena latente propia de la dramática actual de ese proceso. Por ejemplo: si se inquiere a los miem-

bros de una pareja acerca de cuándo se conocieron y se les pide a uno y al otro que refieran su primer recuerdo, lo que vamos a tener al dramatizar uno y otro recuerdo es el modo actual de relacionarse la pareja.

6. Ciertas propuestas de dramatización producen un efecto de decantación o separación y nos proporcionan discriminado y visible lo que antes estaba superpuesto e imposible de ver. Un ejemplo de esto es la técnica de "la pareja ideal", donde aparecen claramente los deseos por un lado y los impedimentos y ansiedades por otro. Para ello proponemos que cada miembro de la pareja sea uno de los directores de una película acerca del amor: "La pareja ideal". Película —decimos— hecha por una serie de directores, cada uno encargado de mostrar en una sola escena corta su visión acerca del tema. Deben desempeñar todos los roles principales de esa producción, salvo el de actores, que estará cubierto por los terapeutas: serán directores, productores, del argumento, guionistas, "cameramen", etc.

Hay correlación entre las escenas y los tratamientos psicoterapéuticos y entre las escenas y el sentido de la vida

Veamos algunos argumentos a favor de las afirmaciones que aparecen en el título precedente:

Ciertas situaciones (escenas) se repiten una y otra vez en la vida de cada individuo.

Cada uno de nosotros sólo es afectado por ciertas escenas, es solamente frente a algunas de ellas que se reacciona, otras pasan sin afectarnos o, al menos, su intensi-

dad puede en situaciones equivalentes variar considerablemente en magnitud de un individuo a otro, o su significado puede diferir mucho según quién sea aquel a quién le toca vivenciarla.

Lo que los psicoterapeutas intentamos detectar y comprender del paciente que entrevistamos por primera vez son sus situaciones (escenas) conflictivas, más allá de ubicarlo en uno u otro cuadro nosográfico y de reconstruir la estructura de sus mecanismos defensivos y su caracterología.

De lo que nos ocupamos en los tratamientos es de escenas conflictivas que el paciente no ha logrado resolver.

Las situaciones transferenciales son escenas del pasado del paciente⁹ conservadas en forma de "escenas propias", que se activan o reavivan, en algunos de cuyos personajes podemos quedar ubicados nosotros (contratransferencia) en forma más o menos fugaz, más o menos prolongada.

Los psicoterapeutas prestamos atención en particular a las escenas conflictivas de nuestros pacientes. Pero éstas —desfavorables, productoras de síntomas y sufrimiento— no son las únicas; también existen otras escenas significativas (vocacionales, placenteras, rutinarias, etc.) que son favorables y productoras de placer o indiferentes.

Empezar a tomar contacto con esa red de escenas, es atisbar el sentido de la vida de un individuo. La red total de escenas significativas corresponde o equivale al sentido de su vida, a todo lo que tiene sentido para él.

La atención dirigida a la trama de escenas significativas de la pareja con la intención de comprenderla más es una de las características de nuestra manera de trabajar.

Tendemos a concebir al ser humano que sufre¹⁰ como constituido por una es-

estructura central buena, con problemas, conflictos, dificultades, incluso malignidades, secundarias. Esto tiene un aspecto práctico importante: vamos confiadamente a la búsqueda de ese núcleo central, cosa que no podríamos hacer con tanta confianza de suponer una malignidad o destructividad inherente al individuo, central o esencial.

Ante la consulta y el subsiguiente tratamiento de una pareja solemos considerar que tenemos como pacientes a cada uno de los individuos y también a la pareja¹¹. Nos parece que será fácil de comprender nuestra posición cuando hablamos de nuestra responsabilidad hacia los individuos, y también de concordar con nosotros. Es necesario en cambio aclarar nuestro punto de vista cuando decimos esto mismo acerca de la pareja. No se trata de un punto de vista ideológico, de índole religiosa, en el que tomamos partido por la no separación a ultranza, partiendo de la idea de que se debería mantener, salvo el caso de muerte, la unión matrimonial una vez concertada. Lo nuestro podríamos decir que es más sofisticado: sostenemos que casi siempre o tal vez siempre en los casos que concurren a tratamiento, la pareja existe, que existe como entidad que posee interioridad, y que esa interioridad es experienciable. Cuando se nos consulta, esa entidad suele estar pidiendo ayuda. Y se la otorgamos, si es que nos parece estar en condiciones de brindarla. El recorte individualista¹² ("lo único verdaderamente existente son los individuos") es erróneo; en consecuencia, además de ocuparnos de los individuos, asumimos el compromiso de dar apoyo a otras entidades existentes.

Este punto de vista nuestro puede ser muy discutido desde el fuerte individualismo con el que nuestra cultura suele mirar la vida humana. El trabajo con dramatizacio-

nes, que hace posible encarnar la pareja como entidad existente, capaz de sufrimiento y goce, relativiza la concepción, demasiado individualista y resulta una ilustración experimental de la presencia ubicua de entidades sensibles no individuales en el mundo humano.

Sin embargo, nuestro punto de vista no implica tratar de mantener la pareja cuando no hay amor, ni atracción, ni otros sentimientos o valores que justifiquen su mantenimiento, o cuando es considerable el daño que los cónyuges se hacen o hacen a otros, hijos por ejemplo, con su convivencia carente de armonía. Como tampoco se justifica el mantenimiento de una unión —pensamos— cuando uno se aprovecha de manera desconsiderada, sádica o sometiendo al otro, que sufre pero que no ve claro, y es incapaz por eso de reaccionar. En algunos de estos casos se impone incluso —pensamos— esclarecer dentro de nuestras posibilidades al cónyuge víctima del sadismo o de la actitud psicopática del otro.

Es la posibilidad de empatía con la pareja, el que en la terapia podamos ubicarnos nosotros y ellos en el interior del personaje "pareja" y experimentar sus sensaciones, sentimientos, deseos, etc., lo que en forma más inmediata justifica y da sentido a nuestro respeto por la dignidad de tales entidades. Desde el momento en que podemos ubicarnos en su interior y experienciarlas, estas entidades son nuestros *semejantes* aún cuando en una acepción considerablemente ampliada del término. Tienen interioridad.

Hacemos una reflexión sobre esta posibilidad de percibir el dolor, el placer, etc. desde dentro de entidades no individuales pequeñas (pareja, familia). El hecho de que sean pequeñas facilita el ejercicio y am-

pliación de una habilidad virtuosa ligada a la función terapéutica, la capacidad de empatía. Así, esta capacidad tiene más posibilidad real de desarrollarse aplicada a entidades más pequeñas que cuando se trata de experimentar desde adentro sentimientos mucho más globales, aplicada a objetivos mucho más ambiciosos, intentando alcanzar empatía universal, amor a la humanidad.

Estos intentos muchas veces se desvanecen, no quedando como resultado sino nuevas abstracciones. Lo que tal vez podría ser evitado, siguiendo un camino escalonado, más realista, cuya primera escala después del individuo fuera la empatía con la pareja.

COMENTARIO FINAL

La psicoterapia de pareja que describimos empezó a tomar forma en 1972. Teníamos la intención de alcanzar un modo de trabajo que, utilizando técnicas dramáticas en forma pautada (Psicodrama Programado) facilitase y acelerase el proceso terapéutico.

Además, comprobábamos a menudo en supervisiones los efectos de una manera de trabajar con parejas que seguía demasiado de cerca el modelo de la técnica psicoanalítica individual, con un resultado no del todo satisfactorio: solían los terapeutas estar demasiado a merced de las resistencias de las parejas, parecían "correr tras ellos" sin iniciativa y con un grado alto de ansiedad. De modo que una estructura, pautando el desarrollo de las sesiones, podría dar mayor seguridad a los terapeutas y carriles a la terapia.

Contribuyó también a la génesis de es-

te procedimiento terapéutico la ambición de contar con repertorios de escenas, en un principio con la idea de facilitar la psicoterapia que se realizaba en instituciones.

Pensábamos también que un sistema no demasiado abierto podía facilitar el co- tejo de experiencias y la investigación.

Suponíamos que un trabajo sistemático, coherente, y en el que a las parejas se les hiciese seguir un proceso similar, podría resultar en la producción de alguna clase de terapia eficiente y de estructura completa en sí misma.

El punto de partida teórico fue el Psicoanálisis y el Psicodrama Psicoanalítico, más el desarrollo que significó la Teoría de la Escena, más la iniciativa de crear repertorios de escenas aplicables a las distintas situaciones psicopatológicas, que constituyó la propuesta del Psicodrama Programado.

Había una dificultad en esta propuesta, hasta ahora no completamente resuelta: es fácil hacer repertorios de escenas manifiestas; pero ya no de las escenas latentes, invisibles, aunque fuertemente vivenciables. De modo que hasta el presente sólo contamos con repertorios de origen pragmático y no nos ha sido posible sistematizar de un modo eficiente la producción de listas de escenas manifiestas útiles basándonos en leyes generales de correspondencia entre escenas manifiestas y latentes.

El abordaje que hemos descrito se ha enriquecido y ha sufrido modificaciones a lo largo de los años y la experiencia. El aprendizaje que hicimos de otros abordajes como el Análisis Bioenergético, agregó una comprensión de la dinámica energética de los individuos y de las relaciones interpersonales. La reflexión de los autores y la inclusión de otros enfoques teóricos, como el de la Psicología Transpersonal,

agregaron amplitud al cuadro general teórico.

Lo que en este artículo resumimos es el estado actual; pero nuestro modo de trabajar está en permanente enriquecimiento, a veces técnico, a veces teórico.

El método que describimos ha sido aplicado en la práctica privada nuestra y de nuestros discípulos, no habiendo sido posible hasta ahora, su aplicación en hospitales, siendo nuestro propósito hacerla a la brevedad.

1. Título de un libro que los autores tienen en preparación.
2. M: mujer de la pareja; H: hombre de la pareja; TM: terapeuta mujer; TH: terapeuta hombre.
3. Ver: MARTINEZ-BOUQUET, C. M., "Fundamentos para una teoría de psicodrama. Contribución a una descripción de lo imaginario", Ed. Siglo XXI, México, 1977.
4. Ver: Teoría de la escena en: MARTINEZ-BOUQUET, C. M., "Fundamentos para una teoría del Psicodrama. Contribución a una descripción de lo imaginario", Ed. Siglo XXI, México, 1977.
5. La videogración es un recurso muy útil; es un espejo cuyas imágenes son muy difíciles de negar, permite a los cónyuges observarse a sí mismos, ser testigos de sus conductas individuales y de las interrelaciones de la pareja desde una posición más distante que en el momento de la sesión en que se hizo la grabación. En nuestro medio el Dr. Carlos M. Martínez Bouquet inició las primeras experiencias de utilización de videogración en psicoterapia (año 1970). Ver: ADAMSON, G., MARTINEZ-BOUQUET, C. M.; SARQUIS, J. A. "Creatividad en Arquitectura desde el psicoanálisis". Ed., Paidós, Bs. As., 1985, pág. 50-51. SOLANAS, J.: "El rostro y el Espejo". Ed. Paidós, Barcelona-Buenos Aires, 1982.
6. Con el nombre de "co-terapéutica" aparece mencionado como uno de los instrumentos terapéuticos valiosos que utiliza el Psicodrama de "Algunos mecanismos de curación en Psicodrama", IV Congreso Latinoamericano de Psicoterapia de Grupo, Porto Alegre, Brasil, 1964, ponencia presentada por Carlos María MARTINEZ-BOUQUET.
7. Por una parte; y por suerte, porque así los usos malignos de la influencia sobre los demás pa-

- ra dominarlos quedan limitados a los recursos relativamente burdos de que hace uso la propaganda (política, comercial, de guerra). Pero por otra, yacen escondidos importantes recursos psicoterapéuticos y socioterapéuticos que serían asequibles con el conocimiento de esas leyes.
8. Decimos "ingenuamente", porque suele confundirse la escena manifiesta que pensamos (de substancia discursiva) con la escena latente, parte de una melodía latente (de substancia latente y complejidad incomparablemente mayor que la discursiva).
9. No discutiremos aquí la participación en las situaciones transferenciales de las escenas propias del terapeuta, las que, sin embargo, son imprescindibles para que se establezca la transferencia.
10. Aunque no negamos —por supuesto— que existen individuos (psicópatas, etc.) cuya patología se caracteriza por hacer sufrir.
11. Por detrás está casi siempre otro personaje o entidad, la familia (hijos en particular) que consideramos generalmente también como paciente.
12. "Individualicista": punto de vista que todo lo centra en el individuo; que centra sus explicaciones en el individuo más allá de lo adecuado.

RESUMEN

Los autores exponen un modo sistematizado de psicoterapia de pareja de breve duración, con el que vienen trabajando desde hace 18 años, y la concepción dramática de la pareja en que se sustenta.

Además del diálogo psicoterapéutico, utilizan dramatizaciones y otros medios técnicos. Repertorios de escenas avaladas por la experiencia (Psicodrama Programado) son empleados para facilitar el tratamiento de las llamadas *situaciones claves* de las parejas.

El tratamiento es conducido por una pareja de coterapeutas hombre-mujer; su rol es ágil y activo. Esta asimismo facilita la participación activa de los pacientes.

Este modo de trabajar permite una aproximación terapéutica cálida y compro-

metida a la pareja y a los individuos que la componen, y al mismo tiempo proporciona mayor seguridad e independencia contra-transferencial.

El programa —"desideratum", en realidad— es de 15 sesiones y finaliza con una revisión general, con posibilidad de recontratos sobre zonas conflictivas detectadas durante las 15 sesiones.

SUMMARY

For eighteen years the authors have been working in a short and systematized type of psychotherapy for couples and on the dramatic conception upon which a couple is based.

Besides using the psychotherapeutic dialogue, they use dramatization and other techniques and, to facilitate the treatment of the so called *key situations* of couples, scenes taken from the repertoire of experience are acted (Programed Psychodrama).

The treatment itself is led by a couple of co-therapists —man-woman—. Their role is agile and active and so is the participation of the patients. This participation is facilitated in every way. It is a kind of approach that allows for a warm and close relationship between the therapists and the couples and the individuals that make them up as well. At the same time this therapy system is designed to ensure independence and security, of countertransference.

Programme "desideratum" actually takes fifteen sessions and ends up with a general revision and the possibility of drawing out a new contract to deal with the areas of conflict detected during the previous fifteen sessions.

BIBLIOGRAFIA

- MARTINEZ BOUQUET, C. M.; *Algunos mecanismos de curación en psicodrama*, IV Congreso Latinoamericano de Psicoterapia de Grupo, Porto Alegre, 1964.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Formas de psicoterapias apropiadas específicamente a determinadas instituciones y tipos de pacientes*, Buenos Aires, 1968-72 (Investigación).
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Psicodrama programado*, IV Congreso Internacional de Psicodrama y Sociodrama y 1er. Simposio Internacional de Psicoterapia de Grupo, Buenos Aires, 1969.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Psicoterapias breves*, Centro de Salud Mental Ameghino, Buenos Aires, 1970.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Técnicas dramáticas con orientación psicoanalítica*, Curso en colaboración con F. Moccio y E. Pavlovsky, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Buenos Aires, 1970.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M.; MOCCIO, F.; PAVLOVSKY, E., *Psicodrama psicoanalítico en grupos*, Ed. Kargieman, Buenos Aires, 1970 (Libro).
- MARTINEZ BOUQUET, C. M.; MOCCIO, F.; PAVLOVSKY, E., *Psicodrama. Cuando y Porqué dramatizar*, Ed. Proteo, Buenos Aires, 1971 (Libro).
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Dialogando sobre coterapia*, II Congreso Argentino de Psicopatología Infanto-Juvenil, Buenos Aires, 1971.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *El psicodrama psicoanalítico y lo imaginario*, Revista Argentina de Psicología, Vol. 17/18, Buenos Aires, 1974-75.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Fundamentos psicoanalíticos de la psicoterapia psicodramática*, Seminario en el Centro de Investigaciones y orientación Enrique Racker de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Buenos Aires, 1974.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M.; FLOREZ MONROY, M. C., *Tratamiento de una pareja infértil con psicodrama psicoanalítico*, Congreso de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, México, 1976.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *La respuesta afectiva de un analista en función de su ubicación en la escena*, Instituto Argentino de Investigaciones Dramáticas, Buenos Aires, 1976.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Teoría de la esce-*

- na, conflicto neurótico y psicopatología, Seminario en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, México, 1976.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Fundamentos para una teoría del psicodrama. Contribución a una descripción de lo imaginario*. Ed. Siglo XXI, México, 1977 (Libro).
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Los afectos en la sesión analítica observados desde el enfoque de la teoría de la escena*, Simposio sobre Afectos en la A.P.A., Buenos Aires 1971.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M.; FLOREZ MONROY, M. C., *Un enfoque diagnóstico y terapéutico de parejas*, Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Buenos Aires, 1977.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M.; FLOREZ MONROY, M. C., *El hijo imaginario*, Sociedad Argentina de Terapia Familiar, Buenos Aires, 1979.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Psicoterapia de parejas. Un enfoque sistematizado de 15 hs. de duración con uso de técnicas verbales y dramáticas*, Revista Temas de Psicología Social, dedicado al VII Congreso Internacional de Psicoterapia de Grupo, realizado en Copenhague, 1980.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Escena terapéutica*, Instituto Argentino de Investigaciones Dramáticas, Buenos Aires, 1980.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M.; FLOREZ MONROY, M. C., *Psicodrama de parejas*, Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Buenos Aires, 1980.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Teoría de la escena. Historia*, en Desarrollos en Psicoterapia de Grupo y Psicodrama, Ed. Gedisa, Barcelona, 1982 (Libro).
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Integración de técnicas en la psicoterapia de grupo*, Centro Racker, Asociación Psicoanalítica Argentina, Bs. As., 1982.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Teoría de la terapia familiar*, II Congreso Argentino de Terapia Familiar, Buenos Aires, 1982.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Psicoprofilaxis de la pareja*, Instituto Argentino de Investigaciones Dramáticas, Buenos Aires, 1983.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Acercas de los significados de la sexualidad*, Asociación Argentina de Sexología, Buenos Aires, 1984.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Insight dramático*, Congreso Internacional de Psicoterapia de Grupo, México, 1984.
- ADAMSON, G.; MARTINEZ BOUQUET, C. M.; SARQUIS, J. A., *Creatividad en Arquitectura desde el Psicoanálisis*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1985, págs. 50-51.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Integración de técnicas en la psicoterapia*, 1ras. Jornadas Patagónicas de Salud Mental y 2das. Jornadas Provinciales de Salud Mental de Río Negro, Viedma, 1985.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Algunos enfoques teórico-prácticos acerca de la creatividad*, Instituto Argentino de Investigaciones Dramáticas, Buenos Aires, 1985.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *La coterapia en la psicoterapia de parejas*, Conferencia en el Departamento de Investigación Psicoanalítica de la Familia y la Pareja de la A.P.A., Buenos Aires, 1986.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *El nivel latente en las culturas*, en Temas Grupales por Autores Argentinos, Ediciones Cinco, Buenos Aires, 1987 (Libro).
- MARTINEZ BOUQUET, C. M.; FLOREZ MONROY, M. C., *Vivir en pareja, vivir en familia. Todo un arte*, Sociedad Hebrea Argentina, Buenos Aires, 1987.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Psicoprofilaxis de la violencia*, Mesa Redonda sobre la Prevención primaria en el adolescente marginado. Violencia individual, familiar y social, en el curso Adolescencia, riesgo y cambio. Aspectos médico-legales. Auspiciado por la Sociedad Argentina de Pediatría y por la División Pediátrica del Hospital Carlos Durand, Buenos Aires, 1987.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Psicoterapia del siglo XXI*, en Temas Grupales por Autores Argentinos, Ediciones Cinco, Buenos Aires, 1988 (Libro).
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Towards new ways of knowledge. A first step: from the orchestra floor to the stage*, X Congreso Internacional Interpersonal, Santa Rosa, California, 1988.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Juegos duros y blandos o de carga y descarga*, Investigación, Creatividad y Arquitectura, Buenos Aires, 1988.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *El origen mitológico de las profesiones*, Investigación, Creatividad y Arquitectura, Buenos Aires, 1989.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *Acercas de la interdisciplina. Divertimento, algunas reflexiones e hipótesis*, Año 2º, Nº 6, Revista Interfas, Buenos Aires, 1989.
- MARTINEZ BOUQUET, C. M., *A beira do novo* (Preguntas y respuestas al filo de lo nuevo), Revista Thot de Filosofía, Nº 51, Ed. Palas Athena, São Paulo, 1989.

PRIMER CONGRESO DE TERAPIA FAMILIAR DEL CONO SUR

Los días 23, 24, 25 y 26 de Agosto de 1990 se llevará a cabo en Cataratas del Iguazú el Primer Congreso de Terapia Familiar del Cono Sur.

Organizado por la Sociedad Argentina de Terapia Familiar y por el Hospital Alvear.

Será presidido por la Dra. Ana Giller y se tratarán los siguientes temas:

- I) Drogadicción y Familia
- II) Violencia Familiar
- III) Actualizaciones teórico-clínicas en Terapia Familiar desde las distintas escuelas. Su desarrollo en el cono sur.
- IV) Aspectos sociales y legales que incumben a la Terapia Familiar

Para mayores informes e inscripción:

Sociedad Argentina de Terapia Familiar 854-2147 / 3140
CHRONOS 49-4646 / 46-3607



Centro
de Estudios
Sistémicos

Taller intensivo:

- Preguntas circulares y reflexivas

Entrenamiento en Terapia Familiar Sistémica

- Teoría sistémica. Escuela de Milán.

Grupos de supervisión

- Orientado a terapeutas con formación y experiencia previa en Terapia Sistémica.

Lic. Adela G. García Directora.

Informes e inscripción: Consultar telefónicamente

Juncal 3611 Pl Baja "B" (1425) Buenos Aires. Tel.: 804-4231

CENTRO DE SALUD MENTAL

Dir. Dr. David Pedro Libedinsky

TERAPIA MULTIFAMILIAR

NUEVA DIRECCION:

LARREA 1162 (1117 - Buenos Aires)

Tel.: 821-5690

3/1989

PSICOBIEETTIVO

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI PSICOTERAPIE A CONFRONTO

Per Ronald Laing
un uomo che seppe comprendere la follia
di Luigi Onnis

LA SCHIZOFRENIA

La psicoterapia dei disturbi schizofrenici
secondo la psicologia analitica
di Giuseppe Maffei e Giuseppe Zanda

La radice relazionale della schizofrenia
di Mara Selvini Palazzoli

Un approccio costruttivista al trattamento della schizofrenia:
schizofrenia come ipotesi
di Giorgio F. Pezzonico e Christine Meier

ARGOMENTI

Il padre di Schreber
di William G. Niederland

L'approccio della psicosi nella esperienza di Soteria:
dal passato al futuro
di Alma Zito Menn

ESPERIENZE

PSICOTERAPEUTICHE NEI SERVIZI PUBBLICI

Descrizione di un modello di intervento terapeutico
su pazienti psicotici in una struttura pubblica territoriale
di M.E. Casula, A. Fenelli, I. Izzì-Trenti, L. Pecci, R. Rossi

Alle drastiche contrapposizioni, concettuali e pratiche, tra modelli psicoterapeutici
differenti, sembra oggi sostituirsi una più attenta ricerca di punti di contatto e di con-
vergenza, nel rispetto delle reciproche diversità.

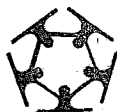
Alla costruzione di questo terreno di confronto *Psicobiettivo* si propone di dare un
contributo e di destinare il proprio spazio.

ABBONAMENTO 1990
Periodicità quadrimestrale (6 numeri l'anno)
Italia: ordinario £ 40.000
Sostanziale: £ 100.000
un numero: £ 16.000
VERSAMENTI sul conto corrente
postale N. 51966000 intestato a:
CEDIS - Via F. Dezza 52, 00197 Roma

cedis
edrice

INSTITUTO DE LA FAMILIA

Centro de Docencia, Investigación y Asistencia en Terapia Familiar
Director: Dr. Carlos María Díaz Usandivaras



CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN TERAPIA FAMILIAR

A cargo de Carlos M. Díaz Usandivaras y colaboradores.

CURSO REGULAR DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO DE TERAPEUTAS FAMILIARES

I Año -	Espistemología y Teoría de la Técnica	CURSO
II Año -	Entrenamiento en Técnica y Clínica	BASICO
III Año -	Clínica, problemas especiales en módulos mensuales independientes	COMPLEMENTARIO
IV Año -	Supervisión Clínica	AVANZADO

CURSO CLINICO EN MODULOS MENSUALES

Crisis y familia	Familias del re-matrimonio.
Problemas escolares de niños y adolescentes.	Depresión, biología, familia y pareja.
Problemas generales de la adolescencia.	Familias con miembros discapacitados.
Adolescentes en alto riesgo.	Pueden curarse independientemente
Crisis marital y divorcio.	

CURSO INTENSIVO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO DE TERAPEUTAS FAMILIARES

A cursarse en cuatro módulos de una semana (50 horas) cada uno.

ABIERTA LA INSCRIPCION

Acassuso 907 - San Isidro (1642) Tel. 743-8645/0797



Centro de Estudios de la Persona

Directoras:

Lic. Berta Sperber

Lic. Eva Waldman

Grupos de Autoafirmación para:

- la mujer
- el varón
- la pareja
- los padres

Asesoría multidisciplinaria social-legal-psicológica para:

- crisis matrimonial
- crisis familiar
- filiación

Terapia pedagógica:

- individual
- grupal
- pareja
- familia

Investigación, intercambio y docencia para:

- profesionales
- docentes



Arenales 1630 1º "A" T 41-6055 (1061) Cap.

Los celos. Un ejercicio en constructivismo sistémico*

CARLOS E. SLUZKI

Jefe, Departamento de Psiquiatría, Berkshire Medical Center, Pittsfield MA 01201 USA; Profesor de Psiquiatría, Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts.

* Una versión previa de este artículo apareció en inglés en *The Family Therapy Network* 13(3):53-78, 1989.

Cuando Dios creó el mundo, lo pobló con todas las especies incluyendo, casi como una ocurrencia de último momento, a Adán y Eva, quienes convivían plácidamente con las otras criaturas del Paraíso. La primera pareja amaba a su Creador incondicionalmente. Dios, con todo, comenzó a sentirse incómodo con este amor sin rivales. "El amor debe ser el resultado de una elección libre", se dijo, "y no el producto de la ausencia de alternativas. Quiero que *quieran* amarme, no que simplemente me amen porque no hay nadie más a quien amar." Para aplacar sus dudas, Dios generó en medio del Paraíso un árbol que produjo frutos prohibidos e instruyó a una serpiente a que tentara al par. Adán y Eva, ingenuos como lo eran, comieron del fruto y se enamoraron violentamente el uno del otro. Se miraban todo el tiempo, se tocaban cuando podían. Se encontraban totalmente fascinados con su recíproca presencia. Se desesperaban cuando no podían estar juntos. Dios, curioso, comenzó a ponerlos a prueba. Los llamaba en voz muy baja y ellos parecían ni

oírlo, cuando antes resonaban a Su más mínimo susurro. Los bombardeaba con órdenes caprichosas y los veía responder con remoloneos, en tanto que antes habrían obedecido instantáneamente. Peroraba: "¿A quién amáis más?", y las voces del par hesitaban un instante antes de responder, mientras que antes sus gritos vibrantes se habrían destacado en medio de la respuesta al coral de las bestias del Paraíso. Hasta que excedieron su umbral: cierto día el Creador notó que, antes de unir sus voces al coro, se guiñaron un ojo de complicidad.

Así fue como Dios, inundado de celos, los expulsó para siempre de su jardín.

En nuestro mundo post-edénico, los celos han sido considerados consecutivamente de tres maneras: 1) como una experiencia interna, un drama intra-personal con consecuencias interpersonales; los celos han sido así discutidos en términos de cómo los siente la gente (usando un lenguaje fenomenológico/experiencial) o en términos de recuerdos de la historia personal que permitan organizar las experiencias tempranas en términos de celos (una exploración genético-dinámica usando un lenguaje psicodinámico); 2) con el advenimiento de la óptica sistémica, como manifestación de una pauta colectiva, un drama interpersonal co-dirigido y co-actuado por dos (o más) personajes; y 3) aun más recientemente, como una práctica lingüística, como una tradición narrativa, es decir, como una manera de hablar y de pensar acerca de procesos interpersonales. Los celos pueden ser así discutidos como una historia producida conjuntamente por los participantes en el contexto de transgresiones acerca de acuerdos previos sobre lealtades y sobre fronteras personales y relacionales.

Tanto la práctica lingüística que llamamos celos como su experiencia subjetiva y

sus pautas interactivas tienen sin duda ciertas raíces culturales. Algunas culturas tienden a favorecer más que otras la generación de narrativas de celos, dependiendo de si la cultura valora derechos individuales o colectivos, relaciones propietarias o no-propietarias, o cuanto enfatiza las diferencias de derechos y privilegios según sexo. Dependiendo del grado de penetración del lenguaje de los celos en la macro-cultura que acota la acción así como en la micro-cultura del medio familiar, los celos pueden jugar un papel menor o mayor en la manera en que los niños aprenden a describir y organizar sus experiencias emocionales y sus relaciones. Una vez que el individuo ha aprendido a organizar, interpretar y describir eventos en términos de celos, el lenguaje y las pautas así descritas tienden a mantenerse en la percepción del individuo mediante justificaciones históricas post-hoc tales como la descripción por parte de adultos acerca de dramas de infancia—"Cuando era muy pequeño, mi mamá tuvo otro hijo, del que yo tenía celos terribles", o "Todos preferían a mi hermana", o "Nadie me quería en casa." Por cierto, las múltiples posibles experiencias penosas de la infancia centradas en soledad, abandono, malos tratos e injusticias pueden ser organizadas en la adultez para interpretar un conglomerado de emociones, que pasan a ser llamadas "celos" mientras reciben la bendición agregada de un contexto histórico de justificación. Pero esta interpretación individual debe ser legitimada por otros, que también juegan un papel en el guión producido colectivamente. De hecho, el lenguaje de los celos coloniza fácilmente al otro miembro de la pareja, generando pautas interactivas auto-perpetuantes.

Si bien celos implica la existencia de un tercer personaje—un amante, la mamá, un

perro faldero, aun un carácter imaginario—, ese drama fundamentalmente contiene dos personajes. ¿Cómo se desarrollan los celos en una relación? Un miembro de la pareja, criado en un medio familiar y social que legitimó una descripción de mapas emocionales y relacionales en términos de celos, comunica a su pareja posesividad, derechos propietarios, desconfianza y la sospecha de que la otra persona ha violado acuerdos mutuos acerca de intimidad. Si la otra persona se coloca a su vez en ese mismo campo semántico, la descripción se legitima: aun una protesta de inocencia o una discusión acerca de la anécdota que permite probar lo infundado de la acusación implica una aceptación de las premisas subyacentes. La pareja establece de esa manera la pauta interactiva, consensual y recíproca de los celos. Esta pauta configura una profecía auto-cumpliente, y como tal tiende a auto-perpetuarse. No existe escape de este círculo vicioso, excepto a través de una escalada lo suficientemente intensa como para destruir la relación, o mediante la intervención de terceros.

En su primer libro *Naven*—un clásico de raigambre antropológica del año 1936—, Gregory Bateson propuso clasificar a las relaciones diádicas en simétricas o complementarias. Relaciones simétricas son aquellas en las que los intercambios interactivos tienden a ser equivalentes en términos de poder, valor o signo: por ejemplo, un saludo respondido con otro saludo configura un intercambio simétrico; una acusación celosa seguida de una contra-acusación celosa constituye una *legitimación simétrica de los celos*. En relaciones complementarias, por otra parte, los intercambios son desiguales, a veces polarmente opuestos, tales como, por ejemplo, un saludo deferente al que se contesta con una inclina-

ción menor de cabeza, o una bofetada seguida de un gemido. Una conducta de aplacamiento en respuesta a una acusación celosa constituye una *legitimización complementaria de los celos*.

HISTORIA NATURAL DE LOS CELOS EN RELACIONES COMPLEMENTARIAS

La retórica organizativa de los celos puede ser introducida como práctica lingüística y legitimizada muy al comienzo de una relación. Una paciente me comentó que cuando fue a su primera cita con quien acabó siendo su pareja estable durante varios años, eligió vestirse de manera más bien llamativa y comportarse de manera un tanto seductora, cosa que ella supuso (tal vez siguiendo algunas sugerencias de él, o indicios culturales) lo complacería. El le elogió su arreglo, pero ya en esa misma cita comenzó a dar señales de irritación porque otros hombres la miraban demasiado, y la acusó de ser demasiado insinuante, y de flirtear con otros a la distancia. Ella malentendió sus protestas como expresiones de amor, y comenzó a aplacarlo, declarándolo único destinatario de su afecto e ignorando activamente a los otros hombres. Este comportamiento, que de hecho lo aplacó, fue a su vez considerado por él como una expresión acabada de amor de ella. Finalmente, la respuesta de él—el aplacarse—fue interpretada por ambos como una expresión de amor de él. Esa secuencia adquirió un lugar central en la relación. Cuando, durante períodos de calma entre tormentas relacionales, ella le reprochaba sus celos excesivos, él los justificaba arguyendo que durante su infancia sus padres siempre prefirieron a sus hermanos—el padre a su her-

mana mayor, y la madre al hermanito menor— lo que lo sensibilizó a los celos. Ella le aseguraba tiernamente que nunca tendría causas para sentir celos con ella, lo que una vez más legitimizaba el lugar central de los celos en su relación. De esta manera, el lenguaje y las pautas de celos y aplacamiento adquirieron un lugar privilegiado en la relación, ocupando mucho del espacio reservado habitualmente a una variedad de expresiones de amor. La relación comenzó a deteriorarse visiblemente cuando la declinación predecible del primer deslumbramiento generó en él un incremento de las exigencias de exclusividad propietaria, lo que la llevó a intentar aplacarlo más a través de distanciarse de los pocos contactos personales fuera de la pareja—incluyendo amigas— que aún mantenía. Esto la colocó en una posición de extrema dependencia en términos de tener que contar con él como fuente de todo nutrimento emocional. Como resultado, y dado lo restringido del repertorio de esta pareja, cuando ella necesitaba nutrirse emocionalmente se comportaba de modo que generara en él una explosión de celos a la que se seguía el aplacamiento y la aceptación. A su vez, cuando él se sentía carenciado emocionalmente, favorecía indirectamente en ella ciertas conductas que le generaban celos (y sino, las alucinaba), a lo que seguía las expresiones de celos y el consiguiente aplacamiento preventivo, comportándose, por ejemplo, en una reunión social, de modo de señalar claramente desconexión de todo hombre excepto su pareja. Pero esa misma posición de alerta para evitar incidentes potenciales así como su disposición a aplacarlo constantemente simplemente reforzaban en él la impresión de que había buenas razones para sentirse celoso... ad infinitum.

El deterioro progresivo de esta estruc-

tura de relación es casi inevitable: la expresión de celos pierde rápidamente su "valor nutritivo emocional" como equivalente de amor dada la intensa ira que la acompaña, que se disuelve sólo luego de las secuencias aplacatorias. De hecho, muchas veces el comportamiento aplacatorio sólo conduce al alivio de que la violencia contenida en los celos se ha mitigado. A su vez, esta falta de nutrimiento afectivo aumenta las probabilidades de que la persona celada de hecho comience a buscar fuentes de afecto en otra parte, completando así la profecía auto-cumpliente: el texto de los celos acaba por generar su justificación. A su vez, la persona celosa participa desde una posición de ira, lo que reduce su receptividad a los comportamientos afectuosos, cosa que a su vez contribuye a aumentar su frustración y su experiencia de no ser querido.

Como puede notarse, las pautas interactivas generan y mantienen el contexto en el que se aloja la narrativa de los celos, y, a su vez, las prácticas lingüísticas reconstituyen a las pautas interactivas.

HISTORIA NATURAL DE LOS CELOS EN RELACIONES SIMÉTRICAS

Contrastando con la configuración complementaria celoso/aplacador, puede darse que los miembros de la pareja se alojen en roles y utilicen prácticas lingüísticas recíprocas semejantes —tal vez provengan de familias en las que los celos hayan sido principios organizativos y retóricos al que tienen acceso ambos sexos en posiciones celosas y aplacadoras, según las circunstancias. En ese caso, puede darse que, muy temprano en la relación, se establezca una

pauta simétrica: ambos se otorgan derechos de expresar celos y ambos lo hacen. A su vez, la respuesta es una contra-queja celosa, y el resultado es una escalada de acusaciones o bien un intercambio de protestas recíprocas de inocencia. No infrecuentemente, estas secuencias terminan en tórridas sesiones amoratorias, ya que en muchas parejas así organizadas las acusaciones celosas recíprocas y las conductas aplacatorias pueden ser descritas como una forma de cortejo o seducción.

En relaciones con pocos conflictos adicionales, estos diálogos pueden agregar intensidad al vínculo y proveer señales necesarias acerca del compromiso recíproco. Con todo, esta pauta sólo retiene funcionalidad si el repertorio interactivo de la pareja contiene medios de neutralizar las escaladas antes de que lleguen al punto de la violencia física o emocional, es decir, si contiene algún sube-y-baja de complementariedad recíproca (alternando la posición del celoso) o una simetría bien calibrada (ambos igualmente celosos a la vez). Una paciente me comentó que la armonía de su pareja —en la que los celos recíprocos eran la regla— colapsó estruendosamente cuando ella descubrió que su marido de hecho la estaba engañando con otra mujer. Hasta entonces sus intensas interacciones celosas (las quejas de uno a la otra, las protestas de inocencia, las contra-acusaciones, todo en un marco de cierta volatilidad) ocurrían dentro de un marco de buena fe, y con el supuesto a priori por parte de ambos de que las sospechas carecían de fundamento. Una vez que descubrió el affaire del marido, la paciente se sintió doblemente engañada. No sólo él le había sido infiel, sino que le había robado a ella su igualdad en la relación —a menos que ella organizara a su vez un affaire, cosa que no se sentía motivada

de hacer excepto tal vez para reestablecer el equilibrio de poder.

CONSIDERACIONES TERAPEUTICAS

En resumen, los celos pueden ser entendidos como una narrativa y práctica facilitada por nuestra cultura y utilizada por cierto número de parejas para organizar y otorgar sentido a múltiples experiencias emocionales. En algunos casos en donde acababan siendo considerados como atributo intrínseco del "vivir en pareja", los celos son una temática incorporada tempranamente que tiende a colonizar la relación. En algunos otros, los celos hacen acto de presencia narrativa e interactiva ocasional como señal de alarma cuando algún acuerdo de la pareja acerca de fronteras y pertenencia se encuentra en riesgo de ser transgredido.

Las parejas celosas concurren a la consulta habitualmente cuando los celos ya han invadido buena parte de la narrativa de la relación —frecuentemente, para ese entonces los comportamientos que derivan "razonablemente" de los celos a su vez han puesto en riesgo la relación o la integridad física de al menos uno de los participantes.

Desde su propio marco de referencia —dentro de los confines del guión, por así decir— los celos son intratables. Muchas de estas parejas, en efecto, han perdido la capacidad para hablar acerca de la relación y las emociones y necesidades recíprocas excepto en términos de celos. Para iniciar un cambio sustantivo, los terapeutas deben colocarse fuera del marco de los celos y ayudar a la pareja a descubrir descripciones alternativas de su situación.

Como regla general, las parejas envueltas en transacciones predominantemente

simétricas tienden a responder más fácilmente a descripciones simétricas, incluyendo re-encuadres globales tales como (en una pareja cuya vida en común comenzó cuando ella quedó embarazada, sin haber transitado, por lo tanto, por un período de calibración recíproca tal como un noviazgo): "Vuestra relación es especial en el sentido de que se ha desarrollado pasando por alto algunos pasos en el desarrollo habitual de la mayoría de las parejas. Tal vez no tendrán más remedio que hacer algunos deberes con retraso." A su vez, las relaciones predominantemente complementarias tienden a responder mejor a intervenciones que mantienen una descripción complementaria, tal como una re-puntuación de la secuencia de sucesos: "Pareciera que Ud. —A— le está enviando mensajes a Ud. —B— acerca de cuando debe hacerlo(a) sentir celos, y Ud. —B— es demasiado considerado y obediente como para desobedecer."

En las relaciones celosas pero estables la erupción de un conflicto de celos puede permitirnos proponer la hipótesis de que la pareja ha perdido un *mecanismo restrictivo de neutralización de la desviación* que previamente les permitía prevenir escaladas más allá de un umbral de seguridad. En la búsqueda de esa "válvula de seguridad" perdida, el terapeuta puede descubrir, por ejemplo, que desde que la pareja se mudó a una casa más pequeña han perdido esa habitación extra a la que uno de ellos se podía retirar ocasionalmente para "contar hasta diez" —un recurso que puede que ni siquiera sabían que usaban. el definirlo así, con todo, permite desarrollar alternativas creativas en términos, por ejemplo, de crear un "espacio para aislarse" en la nueva casa. A la inversa, ciertos conflictos interpersonales que eclosionan en celos aparecieron

cuando la familia se mudó a una casa más grande, lo que permitió a uno de los miembros de la pareja replegarse por largos períodos de aislamiento resentido en otras habitaciones en lugar de verse forzados a resolver activamente conflictos, como no tenían más remedio que hacer en el espacio más restringido de su casa anterior. O tal vez uno de ellos cambió sus horarios de trabajo, lo que redujo el tiempo en común que utilizaban para nutrir su intimidad; aun antes de darse cuenta del empobrecimiento de su contacto, el vacío resultante comenzó a rellenarse con sospechas celosas.

Todo cambio significativo de circunstancias puede reducir el repertorio de salvaguardias de la pareja, al tiempo que proveer argumentos justificativos del conflicto en aumento. Un cambio en las distribuciones tradicionales de roles, en la predictibilidad de la rutina, o en la naturaleza de la red interpersonal, puede desequilibrar una relación. Una pareja, por ejemplo, consultó a raíz de violentos celos por parte del marido que hicieron su aparición cuando la mujer comenzó su carrera como intérprete de música folklórica. Sus quejas celosas, que en un comienzo adquirieron argumentos existenciales, principistas y sexistas que asombraban a ambos miembros de esta pareja de la "contracultura", pudieron centrarse en el hecho que sus programas conjuntos de fines de semana pasaron a estar supeditados a las oportunidades un tanto erráticas que ella tenía de actuar en público. El conflicto de celos se aplacó dramáticamente cuando instalaron una pizarra en el hall central de su casa en la que ella anotaba sus compromisos musicales con tanto adelanto como le fuera posible. Esto reintrodujo un ritual de cuidados por parte de ella así como cierta predictibilidad en la vida en común de la pareja, a la vez que per-

mitió al marido la posibilidad de planificar por adelantado sus propios fines de semana "libres". En otra pareja, un acceso violento de celos por parte de la mujer condujo a una confrontación en la que primero ella salió de la casa, furiosa e informando al marido que se iba a acostar con el primer hombre que viera por la calle, pero retornó al poco rato sin haber cumplido la amenaza, y, en vez, lo atacó físicamente, dejándolo bastante maltrecho. La exploración de la ecología de esta pareja precediendo a la eclosión de los celos produjo el siguiente panorama: ambos habían sido durante muchos años miembros de una secta evangélica fundamentalista, de la que él comenzó a ser segregado a raíz de una confrontación con su vecino, uno de los dirigentes de la secta; durante los últimos tres años ella mantuvo como red principal la secta mientras él fue aislado activamente por todos; en un esfuerzo para romper su ostracismo social, él estableció relaciones de amistad con cierto número de compañeros y compañeras de trabajo, que se transformaron en su red personal, a la que su mujer tenía poco acceso, ya que las interacciones ocurrían fundamentalmente durante las horas de trabajo; ella lo acusó de tener un "affaire del alma" con una compañera de trabajo, él rehusó aplacarla y se encerró en un silencio ofendido, cosa que confirmó para ella su hipótesis, y así se entronó la trama celosa alrededor de lo que fue un movimiento de equilibración —tal vez con sobretonos vindicativos— de las redes. La revisión de la historia con esta pareja a predominancia simétrica (que se había entrampado en una narrativa complementaria) permitió devolverles una discusión íntima acerca de necesidades emocionales y lealtades que les reintrodujo respeto mutuo y anclaje afectivo.

CELOS: ENCUADRE Y CIRCUNSTANCIAS

La discusión acerca de la experiencia subjetiva y la pauta interpersonal "celos" puede ser enriquecida con una nueva visita a la Sagrada Historia, esta vez citando literalmente la Biblia, más específicamente, el Primer Libro de Moisés:

Fue Abel pastor y Caín labrador; y a cabo de tiempo hizo Caín ofrenda a Yavé de los frutos de la tierra y se la hizo también Abel de los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ellos; y agradóse Yavé de Abel y su ofrenda, pero no de Caín y la suya.

Se enfureció Caín y andaba cabizbajo; y Yavé le dijo: "¿Por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? ¿No es verdad que si obraras bien andarías erguido, mientras que, si no obras bien, estará el pecado a la puerta? Cesa, que él siente apego a ti, y tú debes dominarlo a él." (Sagrada Biblia. Traducción Fuster y Colunga. Biblioteca de Autores Cristianos. 7ª Edición - Madrid 1957 - Génesis: 4 - 1 a 19)

Permítaseme parafrasear este fragmento: ambos hermanos ofrendaron a Dios el fruto de sus respectivos trabajos, el pastor sus corderos, y el agricultor sus granos. Un movimiento acabadamente simétrico: cada uno presentó a Dios el fruto de su esfuerzo. Y ¿cuál es la respuesta del Dios del Génesis? Elogia a uno y desprecia al otro. No es de extrañar que Caín, perplejo, se haya quedado de una u otra manera: "¿Por qué tratas a mi ofrenda con desdén y a la suya con aprecio?" A lo que Dios respondió que esta queja —instigada por su movimiento— encerraba un pecado. Aun más, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, Dios implica en su admonición a Caín: "No hay nada inapropiado en Mi favoritismo. Si sientes algo como resultado de Mis acciones, TU

eres el inapropiado." Lejos de aplacar a Caín, esta descalificación sólo sirvió para exacerbar sus sentimientos. Caín, por cierto, podría haber negado sus emociones —"Dios tiene razón, no siento celos"— o su razón —"Dios tiene razón, estoy loco." Podría también haber descalificado la Fuente, así como la Fuente lo descalificó a él —"Dios no sabe lo que está diciendo", y aun podría haber destruido a la Fuente de su dolor. "Dios no existe". Sin embargo, Cain, como tantos otros seres humanos, actuó hasta sus últimas consecuencias su papel en esta trama preordenada: ennegrecido por los celos, mató a su rival en el amor de Dios.

Una de las moralejas de esta historia es que si uno de tus hijos expresa celos por alguno de sus hermanos o hermanas, probablemente está denunciando el hecho de que de hecho estás prefiriendo —por el momento al menos y con o sin razón— al otro. Si te enojas con el celoso, estás de hecho replicando en tu comportamiento tu preferencia por el otro y sólo atizando el fuego —ya que los celos tienden a organizarse en profecía auto-cumpliente. ¿Que qué puedes hacer en cambio? Puedes, por ejemplo, reconocer tu preferencia, al menos circunstancial, por el otro, y simpatizar con el celoso, prediciendo que habrá tiempos mejores. Tal vez esto genere una experiencia de celos menos tóxica e invasiva y, quien sabe, tal vez permita aun prevenir un asesinato.

Los personajes que participan en una narrativa de celos se perciben como totalmente atrapados por la trama, aun cuando, sin saberlo, son también co-autores. Una conversación terapéutica les puede ayudar a descubrir narrativas alternativas, tramas y escenarios diferentes que les permita percibirse como autores de sus propias vidas.

Los terapeutas, considerados hasta no hace mucho oráculos capaces de revelar a los pacientes su verdadera historia, merecen ser descritos un tanto más humildemente como co-autores de las nuevas tramas que describen en forma alternativa la vida de los pacientes. Aun más (¿aun menos?), puede que la descripción más actual de la actividad de los terapeutas sea una de facilitadores creativos, expertos en favorecer el contexto adecuado para permitir a los pacientes generar *ellos mismos* sus nuevas narrativas y sus nuevos dilemas. Los terapeutas, autores en una época y luego co-autores, están transformándose poco a poco en meta-autores, Pirandellos del consultorio.

RESUMEN

Desde una perspectiva constructivista se presenta un modo de entender y operar sobre los celos. Estos pueden ser descritos como pauta interactiva, como práctica lingüística y tradición narrativa. A su vez, está articulada en la macrocultura.

Cuando el individuo ha aprendido a organizar, interpretar y describir ciertos sucesos en términos de celos, el lenguaje y las pautas tienden a mantenerse en la percepción del individuo apoyadas en sus propias justificaciones post-facto.

En el marco de las relaciones interpersonales los individuos tienden a establecer asociaciones con personas que frecuentan

el mismo campo semántico construyendo así un recíproco y compartido contexto de justificación. Utilizando las categorías de G. Bateson de simetría y complementariedad se distinguen dos formas: legitimación simétrica de los celos y legitimación complementaria de los celos.

En cuanto a los aspectos terapéuticos los terapeutas deben(mos) colocarse fuera del marco de los celos para poder así ayudar a la pareja a la construcción de descripciones alternativas.

SUMMARY

From a constructivist point of view, we present a way to understand and work with jealousy. Jealousy can be described as an interactive pattern, as a linguistic practice and as a narrative tradition, articulated with the macroculture.

When the individual has learned to organize, interpret and describe certain events in terms of jealousy, the language and rules tend to maintain themselves in his perception, leaning on his own post-factual justifications. In G. Bateson's categories of symmetry and complementary we distinguish two forms: symmetric legitimation and complementary legitimation of jealousy.

In therapy, therapists must stay out of the frame of reference of jealousy in order to be able to help the couple to construct alternative descriptions.

The heart of man and the bottom of the sea are unfathomable

Talmud

...pero todavía no se habían inventado los terapeutas familiares!

Comentarios Bibliográficos

JUEGOS PSICOLOGICOS PARA PAREJAS

FANNY LEVINTON
Editorial Sava Juro 1985

La autora elabora a través de un conjunto de fichas de juego-trabajo, un interesante y novedoso proceso espiralado tridimensional por medio del cual va recorriendo las principales áreas de conflicto de una pareja a la vez que investiga el origen de las dificultades para luego poner en marcha los recursos de la pareja para la resolución de las mismas.

La idea que está en la base de este método es que las personas poseen elementos naturales, muchas veces inhibidos, que se pondrán en marcha si se los estimula adecuadamente.

Además de los logros en el sentido de la mejoría, practicar estos ejercicios, puede llevar a la pareja a reconocer que sus dificultades exceden sus propios límites de acción, conduciéndola a la consulta terapéutica con mayor claridad de objetivos.

¿Por qué aprender jugando? el juego es una forma de anticipar un riesgo, de entrenarse para luego funcionar en la realidad.

Como en todo juego, aquí también hay reglas y ritmo. Se introduce así un concepto importantísimo de una manera imperceptible: el tiempo. A partir de las actividades hay un tiempo para expresarse y otro para escuchar. Un tiempo de ser adulto y otro de ser niño. Un tiempo de dar y otro de recibir. La pareja aprende isomórficamen-

te la secuencia de los acontecimientos humanos y está mucho más cerca de aceptar los ciclos vitales en los que se ve incluida y que permanentemente la lleva de un estado de equilibrio a uno de crisis y de desarrollo.

Además del reconocimiento de la dinámica temporal, otros elementos son inferidos de la ejecución de los juegos, a saber: desarrollo de estímulos, mayor información, diferenciación, identificación y ruptura de Profecías autocumplidas, inclusión del humor, detección de un punto óptimo de encuentro con el otro.

Los juegos sugeridos desarrollan diferentes objetivos, así el:

- Juego Nº 1 se refiere a la relación con las familias de origen,
- Juego Nº 2 analiza la dupla rutina-creatividad en la pareja,
- Juego Nº 3 retoma el tema de la diferenciación y la complementariedad,
- Juego Nº 4 analiza los índices de competencia traduciéndolos como enriquecimiento mutuo,
- Juego Nº 5 propone una especie de "balance" reconociendo qué se da y qué se recibe,
- Juego Nº 6 revisa la creencia de la rigidez en la distribución de las funciones conyugales,
- Juego Nº 7 estimula el reencuentro con el espacio común: la casa,
- Juego Nº 8 remarca el valor de la sexualidad como forma de relación, multifacética y enriquecedora.

El objetivo de este libro queda claramente expresado en la frase "es una técnica preventiva y de estímulo para el desarrollo, no intenta ser curativa". No obstante a

través de los logros que se obtienen en la aplicación de estos juegos el terapeuta estratégico encuentra en él una valiosa herramienta de trabajo, tanto para abrir el abanico de posibilidades de un paciente, como para entender la simiente de los conflictos merced a la riquísima información que se obtiene luego de cada tarea.

La Lic. Fanny Levinton encara, en el presente texto, una tarea nada fácil si consideramos que con lo postulado se consigue de una manera casi imperceptible y amena y en todos los casos respetuosa de la intimidad y el estilo de cada pareja, lo que les permite reflexionar sobre sí mismos sin resistencias.

Lic. Adriana Schiera de Macchioli

LA PAREJA HUMANA: RELACION Y CONFLICTO

JÜRIG WILLI
Ediciones Morata (1975)

La riqueza de esta obra, resulta difícil de sintetizar por la cantidad de aportes teóricos significativos que presenta.

El autor considera los principios funcionales que hacen al éxito de la relación conyugal; como así también, las fases del matrimonio con sus crisis típicas.

J. Willi se pregunta: ¿Qué produce los conflictos que llevan a una pareja a la consulta? Destaca, que casi siempre, la pareja presenta sus conflictos según sucesivas variantes de un único y mismo tema que forma un inconsciente común.

El juego conjunto de los cónyuges a causa de este inconsciente común, es designado como *COLUSION*. En la base de este concepto estaría la idea de concebir los

conflictos conyugales como perturbación neurótica común de los miembros de la pareja, aun cuando actúen en papeles opuestos (Complementariedad Patológica). Los consortes con perturbaciones análogas, de este modo, se impulsan recíprocamente en su comportamiento patológico, se acostumbran a un juego inconsciente. Colusión significa complicidad secreta. Lusión: Viene de ludere que junto a su significado de jugar tiene la acepción de engañar. Es un juego de a dos o más personas en el que se engañan mutuamente, aunque la pareja no lo admita. Este mecanismo da una ilusión de satisfacción que a la larga fracasa inexorablemente; marido y mujer se refuerzan mutuamente en sus comportamientos neuróticos en lugar de desarrollarse creativamente.

Dentro de este esquema se postulan cuatro temas fundamentales que pueden afectar a todo matrimonio: 1) "Amor como ser uno mismo" (colusión narcisista); 2) "Amor como preocuparse uno del otro" (colusión oral): por ejemplo el par cuidador-cuidado; 3) "Amor como pertenecerse el uno al otro" (colusión anal sádica, par dominante-dominado); 4) "Amor como afirmación masculina" (colusión fálico-edipal: vínculo activo-pasivo).

Cabe aclarar que los tipos de juegos colusivos no son categorías matrimoniales.

La pareja utiliza variados mecanismos de defensa para mantener la colusión, uno de ellos, es la intervención de terceras personas en el conflicto; otro, es desarrollar dolencias psicósomáticas en uno o ambos miembros de la díada; en ambos casos hay un cambio en la forma de la relación, ya que se desplaza la problemática de la pareja a otro punto de interés del que aparentemente ellos no son responsables; y por lo tanto se los supone inmodificables.

Para el autor el objetivo de la terapia es sacar a la pareja del estancamiento, de la colusión (recursividad), más allá de que esto salve o no al matrimonio. La terapia deberá conducir a la claridad de la relación.

Consideramos de fundamental importancia los conceptos desarrollados en este libro que brindarán a los terapeutas un marco de comprensión claro y específico de los conflictos matrimoniales, aunque no integre la influencia de otros aspectos contextuales.

Lic. María Inés Capella
Dr. Arnoldo Raúl Cortés

CONTRATO MATRIMONIAL Y TERAPIA DE PAREJA

CLIFFORD SAGER
Amorrortu Editores

Clifford Sager, psicoanalista clínico, propone en su libro el concepto de contrato matrimonial, integrando los dos determinantes de la conducta, el intrapsíquico y el interaccional.

Los cónyuges traen a la relación marital sus propios contratos, es decir sus propósitos y objetivos individuales con la esperanza de satisfacerlos en el ámbito de la pareja.

Sager diferencia los contratos en: Individuales e interaccionales. A su vez pueden tener la cualidad de ser conscientes explicitados, conscientes no expresados o inconscientes.

La congruencia de las expectativas conscientes lleva a la conformación de la pareja como tal.

La diferencia entre los contratos cons-

cientes no expresados producirá dificultades en las primeras etapas de la vida marital; por último, las incongruencias contractuales de las expectativas inconscientes originan los problemas en etapas más avanzadas de la relación.

Quizá esto se evidencie en discrepancias insignificantes que en realidad ocultan las verdaderas fuerzas dinámicas que actúan dentro de la díada.

La tesis central del libro es que las parejas que llegan a la consulta no han creado un contrato, sino que cada cual actúa como si su propio programa matrimonial fuera un pacto convenido y firmado por ambos. A esto llama el autor contratos individuales.

Sager propone una modalidad de trabajo donde el terapeuta deberá pesquisar las expectativas de los cónyuges, estimulando la explicitación de las cláusulas individuales.

Ante las divergencias existentes, ayudará a renegociar o elaborar otras pautas más aceptables.

En la medida en que las expectativas de los cónyuges se fusionen en un contrato único conocido y aceptado por ambos, cabe esperar una relación más saludable y satisfactoria.

El autor no se limita al abordaje del conflicto diádico sino también proporciona elementos para contemplar las problemáticas individuales que hacen a la etiología de la desavenencia conyugal.

Consideramos que el presente trabajo contiene un aporte nodular para orientar a los terapeutas de pareja en la maraña de información que traen los cónyuges a la consulta.

El concepto de contrato resulta así una guía en la búsqueda de datos clínicos significativos, a la vez que una valiosa herra-

través de los logros que se obtienen en la aplicación de estos juegos el terapeuta estratégico encuentra en él una valiosa herramienta de trabajo, tanto para abrir el abanico de posibilidades de un paciente, como para entender la simiente de los conflictos merced a la riquísima información que se obtiene luego de cada tarea.

La Lic. Fanny Levinton encara, en el presente texto, una tarea nada fácil si consideramos que con lo postulado se consigue de una manera casi imperceptible y amena y en todos los casos respetuosa de la intimidad y el estilo de cada pareja, lo que les permite reflexionar sobre sí mismos sin resistencias.

Lic. Adriana Schiera de Macchioli

LA PAREJA HUMANA: RELACION Y CONFLICTO

JÜRIG WILLI

Ediciones Morata (1975)

La riqueza de esta obra, resulta difícil de sintetizar por la cantidad de aportes teóricos significativos que presenta.

El autor considera los principios funcionales que hacen al éxito de la relación conyugal; como así también, las fases del matrimonio con sus crisis típicas.

J. Willi se pregunta: ¿Qué produce los conflictos que llevan a una pareja a la consulta? Destaca, que casi siempre, la pareja presenta sus conflictos según sucesivas variantes de un único y mismo tema que forma un inconsciente común.

El juego conjunto de los cónyuges a causa de este inconsciente común, es designado como *COLUSION*. En la base de este concepto estaría la idea de concebir los

conflictos conyugales como perturbación neurótica común de los miembros de la pareja, aun cuando actúen en papeles opuestos (Complementariedad Patológica). Los consortes con perturbaciones análogas, de este modo, se impulsan recíprocamente en su comportamiento patológico, se acostumbra a un juego inconsciente. Colusión significa complicidad secreta. Lusión: Viene de ludere que junto a su significado de jugar tiene la acepción de engañar. Es un juego de a dos o más personas en el que se engañan mutuamente, aunque la pareja no lo admita. Este mecanismo da una ilusión de satisfacción que a la larga fracasa inexorablemente; marido y mujer se refuerzan mutuamente en sus comportamientos neuróticos en lugar de desarrollarse creativamente.

Dentro de este esquema se postulan cuatro temas fundamentales que pueden afectar a todo matrimonio: 1) "Amor como ser uno mismo". (colusión narcisista); 2) "Amor como preocuparse uno del otro" (colusión oral): por ejemplo el par cuidador-cuidado; 3) "Amor como pertenecerse el uno al otro" (colusión anal sádica, par dominante-dominado); 4) "Amor como afirmación masculina" (colusión fálico-edipal: vínculo activo-pasivo).

Cabe aclarar que los tipos de juegos colusivos no son categorías matrimoniales.

La pareja utiliza variados mecanismos de defensa para mantener la colusión, uno de ellos, es la intervención de terceras personas en el conflicto; otro, es desarrollar dolencias psicosomáticas en uno o ambos miembros de la díada; en ambos casos hay un cambio en la forma de la relación, ya que se desplaza la problemática de la pareja a otro punto de interés del que aparentemente ellos no son responsables; y por lo tanto se los supone inmodificables.

Para el autor el objetivo de la terapia es sacar a la pareja del estancamiento, de la colusión (recursividad), más allá de que esto salve o no al matrimonio. La terapia deberá conducir a la claridad de la relación.

Consideramos de fundamental importancia los conceptos desarrollados en este libro que brindarán a los terapeutas un marco de comprensión claro y específico de los conflictos matrimoniales, aunque no integre la influencia de otros aspectos contextuales.

Lic. María Inés Capella
Dr. Arnoldo Raúl Cortés

CONTRATO MATRIMONIAL Y TERAPIA DE PAREJA

CLIFFORD SAGER
Amorrortu Editores

Clifford Sager, psicoanalista clínico, propone en su libro el concepto de contrato matrimonial, integrando los dos determinantes de la conducta, el intrapsíquico y el interaccional.

Los cónyuges traen a la relación marital sus propios contratos, es decir sus propósitos y objetivos individuales con la esperanza de satisfacerlos en el ámbito de la pareja.

Sager diferencia los contratos en: Individuales e interaccionales. A su vez pueden tener la cualidad de ser conscientes explícitos, conscientes no expresados o inconscientes.

La congruencia de las expectativas conscientes lleva a la conformación de la pareja como tal.

La diferencia entre los contratos cons-

cientes no expresados producirá dificultades en las primeras etapas de la vida marital; por último, las incongruencias contractuales de las expectativas inconscientes originan los problemas en etapas más avanzadas de la relación.

Quizá esto se evidencie en discrepancias insignificantes que en realidad ocultan las verdaderas fuerzas dinámicas que actúan dentro de la díada.

La tesis central del libro es que las parejas que llegan a la consulta no han creado un contrato, sino que cada cual actúa como si su propio programa matrimonial fuera un pacto convenido y firmado por ambos. A esto llama el autor contratos individuales.

Sager propone una modalidad de trabajo donde el terapeuta deberá pesquisar las expectativas de los cónyuges, estimulando la explicitación de las cláusulas individuales.

Ante las divergencias existentes, ayudará a renegociar o elaborar otras pautas más aceptables.

En la medida en que las expectativas de los cónyuges se fusionen en un contrato único conocido y aceptado por ambos, cabe esperar una relación más saludable y satisfactoria.

El autor no se limita al abordaje del conflicto diádico sino también proporciona elementos para contemplar las problemáticas individuales que hacen a la etiología de la desavenencia conyugal.

Consideramos que el presente trabajo contiene un aporte nodular para orientar a los terapeutas de pareja en la maraña de información que traen los cónyuges a la consulta.

El concepto de contrato resulta así una guía en la búsqueda de datos clínicos significativos, a la vez que una valiosa herra-

mienta de esclarecimiento a lo largo de la tarea en la que los miembros de la pareja toman conciencia del otro como así también de las propias expectativas y necesidades.

Al recorrer este camino los integrantes del matrimonio abandonarán progresivamente la posición narcisista.

Lic. Alberto Fiszbejn
Dr. Arnoldo Cortés

CLINICAL HANDBOOK OF MARITAL THERAPY

Edited by NEIL S. JACOBSON and
ALAN S. GURMAN
Guildford Press NY 1985

Los autores destacan el avance que significa, en el campo de la terapia de pareja, pasar del estado de una "técnica en búsqueda de teoría" a poder presentar diferentes y coherentes modelos para el conocimiento de la interacción marital, su disfunción y cambio. Señalan que la terapia de pareja ha ido desarrollando en los últimos años sus propios supuestos acerca de los problemas relacionales y las estrategias clínicas para su tratamiento.

Esta obra brinda un amplio panorama que va desde los desarrollos teóricos —modelos mayores— hasta modelos diseñados para la intervención. Estos se orientan a cuestiones tan centrales como: prevención, medicina familiar, mediación en divorcio y terapia grupal de pareja.

En su parte III ofrecen un repertorio muy preciso de problemas específicos: terapia de separación; re-matrimonio; disfunciones sexuales; violencia marital; entrecruzamiento cultural, etc.

En su parte IV desarrollan las posibilidades de aplicación de la terapia de pareja, en lo que denominan: "desórdenes psiquiátricos": fobias; depresión; alcoholismo; esquizofrenia; trastornos narcisísticos y trastornos de la alimentación.

Finalmente, abordan dos temas muy poco tratados y fundamentales para este campo como son: la efectividad de la terapia marital y cuestiones éticas de la terapia de pareja.

Psic. Alberto González

CASEBOOK OF MARITAL THERAPY

Edited by ALAN S. GURMAN
University of Wisconsin Medical
School 1985

Esta obra constituye una excelente exposición de una amplia gama de problemas típicos y situaciones claves en la terapia de pareja.

- Distancia.
- Problemas sexuales.
- Infidelidad.
- Desconfianza.
- Problemas con miembros de la familia extensa.

Este desarrollo se presenta por medio de un detallado informe de catorce casos que incluyen terapias breves y terapias prolongadas como asimismo la aplicación de los abordajes: interaccional; intergeneracional e intrapsíquico.

Es fácil de apreciar que se trata de un texto útil y original que puede satisfacer una importante necesidad de los terapeutas de pareja.

Psic. Alberto González

"PSICOANÁLISIS DE LA PAREJA MATRIMONIAL"

ISIDORO BERENSTEIN
JANINE PUGET

INTRODUCCION

Comenzaré comentando el título de la obra. Hablar del "psicoanálisis para más de uno" significa ya un cambio y un aporte a la teoría que este título anticipa y que por cierto cubre ampliamente.

Desfilan en éste los conceptos pilares y articuladores del psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica: transferencia, complejo de Edipo, asociación libre, narcisismo por nombrar algunos. En este sentido este texto organiza un espacio singular para el psicoanálisis, lo que habitualmente en medicina suele llamarse "especialización". Y para esta especialización no sólo utilizan términos y conceptos psicoanalíticos clásicos sino que producen a través de importantes espirales teóricas otros nuevos de cuño propio que como siempre sucede en la historia de la ciencia, pasan rápidamente a ser éstos también conceptos clásicos del psicoanálisis de pareja matrimonial. Pero este pasaje de lo nuevo a lo clásico no es automático, es producido de años de esfuerzo teórico y clínico y esta obra es efecto de ello.

DESARROLLO

Desde los comienzos la obra recurre al concepto de "estructura" tomado de Seausure y retomado por Levi Strauss aportan-

do las características propias del tema. Definen luego su objeto de estudio, la pareja, a la cual discriminan a través del uso de ciertos parámetros —cotidianeidad, proyecto vital compartido, relaciones sexuales y tendencia monogámica— de otras relaciones diádicas como las de amantes y amigos.

Una distinción interesante que hacen los autores, con lo cual abren y potencializan una técnica para dichos tratamientos es entre relación objetal y vínculo que los lleva a formular los conceptos de intra e intersubjetivo respectivamente.

Es así que postulan la presencia de "...un conector como condición necesaria para explicar porqué dos personas mantienen establemente una relación de pareja...". Este conector es el soporte por el cual se vehiculizan los intercambios patognomónicos de las relaciones humanas: palabras, bienes y productos al cual los autores le agregan el intercambio sexual. Pero para estos intercambios las parejas "acuerdan" y "pactan", como así también lo hacen para lo no intercambiable. Otro feliz concepto de los autores: "acuerdos inconscientes" —como no todas las parejas hacen los mismos "acuerdos y pactos" esto además las diferencia—. Surgen entonces una tipología de los vínculos basada en estas ideas. Esto les permite a los autores desarrollar una tipología diferente a la clásica de neurosis, psicosis, etc., proveniente del psicoanálisis individual. Estos "tipos" van desde una fusión indiscriminada de sus miembros hacia un aumento de la discriminación y apertura del vínculo que permite la inclusión/exclusión de un tercero. Pero dado que la alianza viene marcada desde la cultura estas tipologías llevan su marca. Destacamos este aspecto porque los autores incluyen en este texto la transubje-

tividad. Un ejemplo de ello es la Estructura cero.

En la inclusión de la corporeidad en el vínculo conyugal también los autores utilizan organizadores que van de un menor a un mayor grado de complejización. Aquí también producen un nuevo concepto, "cuerpo vincular" que unifica la representación corporal de la pareja con el concepto de "zona erógena" y ésta es pensada como el "resultado de una actividad vincular que guarda una marca corporal de una situación originaria". La mirada es asimismo incluida en este "cuerpo vincular" y es considerada no sólo como estructurante del sujeto sino del vínculo de pareja. Si en este capítulo se refieren los autores al intercambio de la corporeidad en el siguiente lo hacen refiriéndose al intercambio de palabras. Lugar donde la pareja busca narcisísticamente un diálogo basado en un entendimiento total imaginario. Réplica éste de relaciones tempranas. La persistencia de este imaginario genera interferencias. Un modelo de interferencia que es estudiado exhaustivamente es el "malentendido" al que diferencian como malentendido por exceso y malentendido por omisión. Es interesante las diferenciaciones que hacen del mismo para la clínica dado que dentro del "malentendido" se encuentra uno de los típicos motivos de consulta. Ejemplifican a éste con la obra clásica de A. Camus: "El malentendido". El capítulo siguiente se refiere a la "Significación del conflicto matrimonial en el análisis de pareja y en el análisis individual". Diferencian el "conflicto" del "relato del conflicto". Esta distinción es fundamental dado que el relato del conflicto ocupa un lugar de "vía regia" para el análisis de la pareja. Se basan para el análisis del relato en los desarrollos de Kaës sobre la "cadena asociativa grupal"

que les permite ampliar el concepto de asociación libre del contexto bipersonal. Desde allí pueden pensar en las concordancias o discordancias de la actividad fantasmática que determinará los diferentes encuadres analíticos es decir la indicación del tratamiento adecuado. Otro elemento característico utilizado por los autores para la indicación, diferenciación y significación del conflicto es el compromiso y la capacidad transferencial del/los pacientes. La capacidad de apertura del pensamiento científico de los autores les permite discriminar c/u de los diferentes encuadres terapéuticos adjudicándole a c/u sus alcances pero también sus límites, "cada encuadre configura un código y un límite". En el siguiente capítulo referido a la transferencia es interesante la ampliación que hacen de éste concepto al referido a lo tripersonal del campo de pareja. Mencionan para ello "el clima" como resultante de las "transferencias intrasubjetivas individuales" asociadas a las "transferencias vinculares". Este "clima" es el que da cuenta de la situación emocional vincular que funciona como sostén de ciertas interacciones resignificándolas. Luego son desarrollados las distintas alternativas de las transferencias vinculares: espacio, tiempo, representaciones socio-culturales y los parámetros configuradores del vínculo conyugal: cotidianeidad, proyecto vital, sexualidad y tendencia monogémica. El manejo de éste campo vincular posee aristas características que lo enfrentan al psicoanalista de pareja desde su contratransferencia para lo cual los autores, a sabiendas de que puede ser éste "un punto de ardua discusión" sugieren el psicoanálisis de pareja para los profesionales interesados en dicha especialidad dado que ésta tarea moviliza en él no sólo aquellos aspectos que hacen a su vida

de pareja sino que al estar ésta atravesada por valores socioculturales es fácil el deslizamiento hacia un campo valorativo e ideológico. El último capítulo que cierra el libro es uno de los conceptos estructurales más importantes del desarrollo del texto: El zócalo inconsciente. Si bien está en último lugar atraviesa todo el texto. Este como "estructura relacional profunda" es reguladora de las interacciones de vínculo. En éste zócalo se encuentran representados el narcisismo —que es desarrollado en la relación de objeto único—, el complejo de Edipo —desarrollado como estructura de cuatro términos—, y los acuerdos sociales que inscriben a la relación de alianza en la cultura.

Freud dice "...hasta ahora hemos dejado en manos de los poetas pintarnos las "condiciones de amor" bajo las cuáles los

seres humanos eligen su objeto y el modo en que ellos concilian los requerimientos de su fantasía con la realidad..." (El subrayado es nuestro).

El Dr. Berenstein y la Dra. Puget retoman en sus manos ésta metapsicología del amor. Metapsicología que se despliega en todas sus condiciones posibles: desde el amor materno/paterno familiar y endogámico hasta el amor en la pareja humana que lleva la marca del anterior y la creatividad de algo nuevo pero que siempre será alianza inscripto y transcripto por la cultura. Pero, no lo hacen con "las toscas manos de la ciencia" como dice Freud sino con el cuidado y la creatividad que en su praxis los caracteriza.

Lic. Esther Victoria Czernikowski

Las traducciones fueron realizadas por: Lic. Fanny Levinton-Baranchuk, Dra. Evelina Costa, Lic. Inés Dates, Psic. L. Olga Benzadon González



FUNDACION ECOSISTEMAS HUMANOS

Corrientes 2835. Cuerpo A,
6º Dto. A (1193) Buenos Aires
Argentina. Tel. 961-8285
Telex: 18040 CONFER AR
FAX: 331-9724

INVESTIGACION APLICADA A LA PROBLEMÁTICA FAMILIAR ENFOQUE ECOLÓGICO INTERDISCIPLINARIO PROYECTOS EN CURSO

- * El enfermo orgánico y su familia
- * La Persona en la Pareja
- * Tratamiento familiar de la enuresis
- * Ecología del Divorcio Destructivo
- * Servicio de Apoyo a la familia en crisis
- * Transculturación: tejiendo una nueva red.

EXTENSION A LA COMUNIDAD OTOÑO-INVIERNO 1990

CAPACITACION

Abordaje ecológico del Divorcio. Un modelo específico. Para Terapeutas. Jueves de 14 a 16 hs.

Visión contextual de la Familia en el Sistema Judicial. Para abogados, asistentes sociales y psicólogos de dicho ámbito. Martes de 18 a 20 hs.

Manejo del Desaliento en el trabajo con enfermos crónicos. Para agentes de Salud. 3º Martes de c/ mes.

La Terapia de pareja y las ideas sobre la pareja ideal. Lunes de 13.30 a 15 hs.

De la amable rutina al Hastío Mortal. Entrenamiento en Terapia de Parej. Jueves de 14 a 16 hs.

Problemas de Aprendizaje en el contexto familiar. Lunes de 17 a 19 hs.

Cuando el Sistema es una Persona. Teoría y Práctica de la Terapia Individual. Miércoles de 14 a 16 hs.

Supervisiones Individuales y grupales interdisciplinarias.

Training intensivos para aspirantes del interior.

*Lic. Marta Albarracín, Lic. Mónica Berjman, Lic. Silvia Galay de Lestard,
Lic. Haydée Oks, Lic. Malena Reti, Lic. Marta Zeitune*

TALLERES

Matrimonio Sociedad de Responsabilidad Compartida. Los 3 primeros miércoles de cada mes.

Pequeños tiranos. Talleres para Padres.

ASISTENCIA

Intervención en situaciones de crisis familiar.

Asistencia dirigida a la problemática propia de cada proyecto.

SISTEMAS DE AUTOAYUDA

- Divorciados y sus hijos
- Mujeres solas.
- Personas en proceso de Migración
- Violencia Doméstica
- Matrimonio

DIFUSION

Colaboración en prevención a través de mass-media

Paneles interdisciplinarios mensuales. Ultimo miércoles de cada mes. 20 hs.

PEDIDOS DE INFORMACION O ASESORAMIENTO: Para entrevista telefónica o para solicitar entrevista personal llamar al 961-8285 de lunes a viernes entre las 10.00 y las 18.00 horas.

TERAPIA FAMILIAR

Próximos números

1990

TERAPIAS BREVES

Editores invitados:

Lic. Celia Elzufán

Lic. Hugo Hirsch

FAMILIA SANA Y PREVENCION

Editora invitada:

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk

Los autores interesados en algunos de estos temas pueden enviar sus artículos a la Secretaría de la Revista según las "Instrucciones para los autores"

**PARA PUBLICIDAD EN ESTA REVISTA
DIRIGIRSE POR CARTA A:
C.C. Nro. 94 - Sucursal 28
(1428) Buenos Aires - ARGENTINA**

Instrucciones para los autores

La Revista TERAPIA FAMILIAR publica dos números por año, es multidisciplinaria en el área de la familia con especial énfasis en la salud mental. Tiene como objetivo incrementar el conocimiento profesional de la problemática de la familia para mejorar la calidad de ayuda que la familia requiere.

Los trabajos son seleccionados sobre las bases de objetivos, claridad y contribución al área de la familia.

ARTICULOS

—Los originales, por triplicado, deberán ser enviados al Director de la Revista. Dr. Alfredo Canevaro, Echeverría 1945, PB, 1428 Capital Federal, República Argentina.

—La responsabilidad del contenido de los trabajos es del autor.

—No se pagan honorarios por los trabajos aceptados.

—El editor se reserva el derecho de rechazar trabajos, devolverlos al autor para alguna modificación de forma o someterlos a corrección de estilo.

—Los trabajos se deben presentar con un original y dos copias; escritas a máquina y a doble espacio e incluir un resumen lo más conciso posible, así como su traducción en inglés para su envío a re-

vistas internacionales. Las tablas y gráficos que acompañen el trabajo deben ser claros a fin de permitir la máxima calidad de la reproducción fotomecánica.

—Incluir nombre completo de (los) autor (es), título profesional, dirección e institución a la que pertenece.

—Bibliografía: Las referencias bibliográficas deben ceñirse a las normas internacionales: 1) Ordenadas alfabéticamente y numeradas correlativamente según su orden de aparición. 2) Nombre completo del autor o de todos los autores, en caso de ser varios. 3) Título completo del trabajo citado. 4) Nombre abreviado de la Revista según Index Medicus (si el tema es médico). Número de Volúmen o Volúmenes: referencia de primera y última página (en este orden), ciudad, editorial, año de publicación.

Ejemplos:

ASHYBY, W. R. Introducción a la Cibernética (1956). Bs. Aires. Ed. Paidós, 1972.

o

RUDRAUF, J. Ensayos sobre la dialéctica de los niveles de comunicación en la intervención terapéutica. TERAPIA FAMILIAR. 1980. Vol. IV N° 7/8, págs. 87-98. Buenos Aires. Argentina.

—Los autores de los trabajos publicados recibirán un ejemplar de la Revista.

—Los artículos deberán ser inéditos en lengua española.

Ficha de suscripción

Nros. 21 y 22

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección

Código Postal..... Localidad

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Ediciones A.C.E., No a la Orden.

DIRECCION: C.C. N° 94 - Sucursal 28 - Buenos Aires - Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION Nros. 21 y 22

ARGENTINA: Solicitar precio por carta.

EXTERIOR: U\$S 30.-

GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS

SECRETARIA E INFORMES
DE LA REVISTA
TERAPIA FAMILIAR:
C.C. 94, Suc. 28, (1428) Bs. As.,
Argentina